



Buku Ajar

KB DAN PELAYANAN

Machfudloh • Hardiningsih • Asridawati Akib
Lely Khulafa'ur Rosidah • Dhiah Dwi Kusumawati
Nurul Lidya



BUKU AJAR KB DAN PELAYANAN

Penulis:

Machfudloh, S.SiT., MH.Kes., M.Keb.

Hardiningsih, SST., M.Kes.

Asridawati Akib, S.ST., M.Keb.

Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes.

Dhiah Dwi Kusumawati, S. ST., Bdn., MPH.

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.



BUKU AJAR KB DAN PELAYANAN

Penulis: Machfudloh, S.SiT., MH.Kes., M.Keb.

Hardiningsih, SST., M.Kes.

Asridawati Akib, S.ST., M.Keb.

Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes.

Dhiah Dwi Kusumawati, S. ST., Bdn., MPH.

Bdn. Nurul Lidya, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah, S.Pd

ISBN: 978-623-89992-4-8

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ajar berjudul "KB dan Pelayanan" ini dapat tersusun dengan baik dan hadir di tangan pembaca. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang ingin mendalami konsep keluarga berencana (KB) dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah.

Keluarga Berencana (KB) merupakan program strategis dalam pembangunan nasional yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan KB sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar KB, metode kontrasepsi yang tersedia, pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional, serta kemampuan komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi setiap praktisi kesehatan.

Buku ajar ini disusun secara sistematis dengan pendekatan teoritis dan praktis agar mudah dipahami dan diaplikasikan oleh pembaca, terutama para mahasiswa dan tenaga kesehatan di bidang kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan kedokteran. Setiap bab di dalamnya dikembangkan dengan mempertimbangkan relevansi materi dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, dilengkapi dengan berbagai kasus praktik yang representatif, serta dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar untuk memudahkan pemahaman.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar keluarga berencana, berbagai metode kontrasepsi modern dan tradisional, prinsip-prinsip konseling dalam KB, aspek etika dan hukum dalam pelayanan KB, serta tantangan-tantangan terkini dalam pelaksanaan program KB. Dengan cakupan materi yang komprehensif tersebut, diharapkan pembaca tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan KB yang profesional, humanis, dan sesuai standar nasional maupun internasional.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan buku ini di masa depan. Harapan kami, buku ajar ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi di Indonesia.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, mulai dari pengumpulan materi, penulisan, hingga penerbitan. Semoga buku ini memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat luas.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 JENIS METODE KONTRASEPSI DAN MEKANISME KERJA KONTRASEPSI HORMONAL DAN NON HORMONAL	1
A. Kontrasepsi Hormonal.....	3
B. Kontrasepsi Non Hormonal.....	10
C. Latihan Soal	17
D. Rangkuman Materi	18
E. Glosarium.....	19
F. Daftar Pustaka.....	20
BAB 2 EFEK SAMPING ATAU PENYULIT KONTRASEPSI HORMONAL DAN NON HORMONAL	21
A. Efek Samping/ Penyulit Kontrasepsi Hormonal	22
B. Kontrasepsi Non Hormonal.....	31
C. Latihan Soal	36
D. Rangkuman Materi	37
E. Glosarium.....	37
F. Daftar Pustaka.....	38
BAB 3 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BER-KB	41
A. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Ber-KB	43
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan.....	44
C. Langkah-Langkah dalam Pengambilan Keputusan	47
D. Teknik Komunikasi dan Konseling dalam Ber-KB.....	50
E. Implikasi Keputusan KB.....	52
F. Latihan Soal	55
G. Rangkuman Materi	57
H. Glosarium.....	58
I. Daftar Pustaka.....	61

BAB 4 UPAYA-UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF TERKAIT DENGAN PERENCANAAN KELUARGA DAN KONTRASEPSI.....63

A. Upaya Promotif dalam Perencanaan Keluarga dan Kontrasepsi	65
B. Upaya Preventif dalam Perencanaan Keluarga dan Kontrasepsi	66
C. Strategi Promotif yang Efektif	68
D. Strategi Preventif yang Efektif.....	70
E. Hambatan dan Solusi dalam Upaya Promotif dan Preventif.....	72
F. Latihan Soal	75
G. Rangkuman Materi	77
H. Glosarium.....	78
I. Daftar Pustaka.....	81

BAB 5 KONSELING KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN, DAN KONTRASEPSI DARURAT.....83

A. Konsep Konseling Kontrasepsi.....	86
B. Konseling dengan Metode sederhana / Tradisional.....	92
C. Konseling dengan Metode Alami	94
D. Konseling dengan Metode Modern (Hormonal dan Non Hormonal)	96
E. Konseling Kontrasepsi Darurat	97
F. Latihan Soal	99
G. Rangkuman Materi	100
H. Glosarium.....	101
I. Daftar Pustaka.....	101

BAB 6 MEMBUAT PERMINTAAN OBAT KONTRASEPSI DARURAT, MENYIMPAN DAN MEMBERIKAN KONTRASEPSI DARURAT SESUAI KEWENANGAN, KEBIJAKAN LOKAL, PROTOKOL, PERATURAN DAN HUKUM103

A. Konsep Dasar Kontrasepsi Darurat (Kondar).....	105
B. Penyimpanan dan pemberian Kontrasepsi Darurat (Kondar)	107
C. Pengawasan dan Edukasi Pasca Kontrasepsi Darurat (Kondar).....	109
D. Kebijakan Lokal Kontrasepsi darurat (Kondar)	109
E. Protokol Kontrasepsi Darurat (Kondar)	110
F. Peraturan dan Hukum Kontrasepsi Darurat (Kondar).....	111
G. Latihan Soal	111
H. Rangkuman Materi	113
I. Glosarium.....	114

J. Daftar Pustaka.....	114
BAB 7 TREND DAN ISSUE PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	117
A. Trend Dalam Pelayanan Keluarga Berencana	119
B. Issue Pelayanan Keluarga Berencana	121
C. Trend Dan Issue Dalam Kesehatan Reproduksi	124
D. Latihan Soal	127
E. Rangkuman Materi	129
F. Glosarium.....	130
G. Daftar Pustaka.....	130
BAB 8 MEMBERIKAN PELAYANAN KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN, DAN KONTRASEPSI DARURAT. PELAYANAN KONTRASEPSI PASCA ABORSI (KONDOM, PIL, SUNTIK),	133
A. Pelayanan Kontrasepsi dengan Metode Sederhana, Modern, dan Kontrasepsi Darurat.....	136
B. Pelayanan kontrasepsi pasca aborsi (Kondom, Pil, Suntik)	148
C. Latihan Soal	163
D. Rangkuman Materi	166
E. Glosarium.....	167
F. Daftar Pustaka.....	168
PROFIL PENULIS	171

BAB 1

JENIS METODE KONTRASEPSI DAN MEKANISME KERJA KONTRASEPSI HORMONAL DAN NON HORMONAL

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Jenis Kontrasepsi Hormonal
- Menjelaskan Mekanisme Kerja Kontrasepsi Hormonal
- Menjelaskan Jenis Kontrasepsi Non Hormonal
- Menjelaskan Mekanisme Kerja Kontrasepsi Non Hormonal

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan tentang jenis-jenis kontrasepsi hormonal
- Mampu menjelaskan tentang mekanisme kerja kontrasepsi hormonal
- Mampu menjelaskan tentang jenis kontrasepsi non hormonal
- Mampu menjelaskan tentang mekanisme kerja kontrasepsi non hormonal

Pendahuluan

Pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks kesehatan reproduksi, pemilihan metode kontrasepsi yang tepat menjadi langkah strategis untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, menjaga jarak antar kehamilan, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Secara umum, metode kontrasepsi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu alat kontrasepsi hormonal dan alat kontrasepsi non-hormonal. Keduanya memiliki mekanisme kerja, keunggulan, serta pertimbangan penggunaan yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami karakteristik masing-masing agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi individu.

Alat kontrasepsi hormonal bekerja dengan mengatur sistem hormonal tubuh untuk mencegah ovulasi, menebalkan lendir serviks, dan mengubah lapisan endometrium. Jenis-jenisnya mencakup pil kombinasi, pil progestin, suntikan dan implan. Metode ini dikenal karena efektivitasnya yang tinggi, namun juga memerlukan perhatian terhadap kemungkinan efek samping dan kontraindikasi medis tertentu.

Sementara itu, alat kontrasepsi non-hormonal tidak mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh secara langsung. Metode ini meliputi penggunaan kondom, diafragma, IUD non-hormonal (tembaga), metode alami (seperti pantang berkala dan lendir serviks), serta kontrasepsi mantap (MOW/ MOP). Meskipun secara umum memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi, metode non-hormonal sering menjadi pilihan bagi individu yang tidak dapat atau tidak ingin menggunakan kontrasepsi berbasis hormon.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kedua jenis alat kontrasepsi tersebut. Materi disajikan secara sistematis, mencakup jenis dan mekanisme kerjanya. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

A. Kontrasepsi Hormonal

1. Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK)

Pemilihan kontrasepsi pil banyak diminati karena kontrasepsi pil lebih mudah didapatkan dan praktik dalam penggunaannya serta adanya perasaan nyaman dan cocok dari akseptor kontrasepsi pil. Akseptor kontrasepsi pil merasa takut dengan kontrasepsi yang lain salah satunya adalah kontrasepsi suntik dikarenakan trauma pada suntikan dan rasa takut pasangan usia subur (PUS) dalam menggunakan metode alat kontrasepsi dengan metode MKJP dikarenakan banyak mitos-mitos yang beredar bahwa kontrasepsi lain akan banyak mengalami efek samping (Velinda et al., 2022).

a. Definisi

Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK) adalah kontrasepsi pil yang mengandung 2 macam hormon yang berdosisi rendah yaitu progestin dan estrogen seperti hormon progesterone dan estrogen alami pada tubuh Perempuan, yang harus diminum setiap hari (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Jenis

Menurut Direktorat Kesehatan Keluarga (2021) jenis kontrasepsi pil kombinasi yaitu:

1) Monofasik

Pil yang mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam dosis yang sama, macamnya antara lain:

- a) 21 pil mengandung 30 µg Ethynil Estradiol (EE)/ 150 µg Levonorgestrel (LNG) dan 7 pil tanpa hormon (merupakan KPK yang disediakan pemerintah)
- b) 21 pil mengandung 30 µg EE/ 3000 µg Drospirenone dan 7 pil tanpa hormon
- c) 24 pil mengandung 30 µg EE/ 2000 µg Drospirenone dan 4 pil tanpa hormon

2) Bifasik

Pil yang mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam dua dosis yang berbeda. Macamnya antara lain: 21 pil mengandung 0,02 mg EE/ 0,15 mg Desogestrel, 5 pil mengandung 0,01 mg EE dan 2 pil tanpa hormon.

3) Trifasik

Pil yang mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam tiga dosis yang berbeda. Macamnya antara lain:

- a) 7 pil mengandung 0,035 µg EE/ 0,5 mg Norethindrone, 7 pil mengandung 0,035 mg EE/ 0,75 mg Norethindrone, 7 pil mengandung 0,035 mg EE/ 1 mg Norethindrone dan 7 pil tanpa hormon
 - b) 7 pil mengandung 0,025 mg EE/ 0,100 mg Desogestrel, 7 pil mengandung 0,025 mg EE/ 0,125 mg Desogestrel, 7 pil mengandung 0,025 mg EE/ 0,150 mg Desogestrel dan 7 pil tanpa hormon
- 4) Kuadrifasik
- Pil yang mengandung hormon aktif estrogen/ progestin dalam empat dosis yang berbeda. Macamnya antara lain: 2 pil mengandung 3 mg Estradiol Valerate, 5 pil mengandung 2 mg Estradiol Valerate/ 3 mg Dienogest, 17 pil mengandung 2 mg Estradiol Valerate/ 3 mg Dienogest, 2 pil mengandung 1 mg Estradiol Valerate dan 2 pil tanpa hormon.
- c. Mekanisme Kerja
- Mekanisme kerja kontrasepsi pil kombinasi menurut Matahari et al (2018) yaitu:
- 1) Menekan ovulasi
 - 2) Mencegah implantasi
 - 3) Mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma
 - 4) Mengganggu pergerakan tuba sehingga transportasi ovum terganggu
- d. Efektivitas
- Bila digunakan secara benar (diminum setiap hari di waktu yang sama) maka risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Matahari et al., 2018).
- e. Keuntungan
- 1) Pemakaiannya dikendalikan oleh perempuan
 - 2) Dapat dihentikan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan
 - 3) Tidak mengganggu hubungan seksual
 - 4) Mudah digunakan dan mudah didapat
 - 5) Tidak mengganggu hubungan seksual
 - 6) Banyaknya darah haid berkurang (mencegah anemia)
 - 7) Tidak terjadi haid
 - 8) Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan
 - 9) Membantu mencegah kanker endometrium, kanker ovarium, kista ovarium, penyakit radang panggul dan anemia defisiensi besi
 - 10) Mengurangi nyeri haid, nyeri ovulasi dan masalah perdarahan menstruasi dan jerawat.
- (Matahari et al., 2018).

- f. Keterbatasan: relatif mahal dan harus digunakan tiap hari serta mengurangi ASI pada perempuan menyusui (Matahari et al., 2018).

2. Kontrasepsi Pil Progestin (KPP/ Mini Pil)

a. Definisi

Kontrasepsi Pil Progestin adalah pil yang mengandung progestin saja dengan dosis yang sangat rendah seperti hormon progesterone alami pada tubuh perempuan (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Jenis

Jenis kontrasepsi pil progestin antara lain:

- 1) Kemasan 28 pil berisi Lynestrenol 0,5 mg (Kontrasepsi pil progestin yang disediakan Pemerintah)
- 2) Kemasan 28 pil berisi 75 µg norgestrel
- 3) Kemasan 35 pil berisi 300 µg levonorgestrel atau 350 µg norethindrone (Matahari et al., 2018).

c. Mekanisme kerja

- 1) Menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium
- 2) Endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit
- 3) Mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma
- 4) Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu (Matahari et al., 2018).

d. Efektivitas

Bila digunakan secara benar (diminum setiap hari di waktu yang sama) maka risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Matahari et al., 2018).

e. Keuntungan

- 1) Dapat diminum saat menyusui
- 2) Pemakaiannya dikendalikan oleh perempuan
- 3) Dapat dihentikan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan
- 4) Tidak mengganggu hubungan seksual
- 5) Mengurangi nyeri haid dan jumlah perdarahan haid (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

f. Keterbatasan

- 1) Harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama, bila lupa satu pil saja maka kegagalan menjadi lebih besar
- 2) Peningkatan/ penurunan berat badan (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

3. Pil KB Darurat (Kontrasepsi Darurat)

a. Definisi

Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah senggama tanpa pelindung atau tanpa pemakaian kontrasepsi yang tepat dan konsisten sebelumnya (Matahari et al., 2018).

b. Indikasi pemakaian kontrasepsi darurat

- 1) Perkosaan
 - 2) Senggama tanpa menggunakan kontrasepsi
 - 3) Pemakaian kontrasepsi tidak benar atau tidak konsisten:
 - a) Kondom bocor, lepas atau salah penggunaannya
 - b) Diafragma pecah, robek, atau diangkat terlalu cepat
 - c) Senggama terputus gagal dilakukan sehingga ejakulasi terjadi di vagina atau genitalia eksternal
 - d) Salah menghitung masa subur
 - e) IUD ekspulsi
 - f) Lupa minum pil KB lebih dari 2 tablet
 - g) Terlambat suntik progestin lebih dari 2 minggu atau terlambat suntik kombinasi lebih dari 7 hari
- (Matahari et al., 2018).

c. Efektivitas: sangat efektif dengan tingkat kehamilan <3%. Bersifat sementara dan tidak untuk digunakan secara rutin (Matahari et al., 2018).

d. Efek samping : mual, muntah (bila terjadi dalam 2 jam pertama setelah minum pil pertama atau kedua maka berikan dosis ulangan), perdarahan bercak (Matahari et al., 2018).

e. Jenis Kontrasepsi Darurat

Tabel 3.1 Jenis Kontrasepsi Darurat

Cara	Komposisi	Merk Dagang	Dosis	Waktu Pemberian
AKDR-Cu		Copper T Multiload Nova T	Satu kali pemasangan	Dalam waktu 5 hari pasca senggama
Pil Kombinasi dosis tinggi	0,05 mg Etinil estradiol + 0,25 mg levonorgestrel	Microgynon 50 Ovral Neogynon Norgiol Eugynon	2 x 2 tablet	Dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua diminum 12 jam kemudian

Pil kombinasi dosis rendah	0,03 mg etinil estradiol + 0,15 mg levonorgestrel	Microgynon 30 Mikrodiol Nordette	2 x 4 tablet	Dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua diminum 12 jam kemudian
Progestin	1,5 mg levonorgestrel	Postinor	2 x 1 tablet	Dalam waktu 3 hari pasca senggama, dosis kedua diminum 12 jam kemudian

Sumber : (Matahari et al., 2018).

4. Kontrasepsi Suntik Kombinasi (KSK)

a. Definisi

Merupakan kontrasepsi suntik kombinasi yang mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen, seperti hormon progesterone dan estrogen alami pada tubuh perempuan (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Jenis Kontrasepsi Suntik Kombinasi

KSK yang mengandung 2 hormon yaitu Medroxyprogesterone Acetate (MPA)/ Estradiol Cypionate yang disediakan pemerintah yaitu:

- 1) Suntikan 1 bulan sekali: mengandung Medroxyprogesterone Acetate 50 mg/ml dan Estradiol Cypionate 10 mg/ml
 - 2) Suntikan 2 bulan sekali: mengandung Medroxyprogesterone Acetate 60 mg/ml dan Estradiol Cypionate 7,5 mg/ml
 - 3) Suntikan 3 bulan sekali: mengandung Medroxyprogesterone Acetate 120 mg/ml dan Estradiol Cypionate 10 mg/ml
- (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

c. Mekanisme Kerja

- 1) Menekan ovulasi
 - 2) Mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu
 - 3) Atrofi pada endometrium sehingga implantasi terganggu
 - 4) Menghambat transportasi gamet oleh tuba
- (Harnani et al., 2022)

d. Efektivitas

Bila digunakan secara benar maka risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021)

- e. Keuntungan
 - 1) Tidak perlu diminum setiap hari, suntikan ini diberikan sekali tiap bulan
 - 2) Suntikan dapat dihentikan kapan saja
 - 3) Baik untuk menjarangkan kehamilan(Matahari et al., 2018)
- f. Keterbatasan
 - 1) Harus Kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik tepat waktu
 - 2) Efektivitas KSK tergantung pada kembalinya tepat waktu: risiko kehamilan akan meningkat saat klien terlambat suntik ulang atau melewatkan suatu suntikan
 - 3) Kemungkinan keterlambatan pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

5. Kontrasepsi Suntik Progestin (KSP)

- a. Definisi

Merupakan kontrasepsi suntik yang mengandung Progestin saja seperti hormon progesterone alami dalam tubuh perempuan (Kusumawardani & Azizah, 2021).
- b. Jenis
 - 1) Program pemerintah (disediakan oleh BKKBN) yaitu Depo Medroxyprogesterone Acetate/ DMPA dengan dosis 150 mg/ vial (1 ml) secara intra muskuler
 - 2) Nonprogram:
 - a) Depo subQ provera 104: suntikan subcutan setiap 3 bulan dengan sistem suntik Uniject dalam prefilled dosis tunggal syringe hipodermik
 - b) Norethisterone Enanthate (NET-EN) merupakan suntikan intra muskuler setiap 2 bulan(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).
- c. Mekanisme Kerja
 - 1) Mencegah ovulasi
 - 2) Mengentalkan lendir serviks sehingga penetrasi sperma terganggu
 - 3) Menjadikan endometrium tipis dan atrofi
 - 4) Menghambat transportasi gamet oleh tuba(Kusumawardani & Azizah, 2021)
- d. Efektivitas

Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun. Suntikan diberikan 3 bulan sekali (Matahari et al., 2018).
- e. Keuntungan Khusus Bagi Kesehatan
 - 1) Mengurangi risiko kanker endometrium dan fibroid uterus

- 2) Mengurangi risiko penyakit radang panggul simptomatik dan anemia defisiensi besi
 - 3) Mengurangi gejala endometriosis dan krisis sel sabit pada ibu dengan anemia sel sabit
- (Matahari et al., 2018).

f. Keuntungan

- 1) Tidak perlu penggunaan setiap hari
 - 2) Tidak mengganggu hubungan seksual
 - 3) Dapat digunakan oleh Perempuan menyusui dimulai 6 bulan setelah melahirkan
 - 4) Dapat digunakan oleh perempuan usia > 35 tahun sampai perimenopause
- (Kusumawardani & Azizah, 2021)

g. Keterbatasan

- 1) Klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan suntikan ulang
 - 2) Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu
 - 3) Terlambatnya kembalinya kesuburan setelah penghentian pemakaian, rata-rata 4 bulan
 - 4) Pada pemakaian jangka panjang dapat sedikit menurunkan densitas (kepadatan) tulang
- (Yulizawati et al., 2019)

6. Implan

a. Definisi

Implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api, yang melepaskan progestin yang menyerupai hormon progesterone alami di tubuh perempuan (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Jenis Implan

- 1) Implan dua batang: terdiri dari 2 batang implant yang mengandung hormon Levonorgestrel 75 mg/ batang. Efektif hingga 4 tahun penggunaan.
 - 2) Implan satu batang (Implanon): terdiri dari 1 batang implant mengandung hormon Etonogestrel 68 mg, efektif hingga 3 tahun penggunaan
- (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

c. Mekanisme kerja

- 1) Menekan ovulasi
 - 2) Mengentalkan lendir serviks
 - 3) Menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi
- (Yulizawati et al., 2019).

d. Efektivitas

Pada umumnya risiko kehamilan kurang dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun. Implan dimasukkan di bawah kulit dan dapat bertahan hingga 3-7 tahun (tergantung jenisnya). Kembalinya kesuburan tinggi setelah implant dilepas (Matahari et al., 2018).

e. Keuntungan Khusus Bagi Kesehatan

- 1) Mengurangi risiko penyakit radang panggul simptomatik
 - 2) Dapat mengurangi risiko anemia defisiensi besi
- (Kusumawardani & Azizah, 2021)

f. Keuntungan

- 1) Merupakan alat kontrasepsi jangka panjang, sehingga klien tidak perlu melakukan apapun untuk waktu yang lama setelah pemasangan
 - 2) Efektif mencegah kehamilan
 - 3) Tidak mengganggu hubungan seksual
 - 4) Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI
 - 5) Kesuburan dapat Kembali dengan segera setelah implant dilepas
 - 6) Mengurangi nyeri haid
- (Yulizawati et al., 2019).

g. Keterbatasan : perlu prosedur bedah yang harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan terlatih dan tidak memberikan perlindungan terhadap IMS (Matahari et al., 2018).

Alat kontrasepsi implant masih belum banyak yang menggunakan oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas kontrasepsi implant agar terjadi peningkatan kepesertaan metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur (Oktriyanto et al., 2023). Selain itu diperlukan peningkatan pengetahuan ibu (wanita usia subur) tentang implant sehingga mereka akan memilih implant sebagai alat kontrasepsi pilihan (Sitompul & Siregar, 2024).

B. Kontrasepsi Non Hormonal

1. Tubektomi

a. Definisi

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan secara permanen pada perempuan yang tidak ingin mempunyai anak lagi (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Jenis

- 1) Minilaparotomi dengan membuat insisi kecil pada perut kemudian tuba falopii ditarik ke irisan untuk dipotong dan diikat

- 2) Laparoskopi dengan memasukkan pipa kecil Panjang dengan lensa didalamnya ke dalam perut melalui insisi kecil. Laparoskopi memungkinkan dokter untuk mencapai dan memblok atau memotong tuba falopii di dalam perut

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

c. Mekanisme Kerja

Menutup tuba falopii (mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum (Matahari et al., 2018).

d. Keuntungan

- 1) Sangat efektif
- 2) Tidak mempengaruhi proses menyusui
- 3) Tidak bergantung pada factor senggama
- 4) Tidak memiliki efek samping dalam jangka Panjang
- 5) Tidak perlu khawatir menjadi hamil atau khawatir mengenai kontrasepsi lagi
- 6) Klien tidak perlu melakukan atau mengingat apapun setelah prosedur dilakukan
- 7) Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

e. Keterbatasan

- 1) Kesuburan tidak dapat dipulihkan kembali, kecuali dengan operasi rekanalisasi
 - 2) Rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan
 - 3) Harus dilakukan oleh dokter yang terlatih
- (Yulizawati et al., 2019).

2. Vasektomi

a. Definisi

Vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat vas deferens tanpa menggunakan pisau bedah, dengan tujuan memutuskan aliran sperma dari testis sehingga terjadi azoospermia (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Mekanisme Kerja

Mengikat dan memotong setiap saluran vas deferens sehingga sperma tidak bercampur dengan semen (Kusumawardani & Azizah, 2021).

- c. Keuntungan : menghentikan kesuburan secara permanen, prosedur bedahnya aman dan nyaman, efek samping lebih sedikit dibanding metode-metode yang digunakan Wanita, pria ikut mengambil peran dan meningkatkan kenikmatan serta frekuensi seks (Matahari et al., 2018).

d. Keterbatasan

- 1) Tidak segera efektif (WHO menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali ejakulasi)
 - 2) Komplikasi minor seperti infeksi, perdarahan, nyeri pasca operasi
 - 3) Harus dilakukan oleh dokter
- (Yulizawati et al., 2019)

3. Kondom

a. Definisi

Kondom merupakan selubung/ sarung karet yang berbetuk silinder dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu yang dipasang pada penis saat hubungan seksual, terbuat dari berbagai bahan diantaranya lateks (karet), polyurethane, polyisoprene, kulit domba dan nitrile (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

b. Mekanisme Kerja

Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi Perempuan (Matahari et al., 2018).

c. Efektivitas

Bila digunakan dengan benar, risiko kehamilan adalah 2 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Matahari et al., 2018).

d. Keuntungan khusus bagi Kesehatan

Mencegah penularan penyakit menular seksual dan konsekuensinya (Matahari et al., 2018).

e. Risiko bagi Kesehatan

Dapat memicu reaksi alergi pada orang-orang dengan alergi lateks (Matahari et al., 2018).

f. Keuntungan

Tidak ada efek samping hormonal, mudah didapat, dapat digunakan sebagai metode sementara atau Cadangan sebelum menggunakan metode lain, dapat mencegah penularan penyakit menular seksual (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

g. Keterbatasan

- 1) Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi
- 2) Agak mengganggu hubungan seksual (mengurangi sentuhan langsung)
- 3) Bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi
- 4) Malu membelinya di tempat umum

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

4. Diafragma

a. Mekanisme kerja

Diafragma adalah kap berbentuk cembung, terbuat dari lateks (karet) yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai saluran alat reproduksi bagian atas (uterus dan tuba falopii) (Matahari et al., 2018).

b. Efektivitas

Bila digunakan dengan benar bersama spermisida maka risiko kehamilan adalah 6 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Matahari et al., 2018).

c. Keuntungan

- 1) Tidak ada efek samping hormonal
 - 2) Pemakaiannya dikendalikan oleh Perempuan
 - 3) Dapat dipasang sebelum berhubungan seksual
- (Matahari et al., 2018).

d. Kerugian

Memerlukan pemeriksaan dalam untuk menentukan ukuran yang tepat, keberhasilan tergantung cara pemakaian (Matahari et al., 2018)

5. Spermisida

a. Definisi

Spermisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh sperma. Jenisnya berupa krim, busa, gel atau suppositoria vagina dan biasanya digunakan bersama dengan kondom atau diafragma (Harnani et al., 2022).

b. Efektivitas

Efektivitasnya sekitar 71% (Harnani et al., 2022).

6. Senggama terputus (Coitus Interruptus)

a. Definisi

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi (Harnani et al., 2022).

b. Mekanisme kerja

Alat kelamin (penis) dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan ovum dan kehamilan dapat dicegah (Harnani et al., 2022).

c. Efektivitas

Bila dilakukan secara benar, risiko kehamilan adalah 4 diantara 100 ibu dalam 1 tahun (Matahari et al., 2018).

d. Keuntungan

- 1) Efektivitas tinggi bila dilakukan dengan benar
 - 2) Tidak mengganggu produksi ASI
 - 3) Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya
 - 4) Tidak ada efek samping
 - 5) Dapat digunakan setiap waktu
 - 6) Tidak memerlukan biaya
- (Harnani et al., 2022).

e. Keterbatasan

- 1) Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan senggama terputus setiap melaksanakannya
 - 2) Efektivitas akan jauh menurun apabila sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis
 - 3) Memutuskan kenikmatan dalam berhubungan seksual
- (Harnani et al., 2022).

7. Metode Amenorea Laktasi (MAL)

a. Definisi

Metode Amenorea Laktasi (MAL) atau disebut Lactational Amenorrhea Method (LAM) adalah salah satu metode dalam merencanakan kehamilan yang bersifat alamiah dan sementara (Harnani et al., 2022). Kontrasepsi ini mengandalkan pemberian ASI (Air Susu Ibu) secara eksklusif untuk menekan ovulasi. Metode ini memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Ibu belum mendapatkan haid
- 2) Bayi disusui secara eksklusif
- 3) Bayi berusia kurang dari 6 bulan

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja kontrasepsi MAL adalah menunda atau menekan terjadinya ovulasi. Pada saat laktasi/ menyusui, hormon yang berperan adalah prolactin dan oksitosin. Semakin sering menyusui maka kadar prolactin meningkat dan hormon gonadotropin melepaskan hormon penghambat, hormon penghambat ini akan mengurangi kadar estrogen sehingga tidak terjadi ovulasi (Yulizawati et al., 2019).

c. Efektivitas

MAL memiliki efektivitas tinggi (keberhasilan 98% pada enam bulan pasca peralihan bila ASI menjadi satu-satunya sumber nutrisi pada bayi) (Yulizawati et al., 2019).

d. Keuntungan bagi Kesehatan

Mendorong pola menyusui yang benar, sehingga membawa manfaat bagi ibu dan bayi (Matahari et al., 2018)

e. Keuntungan

- 1) Efektivitas tinggi
 - 2) Segera efektif
 - 3) Tidak mengganggu senggama
 - 4) Tidak ada efek samping secara sistematis
 - 5) Tidak perlu pengawasan medis
 - 6) Tidak perlu obat atau alat
 - 7) Tanpa biaya
- (Harnani et al., 2022).

f. Keterbatasan

- 1) Perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui pasca persalinan
 - 2) Mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial
 - 3) Efektivitas yang tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan
 - 4) Tidak melindungi terhadap PMS termasuk virus hepatitis B dan HIV/AIDS
- (Yulizawati et al., 2019).

8. Pantang Berkala

a. Definisi

Pantang berkala adalah tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur istri (Harnani et al., 2022)

b. Cara melakukan metode pantang berkala yaitu:

1) Sistem Kalender

Merupakan metode kontrasepsi sederhana yang digunakan dengan cara tidak melakukan senggama pada masa subur atau ovulasi. Metode ini efektif bila digunakan dengan benar. Pasangan suami istri harus mengetahui masa subur dengan melakukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi sebelum menggunakan metode ini.

2) Lendir serviks

Merupakan metode keluarga berencana alamiah yaitu dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva untuk mengenali masa subur dari siklus menstruasi. Keberhasilan dari metode ini tergantung pada pemahaman yang tepat, instruksi yang tepat, pencairan lendir serviks dan keakuratan dalam pengamatan

3) Pengukuran suhu basal

Suhu basal merupakan suhu tubuh terendah selama istirahat atau dalam keadaan tidur. Pengukuran suhu basal ini dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas atau segera setelah bangun tidur. Caranya yaitu suhu basal tubuh diukur menggunakan thermometer basal.

(Harnani et al., 2022).

9. IUD (Intra Uterine Devices)

a. Mekanisme Kerja

Merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam uterus. IUD menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu, mencegah implantasi hasil konsepsi dalam uterus (Matahari et al., 2018).

b. Jangka waktu pemakaian : berjangka panjang dapat hingga 10 tahun serta sangat efektif dan bersifat reversible (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

c. Efektivitas

Memiliki efektivitas tinggi sekitar 0,6-0,8 kehamilan/ 100 perempuan dalam 1 tahun pertama (1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan) dan kembalinya kesuburan tinggi setelah IUD dilepas (Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

d. Keuntungan Khusus Bagi Kesehatan

Mengurangi risiko kanker endometrium (Matahari et al., 2018).

e. Risiko bagi Kesehatan

- 1) Dapat menyebabkan anemia bila cadangan besi ibu rendah sebelum pemasangan dan IUD menyebabkan haid yang lebih banyak
- 2) Dapat menyebabkan penyakit radang panggul bila ibu sudah terinfeksi klamidia atau gonoroea sebelum pemasangan

(Matahari et al., 2018).

f. Keuntungan

- 1) Efektif mencegah kehamilan
- 2) Efektif segera setelah pemasangan
- 3) Dapat digunakan untuk waktu yang lama
- 4) Tidak mempengaruhi menyusui
- 5) Dapat langsung dipasang setelah persalinan atau keguguran
- 6) Kesuburan segera Kembali setelah IUD dilepas

(Matahari et al., 2018).

g. Keterbatasan

- 1) Pemasangannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan dipasang pada uterus melalui vagina dan serviks sehingga klien takut selama pemasangan
- 2) Tidak ada perlindungan terhadap IMS
- 3) Tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering berganti pasangan
- 4) Klien tidak dapat melepas IUD sendiri
- 5) IUD mungkin keluar dari uterus tanpa diketahui
- 6) Klien harus memeriksa benang IUD dari waktu ke waktu dengan cara memasukkan jari kedalam vagina (sebagian perempuan tidak mau melakukan ini)

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021).

C. Latihan Soal

1. Jenis kontrasepsi pil kombinasi yang disediakan oleh Pemerintah yang terdiri dari 21 pil mengandung 30 µg Ethinyl Estradiol (EE)/ 150 µg Levonorgestrel (LNG) dan 7 pil tanpa hormon adalah jenis
 - A. Monofasik
 - B. Bifasik
 - C. Trifasik
 - D. Kuadrifasik
 - E. Pentafasik
-
2. Waktu pemberian pil kontrasepsi darurat Postinor adalah
 - A. Diberikan dalam waktu 5 hari pasca senggama
 - B. Diberikan dalam waktu 5 hari pasca senggama dan dosis kedua diminum segera setelah senggama
 - C. Diberikan dalam waktu 3 hari pasca senggama sebanyak 1 dosis
 - D. Diberikan dalam waktu 3 hari pasca senggama dan dosis kedua diminum 12 jam kemudian
 - E. Diberikan dalam waktu 12 jam pasca senggama
-
3. Berikut merupakan mekanisme kerja dari alat kontrasepsi implant adalah
 - A. Menjadikan selaput rahim tipis dan atrofi
 - B. Menghambat transportasi gamet oleh tuba
 - C. Mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu
 - D. Menutup tuba falopii sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum

- E. Menghalangi bertemunya sperma dan ovum
4. Suatu metode keluarga berencana tradisional dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi disebut
- A. Kondom laki-laki
 - B. Spermisida
 - C. Pantang berkala
 - D. Metode Amenorea Laktasi
 - E. Senggama terputus
5. Berikut yang BUKAN merupakan mekanisme kerja dari IUD adalah ...
- A. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii
 - B. Mengentalkan lendir serviks sehingga mengganggu penetrasi sperma
 - C. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri
 - D. Mencegah sperma dan ovum bertemu
 - E. Mencegah implantasi hasil konsepsi dalam uterus

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. D
- 3. A
- 4. E
- 5. B

D. Rangkuman Materi

Alat kontrasepsi merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu kontrasepsi hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal bekerja dengan cara memanipulasi kadar hormon reproduksi dalam tubuh, seperti estrogen dan progestin, untuk menghambat ovulasi (pelepasan sel telur), menebalkan lendir serviks agar menghalangi pergerakan sperma, serta menipiskan lapisan endometrium sehingga tidak mendukung implantasi. Jenis-jenis kontrasepsi hormonal meliputi kontrasepsi pil kombinasi, kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi suntik kombinasi, kontrasepsi suntik progestin dan implan subdermal, yang umumnya memiliki tingkat efektivitas tinggi jika digunakan secara konsisten dan benar.

Sementara itu, kontrasepsi non-hormonal bekerja tanpa melibatkan perubahan kadar hormon tubuh, melainkan dengan menciptakan penghalang fisik, kimia, atau biologis untuk mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Contoh

alat kontrasepsi non-hormonal antara lain kondom, diafragma, IUD tembaga, spermisida, metode pantang berkala, serta prosedur sterilisasi seperti vasektomi dan tubektomi. Mekanisme kerja kontrasepsi non-hormonal bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari menghambat masuknya sperma hingga menciptakan kondisi rahim yang tidak ramah bagi pembuahan. Pemilihan jenis kontrasepsi perlu mempertimbangkan faktor efektivitas, kenyamanan penggunaan, dan tujuan jangka panjang pasangan, dengan tetap melibatkan konsultasi medis untuk memastikan keamanan dan kesesuaian metode yang dipilih.

E. Glosarium

Anemia defisiensi besi : jenis anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi

Anemia sel sabit : kondisi kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah merah menjadi abnormal.

Atrofi : gangguan yang menyebabkan hilangnya jaringan otot.

Azoozpermia : gangguan reproduksi pada pria yang ditandai dengan tidak adanya kandungan sperma saat terjadi ejakulasi, sehingga dapat memengaruhi kesuburan (fertilitas)

Ekspulsi : keluarnya AKDR dari kavum uteri melalui kanalis servikalis, baik sempurna (*complete expulsion*) maupun sebagian (*partial expulsion*)

Endometrium: bagian terdalam dari organ rahim yang menjadi tempat menempelnya ovum atau sel telur setelah dibuahi

Estrogen: salah satu jenis hormon seks wanita yang diproduksi oleh ovarium

Fibroid uterus : pertumbuhan massa yang bersifat non-kanker di uterus (rahim).

Gamet : sel reproduksi atau sel kelamin yang berperan penting dalam proses reproduksi seksual.

Gonadotropin : hormon polipeptida yang digunakan untuk menginduksi ovulasi pada wanita, membantu memproduksi hormon testosteron dan sperma pada pria, serta mengobati kondisi yang memengaruhi testis (kriptorkismus).

Implantasi : tahap reproduksi manusia dimana embrio menuju ke dinding uterus

Ovulasi : proses yang ditandai dengan pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium (indung telur) ke tuba falopi.

Progesteron : hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi dan menstruasi, membantu implantasi calon janin pada rahim, serta mempertahankan kehamilan

Rekanalisasi : pembukaan kembali pembuluh darah yang tersumbat (pria dari saluran sperma dan wanita dari saluran indung telur)

Serviks : bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior (bawah) mengarah ke vagina pada sistem reproduksi wanita

F. Daftar Pustaka

- Direktorat Kesehatan Keluarga. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana. In Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Vol. 1, Issue November).
- Harnani, B. D., Wahyuni, S., Herawati, Z., Wulandari, E., & Reflisiani, D. (2022). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In Zahir Publishing. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LXMTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=keluarga+berencana&ots=IXh08gESYP&sig=_bMld5Jf0qPzkHH6RwjcajGnc6A
- Kusumawardani, P. A., & Azizah, N. (2021). Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB. In Umsida Press (Vol. 185, Issue 1).
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. In Pustaka Ilmu.
- Oktriyanto, O., Amrullah, H., & Wulandari, Y. (2023). Quality of Implant Contraceptives According to Provider: Analysis of Customer Satisfaction Index (CSI). *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 505–512. <https://doi.org/10.30604/jika.v8i1.1637>
- Sitompul, H., & Siregar, D. A. (2024). Pengetahuan Wanita Usia Subur tentang Efek Samping Pemakaian Alat Kontrasepsi Implan di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. *Jurnal Kebidanan Darmais*, 2(2), 22–28.
- Velinda, T., Adilla, D. R., & Roslita, R. (2022). Hubungan Pelibatan Tenaga Kesehatan Dalam Pemilihan Kontrasepsi Pil Dengan Frekuensi Efek Samping Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS). *Jurnal Keperawatan Hang Tuah*, 2(2), 221–233. <https://www.doi.org/10.25311/jkh.Vol2.Iss2.800>
- Yulizawati, Iryani, D., B, L. E. S., & Aldina Ayunda Insani. (2019). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana. In Indomedia Pustaka. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

BAB 2

EFEK SAMPING ATAU PENYULIT KONTRASEPSI HORMONAL DAN NON HORMONAL

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Efek Samping/ Penyulit Kontrasepsi Hormonal
- Menjelaskan Efek Samping/ Penyulit Kontrasepsi Non Hormonal

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan tentang efek samping/ penyulit kontrasepsi hormonal
- Mampu menjelaskan tentang efek samping/ penyulit kontrasepsi non hormonal

Pendahuluan:

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Melalui program KB, pasangan usia subur diberikan pilihan berbagai metode kontrasepsi untuk merencanakan dan mengatur kehamilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Namun, setiap metode kontrasepsi memiliki potensi efek samping dan penyulit yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dan pengguna.

Efek samping kontrasepsi dapat bersifat ringan hingga berat, sementara penyulit atau komplikasi dapat mempengaruhi keberlangsungan penggunaan metode tersebut. Pemahaman yang komprehensif mengenai efek samping dan penyulit ini penting untuk memastikan pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, memberikan konseling yang efektif, serta meningkatkan kepatuhan dan kepuasan pengguna.

Buku ajar ini disusun untuk memberikan informasi mendalam mengenai berbagai efek samping dan penyulit yang mungkin timbul dari penggunaan alat kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal. Materi dalam buku ini mencakup identifikasi efek samping umum dan spesifik, penanganan komplikasi.

Diharapkan, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan praktisi di bidang kesehatan reproduksi dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan individu.

Uraian Materi

A. Efek Samping/ Penyulit Kontrasepsi Hormonal

Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin saja maupun kombinasi dengan kandungan estrogen dan progestin. Metode kontrasepsi hormonal memiliki banyak efek samping, salah satunya adalah gangguan siklus menstruasi seperti metrorrhagia dan menorrhagia. Akseptor sering menghentikan kontrasepsi hormonal karena gangguan siklus menstruasi (Adiesti & Wari, 2020). Menurut penelitian yang berjudul Hubungan Kontrasepsi Hormonal dengan Siklus Menstruasi didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi hormonal dengan siklus menstruasi, akseptor kontrasepsi hormonal progestin berisiko 1,6 kali lebih besar mengalami ketidaknormalan siklus menstruasi dibandingkan akseptor kontrasepsi hormonal kombinasi (Adiesti & Wari, 2020).

1. Kontrasepsi Pil Kombinasi (KPK)

a. Efek Samping

1) Menstruasi tidak teratur atau perdarahan pervaginam

Penanganan:

- a) Minum pil setiap hari pada jam yang sama
- b) Minum Ibuprofen 3 x 800 mg selama 5 hari
- c) Bila perdarahan tidak berhenti maka anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi lain

2) Tidak menstruasi

Penanganan:

- a) Lakukan konseling bahwa terkadang setelah pemakaian kontrasepsi pil maka menstruasi menjadi tidak teratur dan bahkan tidak menstruasi
- b) Pastikan pil diminum setiap hari
- c) Pastikan klien tidak hamil

3) Sakit kepala biasa (bukan migrain)

Penanganan:

- a) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya
- b) Bila sakit kepala berlanjut maka lakukan konseling untuk memilih kontrasepsi lainnya

4) Mual atau pusing

Penanganan: untuk mengatasi mual maka minum pil menjelang tidur atau saat makan

5) Payudara nyeri

Penanganan:

- a) Sarankan klien untuk menggunakan bra yang sesuai baik saat aktivitas maupun tidak
- b) Lakukan kompres hangat atau dingin
- c) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya

6) Perubahan berat badan

Penanganan: lakukan evaluasi pola makan dan konsul gizi

7) Perubahan mood dan aktivitas seksual

Penanganan: lakukan konseling bila keluhan berlanjut dan sarankan memilih kontrasepsi lainnya

8) Jerawat

Penanganan:

- a) Jerawat umumnya timbul bersamaan dengan penggunaan pil
- b) Bila klien telah menggunakan pil kombinasi selama beberapa bulan dan jerawat tetap ada maka berikan pil dengan kombinasi lain dan sarankan memilih kontrasepsi jenis lain

9) Gastritis

Penanganan: anjurkan agar pil diminum setelah makan dan jika diperlukan dapat diberikan antasida

(BKKBN, 2021).

Beberapa efek samping tidak berbahaya dan akan menghilang setelah pemakaian beberapa bulan, misal haid tidak teratur.

b. Penyulit KPK yang Sering Terjadi

1) Amenorea (tidak ada perdarahan, spotting)

Penanganan: Melakukan pemeriksaan dalam atau tes kehamilan, jika tidak hamil dan klien minum pil dengan benar maka hal ini kemungkinan besar karena kurang adekuatnya efek estrogen terhadap endometrium, berikan pil dengan dosis estrogen 50 µg atau dosis estrogen tetap tetapi dosis progestin dikurangi. Bila klien hamil intrauterine maka hentikan pil dan yakinkan klien bahwa pil yang telah diminum tidak ada efek pada janin

2) Mual, pusing atau muntah

Penanganan: lakukan tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologik. Bila tidak hamil maka sarankan minum pil saat makan malam atau sebelum tidur.

3) Perdarahan pervaginam/ spotting

Penanganan: lakukan tes kehamilan atau pemeriksaan ginekologik. Sarankan minum pil pada waktu yang sama. Jelaskan kepada klien bahwa

perdarahan/ spotting merupakan hal yang biasa yang terjadi pada 3 bulan pertama dan lambat laun akan berhenti. Bila perdarahan/ spotting tetap saja terjadi maka Ganti pil dengan dosis estrogen lebih tinggi (50 µg) sampai perdarahan teratasi, lalu Kembali ke dosis awal. Bila perdarahan/ spotting timbul lagi, lanjutkan lagi dengan dosis 50 µg atau ganti dengan metode kontrasepsi yang lain.

(Kemenkes RI, 2019).

2. Kontrasepsi Pil Progestin (Minipil)

a. Efek Samping

1) Menstruasi tidak teratur atau perdarahan pervaginam

Penanganan:

- a) Minum pil setiap hari pada jam yang sama
- b) Minum Ibuprofen 3 x 800 mg selama 5 hari
- c) Bila perdarahan tidak berhenti maka anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi lain

2) Tidak menstruasi

Penanganan:

- a) Lakukan konseling bahwa terkadang setelah pemakaian kontrasepsi pil maa menstruasi menjadi tidak teratur dan bahkan tidak menstruasi
- b) Pastikan pil diminum setiap hari
- c) Pastikan klien tidak hamil

3) Sakit kepala biasa (bukan migrain)

Penanganan:

- a) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya
- b) Bila sakit kepala berlanjut maka lakukan konseling untuk memilih kontrasepsi lainnya

4) Mual atau pusing

Penanganan: untuk mengatasi mual maka minum pil menjelang tidur atau saat makan

5) Payudara nyeri

Penanganan:

- a) Sarankan klien untuk menggunakan bra yang sesuai baik saat aktivitas maupun tidak
- b) Lakukan kompres hangat atau dingin
- c) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya

6) Perubahan berat badan

Penanganan: lakukan evaluasi pola makan dan konsultasi gizi

7) Perubahan mood dan aktivitas seksual

Penanganan: lakukan konseling bila keluhan berlanjut dan sarankan memilih kontrasepsi lainnya

8) Jerawat

Penanganan:

a) Jerawat umumnya timbul bersamaan dengan penggunaan pil

b) Bila klien telah menggunakan pil kombinasi selama beberapa bulan dan jerawat tetap ada maka berikan pil dengan kombinasi lain dan sarankan memilih kontrasepsi jenis lain

9) Gastritis

Penanganan: anjurkan agar pil diminum setelah makan dan jika diperlukan dapat diberikan antasida

(BKKBN, 2021)

b. Penanganan Efek Samping

1) Amenorea

Penanganan: pastikan hamil atau tidak. Bila tidak hamil maka tidak perlu Tindakan khusus, cukup berikan konseling kepada klien. Bila amenorea berlanjut atau hal tersebut membuat klien khawatir maka lakukan rujukan. Bila klien hamil maka hentikan pil dan kehamilan dilanjutkan. Jelaskan kepada klien bahwa minipil sangat kecil dapat menimbulkan kelainan pada janin. Bila diduga kehamilan ektopik maka lakukan rujukan. Jangan memberikan obat-obatan hormonal untuk menimbulkan menstruasi.

2) Perdarahan tidak teratur/ spotting

Penanganan: bila tidak menimbulkan masalah Kesehatan/ tidak hamil maka tidak perlu Tindakan khusus. Bila klien tetap saja tidak dapat menerima kondisi tersebut maka perlu menggunakan metode kontrasepsi lainnya.

3) Mual, muntah, pusing

Penanganan: apabila klien tidak hamil maka sarankan minum pil saat makan atau sebelum tidur.

(Kemenkes RI, 2019).

Efek samping dan penyulit yang muncul karena penggunaan alat kontrasepsi pil dapat diterima oleh akseptor kontrasepsi pil, salah satunya adalah dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga Kesehatan sebelum memilih alat kontrasepsi yang tepat untuk dirinya yang berguna untuk meminimalisir efek samping yang terjadi. Selanjutnya tenaga kesehatan juga diharapkan untuk lebih menjelaskan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi

PUS guna mengurangi efek samping akibat penggunaan kontrasepsi (Velinda et al., 2022)

3. Kontrasepsi Suntik Kombinas (KSK)

a. Efek Samping

1) Menstruasi irregular (tidak teratur)

Penanganan:

- a) Yakinkan klien jika kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah beberapa bulan pasca pemasangan
- b) Berikan pengobatan jangka pendek, berikan asam mefenamat 2 x 500 mg selama 5 hari
- c) Jika kondisi ini terus berlangsung maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi

2) Tidak ada menstruasi (amenorea)

Penanganan: jelaskan ke klien jika kondisi ini tidak berbahaya

3) Menstruasi yang banyak dan lama

Penanganan:

- a) Yakinkan kepada klien jika kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah beberapa bulan
- b) Pengobatan jangka pendek boleh diberikan dengan asam mefenamat 3 x 500 mg selama 5 hari atau valdecoxib diberikan 1 x 40 mg selama 5 hari atau ethinyl estradiol diberikan 1 x 50 µg selama 21 hari dimulai sejak kondisi tersebut terjadi
- c) Jika perdarahan mengancam kesehatan maka sarankan untuk mengganti metode kontrasepsi
- d) Sarankan kepada klien untuk mengonsumsi obat penambah zat besi untuk mencegah anemia
- e) Jika kondisi ini terus berlangsung maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi

4) Kembung atau rasa tidak nyaman di perut

5) Perubahan berat badan

Penanganan: lakukan diet dan konsultasi gizi

6) Perubahan mood dan hasrat seksual

Penanganan:

- a) Berikan dukungan yang sepantasnya jika perubahan tersebut mempengaruhi hubungan dengan pasangan
- b) Jika terjadi perubahan mood yang berat seperti depresi mayor, maka harus mendapatkan perawatan segera.

7) Nyeri kepala biasa

Penanganan: berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya.

(BKKBN, 2021).

b. Penyulit pada klien kontrasepsi suntik kombinasi (KSK)

1) Perdarahan pervaginam yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya

Penanganan:

a) Rujuk ke fasilitas layanan Kesehatan Tingkat lanjut atau evaluasi Riwayat sebelumnya dan lakukan pemeriksaan pelvis, diagnosis dan obati dengan tepat

b) Jika perdarahan tidak dapat ditemukan maka ganti metode kontrasepsi (selain implant dan IUD)

c) Jika perdarahan disebabkan infeksi menular seksual atau penyakit radang panggul maka klien tetap dapat melanjutkan metode lain

2) Kondisi kesehatan yang serius seperti penyempitan pembuluh darah, penyakit hati yang berat, hipertensi yang berat, penyumbatan vena di tungkai atau paru, stroke, kanker payudara atau kerusakan arteri penglihatan, ginjal atau sistem syaraf pusat karena diabetes

Penanganan:

a) Stop suntikan kontrasepsi

b) Ganti metode kontrasepsi

c) Lakukan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut

3) Curiga kehamilan

Penanganan: lakukan evaluasi kehamilan dan stop suntikan jika kehamilan terkonfirmasi

(BKKBN, 2021).

4. Kontrasepsi Suntik Progestin (KSP)

a. Efek samping

1) Terjadi perubahan pola menstruasi (menstruasi menjadi tidak teratur atau memanjang dalam 3 bulan pertama, haid jarang, tidak teratur atau tidak haid dalam 1 tahun)

2) Sakit kepala/ pusing

3) Perubahan suasana perasaan

4) Penurunan hasrat seksual

5) Kenaikan berat badan

6) Perut kembung atau tidak nyaman

(Matahari et al., 2018).

b. Penyulit bagi klien Kontrasepsi Suntik Progestin

- 1) Setiap terlambat haid maka harus dipikirkan adanya kemungkinan kehamilan
- 2) Nyeri abdomen bawah yang berat maka kemungkinan gejala kehamilan ektopik terganggu
- 3) Timbulnya abses atau perdarahan di tempat injeksi
- 4) Sakit kepala migrain, sakit kepala berulang yang berat atau kaburnya penglihatan
- 5) Perdarahan berat yang dua kali lebih panjang dari masa haid atau dua kali lebih banyak dalam satu periode masa haid

(BKKBN, 2021).

Peningkatan berat badan yang merupakan salah satu efek samping dari penggunaan kontrasepsi suntik progestin (KSP/ DMPA) disebabkan oleh adanya peningkatan nafsu makan akibat hormon progesteron yang terkandung dalam kontrasepsi DMPA merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus. peningkatan nafsu makan setelah menggunakan KB suntik DMPA setelah 6 bulan pada penelitian ini (Hariati et al., 2020).

Efek samping KB hormonal suntikan terhadap gangguan menstruasi yaitu terjadi perdarahan intermenstrual dan perdarahan bercak/ spotting yang akan berkurang dengan jalannya waktu dan merupakan keluhan terbanyak dari akseptor. Sedangkan amenorea kasusnya akan semakin banyak dengan makin lamanya pemakaian (Hariati et al., 2020). Spotting yang terjadi pada akseptor kontrasepsi suntik diduga penyebabnya adalah adanya penambahan progesteron yang menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah vena kecil di endometrium dan vena tersebut akhirnya rapuh sehingga terjadi perdarahan lokal (Hariati et al., 2020).

5. Implan

a. Efek samping

- 1) Menstruasi irregular (tidak teratur)

Penanganan:

- a) Yakinkan kepada klien jika kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah satu tahun pemasangan
- b) Berikan pengobatan jangka pendek misalnya Ibuprofen diberikan 3 x 800 mg selama 5 hari atau Asam mefenamat diberikan 3 x 500 mg selama 5 hari dimulai sejak kondisi tersebut terjadi
- c) Jika obat diatas tidak membantu maka dapat diberikan: kontrasepsi pil kombinasi yang mengandung progestin levonorgestrel diminum 1 pil

sehari selama 21 hari atau ethinyl estradiol yang diberikan 1 x 50 µg selama 21 hari

- d) Jika kondisi ini terus berlanjut maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi

2) Tidak ada menstruasi dan menstruasi yang banyak dan lama

Penanganan:

- a) Yakinkan kepada klien jika kondisi ini tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah beberapa bulan
- b) Berikan pengobatan jangka pendek yaitu Ibuprofen diberikan 3 x 800 mg selama 5 hari atau Asam mefenamat diberikan 3 x 500 mg selama 5 hari dimulai sejak kondisi tersebut terjadi dan dapat dikombinasikan dengan kontrasepsi oral ethinyl estradiol 50 µg untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik
- c) Anjurkan klien untuk mengkonsumsi obat penambah zat besi untuk mencegah anemia
- d) Jika kondisi ini terus berlangsung maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi

3) Nyeri perut

Penanganan: berikan Aspirin 500 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya

4) Jerawat

Penanganan: jika klien ingin menghentikan implant karena jerawat maka dapat dipertimbangkan penggantian metode kontrasepsi dengan kontrasepsi oral kombinasi

5) Perubahan berat badan

Penanganan: lakukan diet dan konsultasi ahli gizi

6) Nyeri payudara

Penanganan:

- a) Berikan anjuran untuk menggunakan bra yang menyokong (saat aktivitas dan tidur)
- b) Berikan kompres panas atau dingin
- c) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya

7) Perubahan mood dan hasrat seksual

Penanganan:

- a) Berikan dukungan yang sepantasnya jika perubahan tersebut mempengaruhi hubungan dengan pasangan

- b) Jika terjadi perubahan mood (suasana hati) yang berat seperti depresi mayor maka lakukan rujukan untuk mendapatkan perawatan segera
- 8) Nyeri setelah pemasangan atau pencabutan
 - Penanganan:
 - a) Lakukan cek balutan pada lengan apakah terlalu ketat
 - b) Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya (BKKBN, 2021).
- b. Penyulit dari kontrasepsi implant dan penanganannya
 - 1) Infeksi pada tempat insersi
 - Penanganan:
 - a) Jangan mencabut implant
 - b) Bersihkan area yang terinfeksi dengan sabun dan air atau antiseptik
 - c) Berikan antibiotik oral selama 7-10 hari
 - d) Minta klien untuk Kembali jika antibiotik telah habis dan jika tetap terjadi infeksi maka cabut implant
 - 2) Ekspulsi
 - Penanganan: jika tidak ada infeksi maka ganti batang implant melalui insisi baru dekat dengan batang implant lainnya atau sarankan klien untuk mengganti implant
 - 3) Nyeri hebat di perut bawah
 - Penanganan:
 - a) Biasanya diakibatkan berbagai hal seperti pembesaran folikel ovarium atau kista
 - b) Klien dapat terus menggunakan implant selama penilaian
 - c) Tidak ada pengobatan khusus dan biasanya akan menghilang dengan sendirinya
 - d) Jika dicurigai sebagai salah satu gejala kehamilan ektopik dengan gejala lain berupa perdarahan pervaginam yang tidak normal atau tidak menstruasi, pusing, lemas/ pingsan maka segera rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut
 - 4) Sakit kepala hebat
 - Penanganan: implant segera dicabut (BKKBN, 2021).

B. Kontrasepsi Non Hormonal

1. Tubektomi

Penyulit dan penanganan dari metode kontrasepsi tubektomi antara lain :

a. Infeksi

Penanganan: dapat diberikan antibiotik dan bila terdapat abses dapat dilakukan drainase

b. Demam pasca operasi

Penanganan: lakukan pengobatan berdasarkan infeksi apa yang ditemukan

c. Luka pada kandung kemih atau intestinal

Penanganan: lakukan konsultasi dan penanganan luka

d. Hematoma

Penanganan: gunakan packs yang hangat dan lembab

e. Emboli gas

Penanganan: lakukan resusitasi dan tatalaksana emboli

f. Nyeri pada lokasi pembedahan

Penanganan: lakukan tatalaksana sesuai dengan derajat nyeri dan pastikan ada tidaknya infeksi

g. Perdarahan superfisial

Penanganan: lakukan pengontrolan perdarahan dan obati berdasarkan temuan

h. Terjadi reaksi hipersensitivitas saat dilakukan anestesi

Penanganan:

- 1) Berikan anestesi lokal secara perlahan-lahan dengan dosis sesuai berat badan
- 2) Hentikan pemberian anestesi
- 3) Baringkan klien dalam posisi Trendelenburg dengan sudut miring tidak melebihi 15°
- 4) Evaluasi tanda-tanda vital, jaga agar saluran nafas tetap terbuka jika ada sumbatan maka harus dibersihkan dan pasang spatel lidah, beri oksigen dengan tekanan gas serendah mungkin dan harus dimonitor dengan gas meter
- 5) Reaksi alergi biasanya responsif terhadap pemberian antihistamin. Reaksi yang lebih hebat mungkin memerlukan glukokortikoid sistemik seperti metilprednisolon atau dexamethasone.

(BKKBN, 2021).

2. Vasektomi

Penyulit dan penanganan dari metode vasektomi antara lain :

a. Penyumbatan pembuluh darah (*blood clot*)

Penanganan : biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa minggu, jika penyumbatan besar maka akan membutuhkan penanganan bedah dan lakukan rujukan segera

b. Abses

Penanganan : lakukan prosedur antiseptik, drainase abses, berikan antibiotik selama 7-10 hari, jika terjadi sepsis maka segera lakukan rujukan

c. Nyeri yang berlangsung lebih dari 1 bulan

Penanganan : disarankan untuk menggunakan pakaian dalam yang dapat menyangga skrotum, kompres dengan air hangat, berikan anti nyeri dan jika tidak terjadi perbaikan maka segera lakukan rujukan.

d. Rekanalisasi spontan

Penanganan : melakukan kembali vasektomi, melakukan interposisi yaitu dibuat baries vasa antara puntung testikuler dan puntung abdominal.

(BKKBN, 2021).

3. Kondom

a. Efek samping

1) Kondom rusak atau diperkirakan bocor (sebelum berhubungan seksual)

Penanganan : buang dan pakai kondom baru atau gunakan kondom dan spermisida

2) Kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan

Penanganan : pertimbangkan penggunaan kontrasepsi darurat

3) Reaksi alergi

Penanganan : anjurkan ganti metode kontrasepsi atau jika tersedia gunakan kondom yang terbuat dari lambskin atau gut dan lakukan terapi alergi jika mengganggu klien.

4) Mengurangi kenikmatan hubungan seksual

Penanganan : anjurkan untuk menggunakan kondom yang lebih tipis atau anjurkan metode kontrasepsi lain.

(BKKBN, 2021).

4. IUD

a. Efek samping

1) Menstruasi irreguler/ tidak teratur

Penanganan:

a) Yakinkan klien jika kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah beberapa bulan pertama penggunaan

b) Pengobatan jangka pendek, misalnya pemberian Ibuprofen 2 x 400 mg selama 5 hari atau Indometasin diberikan 2 x 25 mg selama 5 hari dimulai sejak kondisi tersebut terjadi

- c) Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi.
 - 2) Menstruasi yang banyak dan lama

Penanganan:

 - a) Yakinkan klien jika kondisi tersebut tidak berbahaya dan biasanya akan berkurang atau berhenti setelah penggunaan beberapa bulan
 - b) Pengobatan jangka pendek boleh diberikan, misalnya Asam traneksamat 3 x 500 mg selama 5 hari dimulai sejak perdarahan berlangsung atau Asam mefenamat 3 x 500 mg selama 5 hari atau Ibuprofen 2 x 400 mg selama 5 hari atau Indometasin 2 x 25 mg selama 5 hari
 - c) Sarankan untuk klien mengkonsumsi obat penambah zat besi atau makanan yang mengandung zat besi untuk mencegah anemia
 - d) Jika kondisi ini berlangsung maka pertimbangkan penyebab lain yang tidak berhubungan dengan kontrasepsi.
 - 3) Kram dan nyeri perut, dapat dirasakan klien beberapa hari setelah insersi IUD dan biasanya terjadi dalam 3 sampai 6 bulan setelah penggunaan IUD khususnya saat menstruasi dan kondisi ini tidak berbahaya

Penanganan: berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg atau Paracetamol 500-1000 mg atau penghilang nyeri lainnya. Aspirin tidak dapat digunakan jika ada perdarahan hebat.
 - 4) Anemia

Penanganan:

 - a) Awasi klien dengan gejala anemia atau dengan kadar Hb kurang dari 9 gr/dl atau hematokrit kurang dari 30 gr/dl
 - b) Berikan preparat zat besi jika dibutuhkan
 - c) Jelaskan pentingnya mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi
 - 5) Pasangan dapat merasakan benang IUD saat senggama

Penanganan:

 - a) Jelaskan kepada klien jika hal ini dikarenakan benang dipotong kurang pendek
 - b) Benang dapat dipotong lebih pendek sehingga benang tidak keluar ke kanalis servikalis maka pasangan tidak akan dapat merasakan benang tetapi klien tidak akan bisa mengecek benang IUD (BKKBN, 2021).
- b. Penyulit dari kontrasepsi IUD dan penanganannya
- 1) Nyeri hebat di perut bawah (curiga kehamilan ektopik)

Penanganan:

 - a) Waspadai gejala kehamilan ektopik karena dapat mengancam jiwa

- b) Lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- 2) Perforasi uterus yang dicurigai terjadi saat insersi maka hentikan prosedur secepatnya (Keluarkan IUD jika telah dilakukan insersi)
 Penanganan:
 - a) Lakukan observasi klien sebaik-baiknya pada satu jam pertama yaitu klien harus bed rest dan cek tanda vital tiap 5 sampai 10 menit
 - b) Jika klien tetap stabil setelah 1 jam maka cek tanda perdarahan intra abdomen seperti hematokrit rendah atau hemoglobin jika memungkinkan dan cek tanda-tanda vital
 - c) Observasi beberapa jam lagi, jika tidak ada tanda dan gejala maka klien dapat pulang tetapi anjurkan klien untuk menghindari melakukan hubungan seksual selama 2 minggu
 - d) Bantu klien untuk memilih metode kontrasepsi yang lain
 - e) Jika didapatkan nadi cepat dan penurunan tekanan darah, nyeri baru atau peningkatan intensitas nyeri di sekitar uterus maka lakukan rujukan
- 3) Perforasi uterus yang dicurigai terjadi 6 minggu atau lebih setelah insersi maka segera rujuk klien ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- 4) IUD keluar sebagian (ekspulsi sebagian)
 Penanganan : keluarkan IUD dan diskusikan dengan klien apakah tetap ingin menggunakan IUD atau metode kontrasepsi lainnya (IUD yang baru dapat langsung dipasang saat itu)
- 5) IUD keluar sempurna (ekspulsi lengkap)
 Penanganan:
 - a) Diskusikan dengan klien apakah tetap ingin menggunakan IUD atau metode lainnya (IUD yang baru dapat langsung dipasang saat itu)
 - b) Jika klien curiga terjadi ekspulsi lengkap tetapi tidak tahu kapan tepatnya terjadi, maka sarankan untuk melakukan x-ray atau USG untuk menilainya dan sarankan metode kontrasepsi lain selama proses penilaian
- 6) IUD patah dan benang hilang
 Penanganan:
 - a) Lakukan rujukan ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut
 - b) Lakukan cek benang dengan prosedur medis yang aman
 - c) Sekitar setengah dari kasus benang hilang dapat ditemukan di kanalis servikalis
 - d) Jika benang tidak dapat ditemukan maka pastikan tidak ada kehamilan sebelum melakukan tindakan invasif

- e) Segera lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki USG
- 7) Perdarahan pervaginam yang tidak dapat dijelaskan
Penanganan:
 - a) Lakukan evaluasi riwayat sebelumnya dan lakukan pemeriksaan pelvis, diagnosis dan obati dengan tepat. Jika tidak ada perbaikan maka lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut
 - b) IUD tetap dapat digunakan selama proses evaluasi
 - c) Jika penyebabnya adalah penyakit radang panggul atau infeksi menular seksual maka IUD tetap dapat digunakan selama pengobatan
- 8) Terjadi kehamilan
Penanganan: jelaskan kepada klien bahwa IUD dapat mengancam kehamilan dan keluarkan IUD segera selama benang IUD masih terlihat
- 9) Pada wanita yang hamil saat IUD masih terpasang dapat mengalami keguguran, kelahiran prematur atau infeksi
Penanganan: lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut (BKKBN, 2021).

Dari efek samping yang terjadi maka akan mempengaruhi rasa takut terhadap seseorang yang akan melakukan pemasangan KB IUD, dan jika jumlah calon akseptor IUD yang mempunyai rasa takut terhadap efek samping penggunaannya lebih tinggi maka dapat berdampak pada penurunan angka akseptor IUD selanjutnya (Rachmawati & Agustin, 2022). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan antara rasa takut ibu dengan efek samping pemasangan IUD, sehingga diperlukan pemberian penyuluhan kesehatan khususnya metode kontrasepsi kepada akseptor IUD sehingga akseptor dapat bersikap positif dan dapat mengelola stress yang dialami ketika timbul efek samping (Rachmawati & Agustin, 2022).

Kurangnya pengetahuan pada calon akseptor sangat berpengaruh terhadap pemakaian kontrasepsi, yaitu jika pengetahuan dari wanita kurang maka penggunaan kontrasepsi terutama metode IUD akan menurun. Selain itu diperlukan juga dukungan suami berupa perhatian dan memberikan rasa nyaman serta percaya diri dalam mengambil keputusan untuk menggunakan kontrasepsi IUD (Paula et al., 2020).

C. Latihan Soal

1. Berikut merupakan efek samping dari kontrasepsi pil kombinasi (KPK) adalah
 - A. Menstruasi menjadi tidak teratur
 - B. Terjadi reaksi hipersensitivitas
 - C. Terjadi penyumbatan pembuluh darah
 - D. Mengurangi kenikmatan hubungan seksual
 - E. Terjadi kram perut
2. Penanganan efek samping dari minipil berupa menstruasi tidak teratur adalah ...
 - A. Lakukan tes kehamilan
 - B. Minum pil setiap hari pada jam yang sama
 - C. Berikan Aspirin 500 mg atau Ibuprofen 400 mg
 - D. Minum pil menjelang tidur atau saat makan
 - E. Lakukan kompres hangat pada perut
3. Berikut merupakan penanganan penyulit implant berupa infeksi pada tempat insersi adalah ...
 - A. Bersihkan area yang terinfeksi
 - B. Ganti dengan implant yang baru
 - C. Lakukan konseling perawatan luka
 - D. Berikan obat pengurang rasa nyeri
 - E. Anjurkan klien memilih metode kontrasepsi lainnya
4. Berikut yang merupakan penyulit dari tubektomi adalah
 - A. Infeksi
 - B. Penyumbatan pembuluh darah
 - C. Nyeri yang berlangsung lebih dari 1 bulan
 - D. Rekanalisasi spontan
 - E. Terjadi reaksi alergi
5. Berikut merupakan penanganan efek samping dari IUD berupa menstruasi yang banyak dan lama adalah
 - A. Berikan Ibuprofen 2 x 400 mg selama 5 hari
 - B. Lakukan medical check up
 - C. Berikan konseling bahwa keadaan tersebut tidak berbahaya dan akan berkurang atau berhenti setelah beberapa bulan penggunaan
 - D. Berikan Aspirin 500 mg
 - E. Berikan preparate zat besi

Kunci Jawaban

1. A
2. B
3. A
4. A
5. C

D. Rangkuman Materi

Alat kontrasepsi, baik yang bersifat hormonal maupun non hormonal, memiliki berbagai efek samping dan kemungkinan penyulit yang perlu dipertimbangkan sebelum pemakaian. Kontrasepsi hormonal, seperti pil, suntikan, dan implan, bekerja dengan mengatur kadar hormon dalam tubuh untuk mencegah ovulasi. Efek samping umum dari alat ini meliputi mual, sakit kepala, kenaikan berat badan, perubahan mood, perdarahan di luar siklus menstruasi, dan pada beberapa kasus dapat meningkatkan risiko trombotik atau tekanan darah tinggi. Penggunaan jangka panjang juga perlu diawasi karena dapat memengaruhi metabolisme dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, kontrasepsi non hormonal seperti IUD, kondom, diafragma, dan metode alami, umumnya tidak memengaruhi keseimbangan hormon tubuh, namun tetap memiliki risiko tersendiri. Misalnya, IUD dapat menyebabkan nyeri haid yang lebih berat dan kram, serta meningkatkan risiko infeksi panggul terutama pada masa awal pemasangan. Kondom dapat menimbulkan iritasi atau alergi lateks pada sebagian individu, sedangkan metode alami rentan terhadap kegagalan akibat kesalahan dalam penghitungan masa subur. Oleh karena itu, pemilihan alat kontrasepsi harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan, preferensi, serta kesiapan pengguna untuk menghadapi kemungkinan efek samping dan penyulit yang bisa terjadi.

E. Glosarium

Amenorea: suatu keadaan atau kondisi dimana pada seorang wanita tidak mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya

Estrogen: hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya

Folikel ovarium: sekumpulan seluler berbentuk bulat yang ditemukan di indung telur yang mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tahap-tahap siklus menstruasi

Gastritis: kondisi saat terjadi peradangan pada dinding lambung

Hamil intrauterine: kehamilan yang terjadi ketika sel telur yang telah dibuahi menempel di dalam rahim

Menorrhagia: kondisi ketika terjadi perdarahan haid dalam jumlah yang banyak atau durasi yang lebih panjang daripada interval haid yang normal

Metrorrhagia: perdarahan yang tidak normal dari vagina di antara periode atau tidak terkait dengan menstruasi

Pasangan Usia Subur (PUS) : pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun

Pemeriksaan ginekologik : merupakan salah satu prosedur dalam dunia medis yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan gangguan atau penyakit terhadap organ reproduksi perempuan

Perdarahan intermenstrual : pendarahan pada rahim dengan interval yang tidak teratur, terutama antara periode menstruasi rutin

Progesteron : hormon yang berasal dari ovarium dan terlibat dalam terjadinya menstruasi maupun kehamilan.

Spotting : kondisi perdarahan vagina yang sangat ringan dan biasanya ditandai dengan keluarnya cairan berwarna coklat, dan terjadi di pertengahan siklus di antara periode menstruasi.

F. Daftar Pustaka

- Adiesti, F., & Wari, F. E. (2020). Hubungan kontrasepsi hormonal dengan siklus menstruasi. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 4(1), 6–12. <https://doi.org/10.32536/jrki.v4i1.71>
- BKKBN. (2021). Mata Pelatihan Inti 3 Pelayanan Kontrasepsi. <https://repository.binawan.ac.id/1464/>
- Hariati, A., Ekawati, N., & Nugrawati, N. (2020). Gambaran Efek Samping Pemberian Kontrasepsi Suntikan Hormonal. *Jmns*, 2(1), 18–25. <http://e-journal.aktabe.ac.id/index.php/jmns/article/view/37>
- Kemenkes RI. (2019). *Praktikum Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. In Poltekes Kemenkes Palangkaraya. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2.Modul Suhu dan Kalor.pdf, diakses pada tanggal 27 maret 2020
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. In *Pustaka Ilmu*.

- Paula, Y., Rahmadhani, S. P., & Handayani, S. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu, Dukungan Suami dan Efek Samping Dengan Penggunaan Kontrasepsi Intra Uterine Device (IUD) Di Puskesmas Pedamaran Timur Kabupaten Oki Tahun 2020. *Jurnal SMART ANkes*, 4(2), 8–13. <http://www.jurnalabdinusababel.ac.id/index.php/JSA/article/view/44>
- Rachmawati, A., & Agustin, E. R. (2022). Hubungan Antara Rasa Takut Ibu Terhadap Efek Samping Pemasangan Kontrasepsi IUD. *IJMT: Indonesian Journal of Midwifery Today*, 2(1), 20–26.
- Velinda, T., Adilla, D. R., & Roslita, R. (2022). Hubungan Pelibatan Tenaga Kesehatan Dalam Pemilihan Kontrasepsi Pil Dengan Frekuensi Efek Samping Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS). *Jurnal Keperawatan Hang Tuah*, 2(2), 221–233. <https://www.doi.org/10.25311/jkh.Vol2.Iss2.800>

BAB 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM BER-KB

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menunjukkan kompetensi dalam memberikan layanan KB berbasis keputusan informatif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi, psikososial, budaya, serta menghormati hak dan pilihan individu atau pasangan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya pengambilan keputusan dalam KB.
- Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memilih metode kontrasepsi.
- Menerapkan teknik komunikasi dan konseling yang efektif untuk mendukung klien dalam proses pengambilan keputusan ber-KB.
- Menganalisis implikasi keputusan KB terhadap kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan sub-bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan prinsip dasar pengambilan keputusan dalam ber-KB.
- Menguraikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan dalam memilih kontrasepsi.
- Menyusun langkah-langkah sistematis dalam mendukung pengambilan keputusan informatif.
- Mendemonstrasikan keterampilan konseling dalam membantu klien memahami pilihan KB yang tersedia.
- Mengevaluasi dampak pengambilan keputusan KB terhadap kesehatan reproduksi jangka pendek dan panjang.

Pendahuluan

Pengambilan keputusan dalam ber-KB merupakan proses penting yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor termasuk aspek kesehatan, psikososial, budaya, ekonomi, serta preferensi individu atau pasangan. Dalam pelayanan KB, tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan edukasi, konseling, dan pendampingan sehingga klien dapat membuat keputusan yang informatif, tepat, dan sesuai kebutuhan mereka. Bab ini akan menjelaskan berbagai aspek dalam proses

pengambilan keputusan KB, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi, metode pengambilan keputusan, serta implikasi keputusan tersebut terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Ber-KB

Pengambilan keputusan dalam ber-KB atau keluarga berencana merupakan sebuah proses penting yang memerlukan pertimbangan matang dari setiap individu atau pasangan dalam memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Secara mendasar, pengambilan keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau pasangan mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan relevan mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan prinsip utama yang dikenal sebagai *informed choice*, yaitu hak dasar seseorang untuk menentukan pilihan secara bebas setelah menerima informasi yang lengkap tentang manfaat, risiko, efek samping, serta implikasi jangka pendek maupun jangka panjang dari metode kontrasepsi yang akan digunakan.

Prinsip *informed choice* menempatkan individu sebagai pusat dari proses pengambilan keputusan, sehingga peran tenaga kesehatan atau pemberi layanan KB tidak sekadar memberikan rekomendasi atau menentukan metode tertentu secara sepihak, melainkan lebih menekankan pentingnya menyediakan berbagai informasi secara obyektif dan transparan kepada individu atau pasangan yang akan menggunakan layanan tersebut. Dengan demikian, individu atau pasangan akan mampu mempertimbangkan berbagai aspek kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, dan keyakinan pribadi mereka dalam membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun keluarga.

Dalam konteks keluarga berencana, informasi yang harus disediakan mencakup penjelasan yang komprehensif mengenai jenis-jenis metode kontrasepsi seperti kontrasepsi hormonal (pil, suntik, susuk/implan), kontrasepsi barrier (kondom, diafragma), alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), metode permanen seperti sterilisasi, serta metode alamiah seperti kalender atau amenorea laktasi. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, tingkat efektivitas, serta efek samping yang berbeda-beda, sehingga calon pengguna perlu mengetahui secara jelas informasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian antara harapan dan realita penggunaan metode tersebut.

Selain informasi terkait metode kontrasepsi secara umum, proses pengambilan keputusan KB juga membutuhkan informasi yang personal atau spesifik terhadap kondisi kesehatan individu atau pasangan, seperti usia, riwayat kesehatan, pola kehidupan seksual, frekuensi hubungan seksual, jumlah anak yang diinginkan, dan status ekonomi keluarga. Informasi-informasi ini penting karena setiap metode kontrasepsi memiliki indikasi dan kontraindikasi tertentu yang harus diperhatikan

agar pilihan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap kesehatan maupun kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pengambilan keputusan dalam ber-KB juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikososial seperti dukungan dari pasangan atau keluarga, tingkat pendidikan, persepsi masyarakat, norma-norma budaya, serta agama yang dianut. Faktor-faktor ini sering kali memengaruhi cara pandang seseorang terhadap metode kontrasepsi tertentu, sehingga proses edukasi dan konsultasi oleh tenaga kesehatan harus sensitif dan menghormati nilai-nilai yang dianut oleh calon pengguna KB.

Proses pengambilan keputusan yang efektif dalam KB pada akhirnya bertujuan untuk memastikan setiap individu atau pasangan merasa nyaman dan yakin terhadap pilihan metode kontrasepsi yang diambil. Oleh sebab itu, keterampilan komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan sangat diperlukan, termasuk kemampuan mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran pasien, memberikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti, serta memberikan kesempatan kepada individu atau pasangan untuk bertanya secara bebas mengenai berbagai aspek metode kontrasepsi yang ditawarkan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap individu atau pasangan tidak hanya sekadar menerima layanan KB, namun juga secara aktif dan sadar terlibat dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi dirinya, sehingga dapat mencapai tujuan utama keluarga berencana, yaitu tercapainya kualitas hidup yang lebih baik melalui pengaturan jumlah dan jarak kehamilannya secara efektif dan aman.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam berkeluarga berencana (KB) adalah suatu proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri individu (faktor internal) maupun dari lingkungan luar individu (faktor eksternal). Kedua jenis faktor ini secara signifikan dapat menentukan keputusan akhir mengenai metode kontrasepsi mana yang akan digunakan oleh individu atau pasangan.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan berbagai aspek yang melekat pada diri individu atau pasangan yang hendak memilih metode KB. Faktor ini umumnya bersifat personal dan berhubungan langsung dengan kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Berikut ini beberapa faktor internal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan KB:

a. Usia

Usia individu merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling tepat. Pada usia muda atau remaja, pilihan KB biasanya lebih diarahkan pada metode temporer seperti kondom atau pil, mengingat kebutuhan reproduksi di masa depan masih tinggi. Sebaliknya, pada usia yang lebih tua atau menjelang menopause, individu mungkin akan memilih metode kontrasepsi yang lebih permanen atau berjangka panjang seperti IUD atau sterilisasi, karena kemungkinan untuk memiliki anak di masa depan sudah menurun.

b. Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan sangat menentukan pemilihan metode KB yang aman dan efektif. Beberapa kondisi medis tertentu dapat menyebabkan kontraindikasi terhadap penggunaan metode kontrasepsi tertentu, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gangguan pembekuan darah, atau kanker. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi kesehatan ini harus diidentifikasi dengan jelas sebelum memilih metode KB yang sesuai.

c. Riwayat Medis

Riwayat medis seseorang, termasuk pengalaman menggunakan kontrasepsi sebelumnya, efek samping yang pernah dialami, serta adanya riwayat alergi atau reaksi negatif terhadap obat tertentu, akan sangat mempengaruhi pemilihan metode KB. Individu dengan riwayat efek samping serius terhadap metode tertentu mungkin akan menghindari metode tersebut di masa depan.

d. Preferensi Pribadi

Pilihan dan preferensi pribadi individu sangat menentukan keputusan KB yang akan diambil. Preferensi ini dapat didasarkan pada kemudahan penggunaan, kenyamanan, tingkat kepraktisan, maupun persepsi individu mengenai keamanan dan efektivitas metode kontrasepsi tertentu. Misalnya, seseorang yang merasa nyaman dengan metode pil KB karena mudah dikontrol secara pribadi mungkin akan terus menggunakan metode tersebut.

e. Rencana Kehamilan di Masa Depan

Rencana mengenai kehamilan di masa depan juga menjadi pertimbangan penting. Pasangan yang masih merencanakan kehamilan di kemudian hari akan cenderung memilih metode kontrasepsi temporer yang tidak mempengaruhi kesuburan secara permanen. Sebaliknya, individu atau pasangan yang tidak berencana memiliki anak lagi kemungkinan besar memilih metode permanen seperti vasektomi atau tubektomi.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar individu atau pasangan yang juga ikut mempengaruhi keputusan penggunaan KB. Faktor eksternal ini cenderung melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan yang berlaku. Berikut ini penjelasan detailnya:

a. Dukungan Pasangan dan Keluarga

Dukungan dari pasangan maupun keluarga merupakan salah satu faktor eksternal utama dalam pengambilan keputusan KB. Keputusan untuk menggunakan metode KB tertentu sering kali didiskusikan bersama pasangan, sehingga persetujuan dan dukungan dari pasangan dapat sangat mempengaruhi pilihan tersebut. Demikian pula, dukungan dari keluarga besar akan memberikan kenyamanan psikologis dalam penerapan metode kontrasepsi yang dipilih.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi secara signifikan mempengaruhi kemampuan seseorang atau keluarga dalam mengakses metode kontrasepsi tertentu. Beberapa metode kontrasepsi mungkin lebih mahal daripada metode lain, sehingga individu dengan keterbatasan ekonomi akan cenderung memilih metode yang lebih terjangkau seperti kondom atau pil KB yang disediakan pemerintah secara gratis atau bersubsidi.

c. Akses Layanan Kesehatan

Kemudahan akses layanan kesehatan menjadi faktor penting lainnya. Individu atau pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas layanan kesehatan yang memadai mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan metode KB tertentu yang memerlukan instalasi khusus seperti implan atau IUD. Akibatnya, mereka lebih memilih metode yang mudah diakses dan tidak memerlukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan.

d. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendukung dan menyediakan layanan KB secara luas akan mempermudah individu dalam memilih dan mendapatkan metode kontrasepsi yang mereka inginkan. Pemerintah yang menyediakan informasi edukatif secara luas, layanan konsultasi KB yang mudah diakses, serta subsidi atau fasilitas layanan KB gratis akan secara langsung mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan metode KB.

e. Faktor Budaya

Budaya yang dianut oleh masyarakat turut memberikan pengaruh besar terhadap pemilihan metode KB. Di beberapa budaya tertentu, misalnya, penggunaan metode KB tertentu seperti sterilisasi permanen dianggap tabu

atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hal ini tentu akan membuat individu atau pasangan menghindari penggunaan metode tersebut dan lebih memilih metode lain yang diterima secara budaya.

f. **Faktor Agama**

Agama juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan KB. Beberapa agama atau keyakinan tertentu memiliki pandangan yang berbeda terhadap penggunaan metode kontrasepsi, sehingga pilihan metode KB akan dipengaruhi oleh sejauh mana metode tersebut diperbolehkan atau dianjurkan menurut keyakinan agamanya.

C. Langkah-Langkah dalam Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam keluarga berencana (KB) merupakan suatu rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk membantu individu atau pasangan dalam menentukan metode kontrasepsi yang tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan serta kondisi mereka. Proses ini sangat penting karena keputusan yang diambil akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup individu maupun keluarganya. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diikuti secara cermat dan terstruktur dalam pengambilan keputusan KB, yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan Klien

Langkah awal yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan KB adalah melakukan identifikasi kebutuhan klien secara menyeluruh dan teliti. Pada tahap ini, tenaga kesehatan atau pemberi layanan KB perlu menggali informasi penting yang meliputi:

- a. Riwayat kesehatan klien: Kondisi kesehatan saat ini dan sebelumnya, riwayat penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, alergi obat, serta riwayat medis lain yang relevan.
- b. Usia klien dan pasangan: Penting diketahui karena faktor usia berpengaruh terhadap efektivitas dan keamanan metode kontrasepsi tertentu.
- c. Rencana kehamilan di masa depan: Mengetahui apakah klien masih merencanakan memiliki anak lagi dalam waktu dekat atau tidak, akan menentukan apakah metode jangka panjang, sementara, atau permanen yang paling sesuai.
- d. Preferensi dan harapan klien: Informasi tentang preferensi klien terhadap jenis metode kontrasepsi, harapan terhadap penggunaan metode, dan kenyamanan dalam menggunakan metode tertentu.
- e. Kondisi sosial-ekonomi dan budaya klien: Faktor-faktor yang memengaruhi akses dan penerimaan terhadap metode kontrasepsi tertentu.

Proses identifikasi ini sangat penting untuk memahami secara mendalam situasi pribadi klien, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi kontrasepsi yang tepat.

2. Penyampaian Informasi Kontrasepsi yang Lengkap dan Akurat

Setelah kebutuhan klien teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menyampaikan informasi yang lengkap, objektif, dan akurat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia. Informasi yang perlu disampaikan antara lain mencakup:

- a. Jenis-jenis metode kontrasepsi: seperti kontrasepsi hormonal (pil, suntik, implan), kontrasepsi non-hormonal (IUD tembaga), metode barrier (kondom), metode permanen (sterilisasi), dan metode alamiah (kalender, amenorea laktasi).
- b. Efektivitas masing-masing metode kontrasepsi: tingkat kegagalan metode dalam kondisi penggunaan ideal maupun kondisi praktis sehari-hari.
- c. Cara penggunaan metode kontrasepsi: prosedur pemakaian, frekuensi penggunaan, dan cara pemeliharaan atau pengawasan yang diperlukan.
- d. Efek samping dan risiko potensial: efek samping umum yang mungkin muncul serta risiko kesehatan khusus yang mungkin terjadi terkait penggunaan metode tertentu.
- e. Keuntungan tambahan dari tiap metode: misalnya perlindungan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) pada kondom, regulasi siklus menstruasi pada pil KB, atau efek perlindungan jangka panjang pada implan dan IUD.

Pemberian informasi yang jelas dan terstruktur ini bertujuan agar klien dapat membuat keputusan secara mandiri berdasarkan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh (informed choice).

3. Diskusi dan Konseling untuk Membantu Klien Memahami Informasi

Langkah selanjutnya adalah mengadakan diskusi terbuka dan sesi konseling secara interaktif dengan klien. Pada tahap ini, tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator yang mendengarkan kekhawatiran, pertanyaan, maupun keraguan yang dimiliki klien terkait metode kontrasepsi tertentu. Konseling bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan kembali informasi secara lebih detail: memastikan bahwa klien benar-benar memahami setiap pilihan yang tersedia.
- b. Menjawab pertanyaan dan klarifikasi: memungkinkan klien mengajukan berbagai pertanyaan seputar metode kontrasepsi.
- c. Mengeksplorasi preferensi pribadi klien: membantu klien mengenali faktor-faktor pribadi yang memengaruhi preferensi mereka terhadap metode tertentu.

- d. Memberikan kesempatan berdiskusi bersama pasangan: jika klien berpasangan, konseling ini juga menyediakan ruang untuk diskusi bersama pasangan demi mencapai kesepakatan yang disetujui bersama.
- e. Diskusi dan konseling ini bertujuan untuk memastikan bahwa klien mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan.

4. Mendukung Klien dalam Proses Memilih Metode yang Paling Sesuai

Setelah diskusi dan konseling, langkah penting berikutnya adalah mendukung klien dalam proses pemilihan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Dukungan ini dapat berupa:

- a. Memberikan dorongan dan motivasi: menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan klien, sehingga klien merasa memiliki kontrol penuh terhadap pilihannya.
- b. Membantu klien membandingkan metode: tenaga kesehatan dapat membantu klien membandingkan metode kontrasepsi berdasarkan kelebihan, kekurangan, kenyamanan, dan efektivitasnya.
- c. Menawarkan waktu untuk berpikir ulang jika diperlukan: memberikan ruang bagi klien untuk mempertimbangkan kembali jika masih ragu, sehingga tidak ada tekanan untuk mengambil keputusan tergesa-gesa.
- d. Menghormati keputusan klien: tenaga kesehatan wajib menghormati setiap keputusan yang diambil oleh klien tanpa adanya sikap menghakimi atau memaksakan metode tertentu.

Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa klien merasa nyaman, percaya diri, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan metode kontrasepsi yang diambil.

5. Implementasi Keputusan yang Telah Diambil

Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan KB adalah implementasi atau pelaksanaan keputusan tersebut dalam praktik nyata. Implementasi meliputi:

- a. Pemberian atau pemasangan metode kontrasepsi: seperti pemasangan implan atau IUD, pemberian pil atau suntik, atau pelaksanaan prosedur sterilisasi, sesuai metode yang dipilih klien.
- b. Pendidikan mengenai penggunaan metode yang dipilih: memberikan instruksi penggunaan yang jelas dan praktis kepada klien agar metode yang dipilih dapat digunakan dengan benar dan efektif.
- c. Pengaturan jadwal follow-up atau kunjungan ulang: menetapkan jadwal kunjungan kontrol untuk mengevaluasi adaptasi tubuh klien terhadap metode

kontrasepsi yang baru digunakan, serta memastikan kepatuhan dan kenyamanan klien.

- d. Pemantauan dan evaluasi jangka panjang: melakukan evaluasi berkala untuk memantau efek samping, efektivitas kontrasepsi, serta tingkat kepuasan klien terhadap metode yang dipilih.

Implementasi yang baik akan menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh klien tidak hanya berhasil di tahap awal, tetapi juga memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang sesuai harapan mereka.

D. Teknik Komunikasi dan Konseling dalam Ber-KB

Komunikasi dan konseling merupakan inti utama dalam pelayanan keluarga berencana (KB), karena kesuksesan program KB sangat bergantung pada bagaimana klien memahami, menerima, dan merasa nyaman dengan informasi serta metode kontrasepsi yang dipilih. Keterampilan komunikasi yang efektif dalam konseling KB sangat penting agar individu atau pasangan dapat mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan kondisi spesifik mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, konseling KB harus dilakukan secara empati, menggunakan teknik komunikasi yang efektif, serta bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh klien.

Dalam pelaksanaan konseling KB, salah satu teknik komunikasi yang sangat penting adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan suatu keterampilan komunikasi di mana tenaga kesehatan tidak hanya mendengar secara pasif, tetapi juga secara aktif menunjukkan perhatian, minat, dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh klien. Mendengarkan aktif ditandai dengan sikap tubuh yang terbuka, kontak mata yang baik, anggukan kepala sebagai tanda pengertian, serta respons verbal yang menunjukkan bahwa tenaga kesehatan benar-benar memahami pesan klien. Selain itu, mendengarkan aktif juga melibatkan proses klarifikasi, yaitu dengan mengulang atau merangkum kembali ucapan klien untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan telah menangkap maksud dari apa yang disampaikan. Teknik ini akan membuat klien merasa dihargai, didengar, dan lebih percaya diri dalam mengungkapkan masalah, kebutuhan, serta preferensinya secara lebih terbuka.

Selain mendengarkan aktif, pemberian empati juga merupakan teknik komunikasi penting dalam konseling KB. Empati didefinisikan sebagai kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh klien, seolah-olah berada dalam posisi klien tersebut. Dalam konseling KB, empati dapat ditunjukkan melalui ungkapan verbal yang menunjukkan

pengertian terhadap perasaan atau kekhawatiran klien, seperti menyatakan pemahaman tentang kecemasan yang dirasakan terkait efek samping atau ketidakpastian mengenai efektivitas metode kontrasepsi tertentu. Selain ungkapan verbal, empati juga dapat ditunjukkan melalui ekspresi wajah yang lembut, nada bicara yang tenang dan penuh perhatian, serta sikap yang tidak menghakimi. Dengan merasakan adanya empati, klien akan merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi keputusan penting mengenai KB, sehingga lebih mudah terbuka dan mempercayai tenaga kesehatan dalam menyampaikan masalahnya.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam teknik komunikasi konseling KB adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Sebagian besar klien KB berasal dari latar belakang pendidikan, sosial, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga kemampuan mereka dalam memahami istilah-istilah medis atau teknis pun bervariasi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus menghindari penggunaan jargon medis atau istilah-istilah rumit dalam memberikan informasi mengenai metode KB. Bahasa yang digunakan harus sederhana, lugas, dan mudah dimengerti. Misalnya, daripada menggunakan istilah "kontrasepsi hormonal oral", lebih baik tenaga kesehatan mengatakan "pil KB yang diminum setiap hari". Demikian pula, informasi mengenai efek samping atau cara penggunaan harus disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan oleh klien. Teknik ini bertujuan agar klien benar-benar memahami informasi yang disampaikan tanpa kesulitan, sehingga mereka dapat membuat keputusan secara tepat berdasarkan pemahaman yang jelas dan penuh keyakinan.

Selain teknik-teknik tersebut, keterampilan komunikasi dalam konseling KB juga mencakup kemampuan tenaga kesehatan untuk menciptakan suasana diskusi yang nyaman dan terbuka. Suasana yang nyaman dapat tercipta melalui sikap ramah, tidak terburu-buru, dan bersedia meluangkan waktu khusus untuk klien. Dalam suasana yang nyaman ini, klien akan merasa bebas menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, atau masalah yang mungkin selama ini sulit mereka ungkapkan. Tenaga kesehatan juga harus peka terhadap sinyal-sinyal nonverbal dari klien, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau nada suara yang menunjukkan ketidaknyamanan atau keraguan, sehingga bisa memberikan respons yang tepat untuk membantu klien mengatasi perasaan-perasaan tersebut.

Dengan menerapkan berbagai teknik komunikasi ini secara efektif, konseling KB tidak hanya sekedar menjadi kegiatan informatif, tetapi juga menjadi proses interaktif yang penuh perhatian dan penghargaan terhadap klien. Akhirnya, klien tidak hanya menerima informasi, namun juga mendapatkan dukungan emosional dan psikologis, yang akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam membuat

keputusan tentang metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka.

E. Implikasi Keputusan KB

Pemilihan metode kontrasepsi bukan hanya sekadar keputusan medis atau teknis yang sederhana, namun merupakan keputusan yang memiliki dampak atau implikasi yang luas dan kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan individu maupun keluarga. Ketika seseorang atau pasangan memutuskan untuk menggunakan metode kontrasepsi tertentu, keputusan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik saja, melainkan juga pada kesehatan mental, hubungan interpersonal, serta kesuksesan program keluarga berencana secara keseluruhan.

Berikut adalah penjelasan secara rinci beserta uraian tentang implikasi dari keputusan dalam pemilihan metode kontrasepsi:

1. Implikasi terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Klien

Setiap keputusan terkait metode kontrasepsi memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi kesehatan fisik maupun mental pengguna. Implikasi terhadap kesehatan fisik terutama terkait dengan bagaimana tubuh individu merespon terhadap metode kontrasepsi yang dipilih. Sebagai contoh, penggunaan metode kontrasepsi hormonal seperti pil, suntik, atau implan dapat menimbulkan efek samping tertentu yang perlu diperhatikan. Efek samping tersebut bisa berupa perubahan siklus menstruasi, penambahan berat badan, sakit kepala, mual, nyeri payudara, atau perdarahan bercak yang tidak teratur. Sementara metode kontrasepsi non-hormonal seperti IUD tembaga mungkin bisa menyebabkan peningkatan nyeri menstruasi atau perdarahan yang lebih banyak. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa klien memahami sepenuhnya potensi risiko dan efek samping yang mungkin timbul dari metode kontrasepsi yang dipilih.

Selain dampak fisik, keputusan kontrasepsi juga membawa implikasi pada kesehatan mental klien. Pemilihan metode kontrasepsi yang tepat dan nyaman digunakan akan memberikan rasa aman, nyaman, dan menurunkan tingkat stres atau kecemasan terkait kehamilan yang tidak direncanakan. Sebaliknya, pemilihan metode kontrasepsi yang tidak sesuai, misalnya metode yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik atau efek samping yang serius, dapat memicu kecemasan, depresi, atau stres emosional yang tinggi. Oleh karena itu, konseling dan pemantauan berkala sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa metode

kontrasepsi yang digunakan benar-benar mendukung kesehatan fisik dan mental klien.

Secara ringkas, implikasi terhadap kesehatan fisik dan mental meliputi:

- a. Efek samping fisik: perubahan hormonal, perdarahan, nyeri, atau gangguan siklus menstruasi.
- b. Efek psikologis: rasa aman atau kecemasan, stres emosional, depresi atau kesejahteraan mental secara keseluruhan.

2. Implikasi terhadap Hubungan Interpersonal dan Dinamika Keluarga

Keputusan mengenai pemilihan metode kontrasepsi juga secara langsung atau tidak langsung memengaruhi hubungan interpersonal, terutama dalam konteks hubungan pasangan dan dinamika keluarga secara umum. Secara interpersonal, keputusan ini dapat memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara pasangan apabila keputusan tersebut dibuat bersama-sama melalui diskusi terbuka dan saling menghormati. Proses pengambilan keputusan bersama pasangan mengenai kontrasepsi dapat mempererat ikatan emosional, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan rasa saling mendukung dalam hubungan tersebut.

Namun demikian, apabila keputusan kontrasepsi diambil tanpa komunikasi yang jelas atau tanpa persetujuan pasangan, hal tersebut bisa menimbulkan konflik atau ketidakpuasan dalam hubungan. Beberapa metode kontrasepsi mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena alasan budaya, agama, atau preferensi pribadi yang berbeda. Misalnya, penggunaan metode kontrasepsi permanen seperti sterilisasi yang diputuskan tanpa persetujuan pasangan dapat menimbulkan konflik serius dalam keluarga.

Selain hubungan antar pasangan, keputusan mengenai KB juga mempengaruhi dinamika keluarga secara luas, terutama dalam hal merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak. Pengaturan jumlah anak yang ideal dan terencana akan membantu keluarga dalam mengelola sumber daya, seperti ekonomi, pendidikan, perhatian dan kasih sayang yang lebih optimal kepada anak-anak yang ada. Sebaliknya, ketidakjelasan keputusan KB dapat menambah beban finansial dan psikologis yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga secara umum.

Implikasi terhadap hubungan interpersonal dan dinamika keluarga mencakup:

- a. Komunikasi pasangan: mempererat atau berpotensi menimbulkan konflik.

- b. Kesejahteraan emosional keluarga: kenyamanan psikologis keluarga dalam merencanakan masa depan.
- c. Stabilitas ekonomi keluarga: pengaturan keuangan dan sumber daya keluarga secara efektif.

3. Implikasi terhadap Keberhasilan Program Keluarga Berencana secara Luas

Pada tingkat yang lebih luas, keputusan individu atau pasangan dalam pemilihan metode kontrasepsi akan berdampak langsung pada keberhasilan program KB secara nasional atau global. Keberhasilan program keluarga berencana bergantung pada tingkat penggunaan kontrasepsi yang konsisten dan tepat, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan, angka aborsi, angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Ketika individu atau pasangan mampu memilih metode kontrasepsi yang efektif, aman, dan nyaman digunakan, maka tingkat kepatuhan terhadap metode tersebut akan meningkat. Kepatuhan yang tinggi dalam penggunaan metode kontrasepsi akan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan program KB, yaitu mengatur pertumbuhan populasi, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menurunkan angka kelahiran yang tidak direncanakan. Sebaliknya, jika keputusan kontrasepsi yang diambil kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan klien, tingkat kegagalan metode atau penghentian penggunaan kontrasepsi meningkat, yang kemudian menghambat pencapaian tujuan program keluarga berencana secara luas.

Selain itu, keputusan KB yang tepat juga akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, menyediakan layanan kontrasepsi yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam program KB. Sebagai hasilnya, manfaat program KB tidak hanya terbatas pada individu atau keluarga saja, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Implikasi terhadap keberhasilan program keluarga berencana secara luas mencakup:

- a. Penurunan angka kehamilan yang tidak direncanakan dan aborsi.
- b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum (khususnya kesehatan ibu dan anak).
- c. Peningkatan efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan populasi.

F. Latihan Soal

Kasus 1

Rina, 23 tahun, baru menikah 6 bulan lalu dan datang ke klinik KB untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi yang sesuai. Ia menyatakan belum ingin memiliki anak setidaknya selama 3 tahun ke depan karena ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Rina mengaku sering lupa jadwal minum obat rutin, namun takut terhadap prosedur invasif. Metode kontrasepsi apa yang paling sesuai untuk Rina?

- A. Suntik KB 3 bulan
- B. Pil KB kombinasi
- C. IUD
- D. Implan
- E. Metode kalender

Kunci Jawaban: D (Implan)

Rasional:

Metode implan sangat sesuai untuk Rina karena ia ingin menunda kehamilan dalam jangka panjang (hingga 3 tahun atau lebih). Implan memiliki efektivitas tinggi (hingga 99%) dan tidak memerlukan kepatuhan tinggi setiap hari seperti pil KB, sehingga sesuai dengan kondisi Rina yang sering lupa minum obat. Prosedur pemasangan implan tergolong minim invasif dibandingkan IUD yang lebih invasif.

Kasus 2

Ibu Siti, 38 tahun, telah memiliki 4 anak dan merasa cukup dengan jumlah anaknya saat ini. Ia datang bersama suaminya ke klinik KB dan menyampaikan ingin metode kontrasepsi yang permanen. Setelah konseling, pasangan ini masih ragu terkait risiko operasi. Sebagai perawat, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah?

- A. Menyarankan pemasangan IUD
- B. Menyarankan kontrasepsi hormonal suntikan bulanan
- C. Melakukan konseling ulang untuk informed choice
- D. Mengarahkan segera ke dokter bedah untuk sterilisasi
- E. Menyarankan metode alami kalender

Kunci Jawaban: C (Melakukan konseling ulang untuk informed choice)

Rasional:

Pasangan masih ragu, sehingga tindakan paling tepat adalah melakukan konseling ulang untuk memastikan mereka benar-benar paham tentang manfaat dan risiko sterilisasi. Prinsip informed choice menuntut agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pemahaman lengkap, tanpa tekanan atau keterpaksaan.

Kasus 3

Mila, usia 20 tahun, datang ke klinik KB karena ingin menunda kehamilan hingga menyelesaikan studi. Saat wawancara, Mila mengungkapkan bahwa ia memiliki riwayat migrain berat yang disertai aura. Berdasarkan kondisi kesehatan tersebut, metode kontrasepsi mana yang sebaiknya tidak disarankan untuk Mila?

- A. Implan progesteron
- B. Suntik KB 3 bulanan
- C. Pil KB kombinasi
- D. IUD tembaga
- E. Metode barrier (kondom)

Kunci Jawaban: C (Pil KB kombinasi)

Rasional:

Pil KB kombinasi mengandung estrogen yang kontraindikasi bagi wanita dengan migrain berat disertai aura, karena dapat meningkatkan risiko stroke. Metode non-estrogen seperti IUD tembaga, kondom, suntik progesteron, atau implan progesteron lebih dianjurkan.

Kasus 4

Seorang ibu usia 30 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 ingin menggunakan KB hormonal. Saat konseling, ibu ini mengaku takut efek samping kenaikan berat badan dan gangguan gula darahnya memburuk. Sebagai perawat, rekomendasi yang paling tepat adalah?

- A. Pil KB kombinasi dosis rendah
- B. Suntik KB progestin
- C. Pil KB estrogen tinggi
- D. Metode IUD tembaga
- E. Kondom wanita

Kunci Jawaban: D (Metode IUD tembaga)

Rasional:

IUD tembaga tidak mengandung hormon, sehingga paling aman bagi wanita diabetes karena tidak menyebabkan perubahan metabolisme gula darah atau peningkatan berat badan, berbeda dengan metode hormonal seperti suntik progestin atau pil kombinasi.

Kasus 5

Pasangan muda, Tika (24 tahun) dan Budi (26 tahun), datang untuk memilih metode kontrasepsi. Mereka tinggal di desa yang cukup jauh dari layanan kesehatan dan

hanya bisa ke klinik setiap 6 bulan sekali. Mereka juga tidak ingin metode permanen. Metode apa yang paling tepat untuk pasangan ini?

- A. Kondom
- B. Pil KB
- C. Suntik KB bulanan
- D. Suntik KB 3 bulanan
- E. Metode kalender

Kunci Jawaban: D (Suntik KB 3 bulanan)

Rasional:

Suntik KB 3 bulanan efektif untuk pasangan yang kesulitan akses rutin ke fasilitas kesehatan, karena hanya memerlukan kontrol setiap 3 bulan. Metode ini tidak permanen, sangat sesuai dengan keinginan pasangan yang ingin menunda kehamilan sementara dan terbatasnya akses rutin ke fasilitas kesehatan.

G. Rangkuman Materi

Pengambilan keputusan dalam keluarga berencana (KB) merupakan proses penting dan kompleks yang melibatkan berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Keputusan yang baik dalam pemilihan metode kontrasepsi didasarkan pada prinsip informed choice, yang memastikan bahwa setiap individu atau pasangan mendapatkan informasi lengkap, jelas, dan objektif tentang berbagai pilihan kontrasepsi yang tersedia, beserta manfaat dan risiko yang melekat pada masing-masing metode tersebut. Faktor-faktor internal seperti usia, kondisi kesehatan, riwayat medis, preferensi pribadi, serta rencana kehamilan di masa depan, dan faktor eksternal seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, akses layanan kesehatan, kebijakan pemerintah, faktor budaya dan agama sangat mempengaruhi pilihan yang diambil.

Proses pengambilan keputusan KB yang efektif terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu identifikasi kebutuhan klien secara menyeluruh, penyampaian informasi lengkap tentang metode kontrasepsi, konseling interaktif yang empatik, mendukung klien dalam pemilihan metode secara mandiri, serta implementasi dan pemantauan keputusan tersebut. Keterampilan komunikasi tenaga kesehatan dalam proses konseling sangat penting untuk menciptakan suasana diskusi yang nyaman, terbuka, dan saling menghargai, sehingga klien mampu membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan keluarga.

Implikasi dari keputusan KB sangat luas, mencakup aspek kesehatan fisik dan mental klien, hubungan interpersonal dalam keluarga, dan dampak jangka panjang

terhadap keberhasilan program keluarga berencana secara nasional maupun global. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sensitif terhadap nilai dan kebutuhan individu serta dukungan komunikasi yang efektif, maka pengambilan keputusan dalam ber-KB tidak hanya memastikan tercapainya tujuan pengaturan jumlah dan jarak kehamilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

H. Glosarium

Amenorea Laktasi

Metode kontrasepsi alami dengan memanfaatkan periode menyusui eksklusif yang dapat menunda ovulasi dan menstruasi setelah melahirkan.

Barrier (Metode Barrier)

Jenis kontrasepsi yang mencegah kehamilan dengan menghalangi sperma memasuki rahim, misalnya kondom atau diafragma.

Efektivitas Kontrasepsi

Tingkat keberhasilan suatu metode kontrasepsi dalam mencegah kehamilan dalam penggunaan yang ideal maupun penggunaan praktis sehari-hari.

Faktor Eksternal

Aspek lingkungan di sekitar individu atau pasangan yang memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi, meliputi dukungan keluarga, kondisi ekonomi, akses layanan kesehatan, kebijakan pemerintah, budaya, dan agama.

Faktor Internal

Aspek personal yang melekat pada individu atau pasangan dalam memilih metode kontrasepsi, meliputi usia, kondisi kesehatan, riwayat medis, preferensi pribadi, dan rencana kehamilan di masa depan.

Implan (Susuk)

Metode kontrasepsi hormonal jangka panjang berupa tabung kecil yang ditanamkan di bawah kulit, biasanya di lengan atas, dan melepaskan hormon secara bertahap.

Indikasi dan Kontraindikasi

Kondisi yang menunjukkan suatu metode kontrasepsi boleh digunakan (indikasi) atau sebaiknya dihindari (kontraindikasi) karena berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna.

Informed Choice

Hak dasar individu untuk membuat keputusan secara bebas berdasarkan informasi yang lengkap, objektif, dan akurat tentang berbagai pilihan metode kontrasepsi beserta manfaat dan risikonya.

IUD (Intra Uterine Device)/AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Alat kontrasepsi non-hormonal berupa perangkat kecil berbentuk T yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah pembuahan dan implantasi.

Keluarga Berencana (KB)

Program perencanaan jumlah dan jarak kehamilan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan aman.

Komunikasi Efektif

Kemampuan tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi dengan jelas, sederhana, empati, serta aktif mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran klien dalam proses konseling KB.

Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi yang menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi dan mengubah kondisi rahim, misalnya pil KB, suntik KB, dan implan.

Metode Permanen (Sterilisasi)

Metode kontrasepsi jangka panjang yang bersifat permanen dengan prosedur bedah untuk memotong atau menutup saluran reproduksi, misalnya vasektomi (pria) atau tubektomi (wanita).

Metode Temporer

Metode kontrasepsi yang bersifat sementara dan dapat dihentikan penggunaannya bila menginginkan kehamilan di masa depan, seperti pil KB, kondom, suntik KB, atau implan.

Metode Alamiah

Metode kontrasepsi yang mengandalkan pengamatan siklus alami tubuh wanita tanpa alat atau hormon tambahan, misalnya metode kalender atau amenorea laktasi.

Mendengarkan Aktif

Teknik komunikasi yang menunjukkan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan klien, dengan respons nonverbal dan verbal yang memastikan pemahaman penuh atas pesan klien.

Pemantauan dan Evaluasi

Proses untuk menilai efektivitas dan kenyamanan metode kontrasepsi yang digunakan klien secara berkala untuk memastikan metode tersebut sesuai dan aman dalam jangka panjang.

Preferensi Pribadi

Pilihan metode kontrasepsi berdasarkan kenyamanan, kemudahan penggunaan, kepraktisan, serta persepsi pribadi individu atau pasangan terhadap efektivitas dan keamanan metode tersebut.

Prinsip Konseling

Pendekatan interaktif yang empati, objektif, non-menghakimi, dan menghormati nilai serta keyakinan individu atau pasangan dalam proses pengambilan keputusan KB.

Psikososial

Aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi keputusan individu atau pasangan dalam memilih metode kontrasepsi, termasuk dukungan sosial, norma budaya, pendidikan, persepsi masyarakat, dan keyakinan agama.

Riwayat Medis

Catatan kesehatan individu yang mencakup penyakit atau kondisi medis sebelumnya, pengalaman penggunaan kontrasepsi sebelumnya, serta efek samping atau alergi terhadap obat tertentu.

Teknik Komunikasi dan Konseling KB

Metode yang digunakan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi kontrasepsi secara jelas dan mudah dimengerti, serta menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka sehingga klien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan penuh pemahaman.

I. Daftar Pustaka

- Agustina, R., & Nurhaeni, N. (2020). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan metode kontrasepsi pada wanita usia subur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2), 85-94. <https://doi.org/10.22435/kespro.v7i2.2935>
- Ariawan, I., Utomo, B., & Hastuti, D. (2021). Pengambilan keputusan keluarga berencana: Perspektif informed choice. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(1), 37-45. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v16i1.4567>
- BKKBN. (2020). Panduan Praktik Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Hak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Fitriani, E., Rohmani, N., & Handayani, S. (2019). Hubungan komunikasi interpersonal dalam konseling KB terhadap keputusan pemilihan metode kontrasepsi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22(3), 157-164. <https://doi.org/10.7454/jki.v22i3.993>
- Handayani, S., & Andriyani, A. (2021). Strategi konseling keluarga berencana berbasis informed choice. *Jurnal Ilmu Kebidanan Indonesia*, 11(1), 15-23. <https://doi.org/10.33859/jiki.v11i1.1234>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Pedoman Nasional Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Kemenkes RI.
- Khasanah, U., & Mahmudah, S. (2020). Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemilihan kontrasepsi. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 5(1), 23-30. <https://doi.org/10.35730/jkkt.v5i1.2347>
- Lubis, R., & Marpaung, F. (2021). Efektivitas komunikasi terapeutik dalam pelayanan keluarga berencana di puskesmas. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 3(2), 89-98. <https://doi.org/10.37275/jkk.v3i2.427>
- Notoatmodjo, S. (2022). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.

- Putri, A. M., & Susilowati, E. (2020). Analisis dampak pemilihan metode kontrasepsi terhadap kesehatan reproduksi wanita. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 11(2), 132-140. <https://doi.org/10.35890/jkri.v11i2.567>
- Rahmawati, F., & Sari, D. E. (2021). Pengaruh konseling terhadap keputusan pemilihan kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Indonesian Journal of Nursing Practices*, 5(1), 45-52. <https://doi.org/10.18196/ijnp.51101>
- Setiawati, T., & Sudarti, S. (2021). Faktor budaya dan agama dalam pemilihan metode kontrasepsi di masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 211-220. <https://doi.org/10.33023/jish.v10i2.789>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Family planning: A global handbook for providers*. WHO Press.
- Zulkifli, A., & Permana, I. (2019). Komunikasi efektif dalam konseling keluarga berencana. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Penyuluhan*, 6(2), 101-110. <https://doi.org/10.35315/jikp.v6i2.3246>

BAB 4

UPAYA-UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF TERKAIT DENGAN PERENCANAAN KELUARGA DAN KONTRASEPSI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu melaksanakan upaya promotif dan preventif yang efektif dalam perencanaan keluarga dan pelayanan kontrasepsi guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara optimal.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, tujuan, dan pentingnya penerapan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan keluarga berencana serta mampu merancang dan menerapkan kegiatan promotif dan preventif secara tepat di masyarakat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya upaya promotif dalam perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi.
- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya upaya preventif dalam perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi.
- Merancang strategi kegiatan promotif terkait perencanaan keluarga yang efektif di masyarakat.
- Merancang strategi kegiatan preventif terkait perencanaan keluarga dan kontrasepsi yang efektif di masyarakat.
- Mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif serta menemukan solusi praktis yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Pendahuluan

Program keluarga berencana (KB) merupakan upaya strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang bertujuan mengatur jarak kelahiran, jumlah anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan program KB tidak

terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara sistematis. Upaya promotif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta sikap positif masyarakat terhadap perencanaan keluarga. Sementara itu, upaya preventif bertujuan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mengurangi risiko kesehatan ibu dan anak, serta mencegah berbagai permasalahan sosial yang dapat timbul akibat perencanaan keluarga yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang pentingnya upaya promotif dan preventif dalam konteks KB sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat umum.

A. Upaya Promotif dalam Perencanaan Keluarga dan Kontrasepsi

Upaya promotif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta sikap positif masyarakat terhadap manfaat perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif agar masyarakat dapat secara sadar dan bertanggung jawab mengambil keputusan terkait jumlah anak yang diinginkan, jarak antar kelahiran, dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau pasangan.

Salah satu pendekatan utama dalam upaya promotif adalah melalui edukasi kesehatan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Edukasi kesehatan mencakup penyampaian informasi mengenai berbagai metode kontrasepsi, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta pentingnya pengaturan jarak kelahiran demi kesehatan ibu dan anak. Edukasi ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional seperti bidan, perawat, dokter, dan kader kesehatan masyarakat yang telah dilatih secara khusus untuk menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selain edukasi langsung, kegiatan penyuluhan juga menjadi bagian integral dari upaya promotif. Penyuluhan umumnya dilaksanakan secara berkala di tingkat komunitas seperti Posyandu, Puskesmas, atau dalam kegiatan masyarakat lainnya. Dalam penyuluhan, masyarakat didorong untuk berdiskusi secara aktif dan terbuka mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Melalui kegiatan ini, mitos, stigma, dan miskonsepsi yang masih berkembang di masyarakat dapat diluruskan, sehingga keputusan yang diambil terkait KB benar-benar berdasarkan fakta dan informasi yang akurat.

Selain itu, kampanye sosial yang lebih luas juga berperan signifikan dalam upaya promotif ini. Kampanye sosial dilakukan melalui berbagai platform komunikasi, baik cetak seperti brosur, pamflet, majalah kesehatan, maupun digital seperti media sosial, website, aplikasi mobile, radio, dan televisi. Pemanfaatan media komunikasi digital menjadi semakin penting, mengingat luasnya jangkauan dan tingginya penggunaan internet oleh berbagai lapisan masyarakat. Kampanye sosial umumnya dirancang secara menarik, kreatif, dan persuasif agar pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian masyarakat, terutama kelompok usia produktif dan pasangan muda yang menjadi target utama dari program KB.

Lebih jauh lagi, upaya promotif dalam KB juga mengedepankan strategi komunikasi interpersonal melalui keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta influencer lokal. Pelibatan tokoh-tokoh ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan sosial dan budaya terhadap program KB, sekaligus mengurangi hambatan-hambatan psikologis maupun sosial yang sering menjadi tantangan dalam implementasi program ini. Dengan tokoh-tokoh lokal yang memberikan dukungan secara terbuka, masyarakat cenderung lebih percaya dan merasa nyaman untuk mengadopsi perilaku sehat dalam hal perencanaan keluarga.

Dalam konteks global, upaya promotif juga sering didukung oleh program-program pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), serta kerjasama lintas sektor. Dukungan ini penting guna menjamin kontinuitas dan keberlanjutan promosi KB yang efektif serta berbasis bukti. Evaluasi berkala terhadap dampak dan efektivitas kegiatan promotif juga menjadi bagian penting, guna memastikan strategi yang digunakan benar-benar mampu mencapai tujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku positif terkait KB dan kontrasepsi.

Dengan demikian, berbagai upaya promotif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi merupakan elemen kunci untuk memastikan tercapainya keluarga yang sejahter dan sejahtera melalui peningkatan pemahaman, kesadaran, serta penerimaan masyarakat terhadap konsep keluarga berencana sebagai bagian integral dari kehidupan sehat.

B. Upaya Preventif dalam Perencanaan Keluarga dan Kontrasepsi

Upaya preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi merupakan suatu rangkaian tindakan atau intervensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya bertujuan mengurangi risiko berbagai komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun anak. Tujuan utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa setiap kehamilannya merupakan hasil dari perencanaan yang matang, sehingga dapat memberikan dampak positif pada kesehatan keluarga, kesejahteraan ekonomi, serta kestabilan sosial secara luas.

Salah satu komponen inti dari upaya preventif ini adalah penyediaan layanan kontrasepsi yang aman dan efektif. Layanan kontrasepsi mencakup berbagai jenis metode yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau pasangan, kondisi kesehatan, preferensi pribadi, serta kondisi sosial-ekonomi. Berbagai pilihan metode kontrasepsi tersedia, mulai dari metode hormonal seperti pil KB, suntik KB, implan atau susuk, metode kontrasepsi intrauterine seperti IUD (spiral), hingga metode

non-hormonal seperti kondom, diafragma, dan metode alami seperti kalender atau pantang berkala. Penyedia layanan kesehatan bertugas memberikan informasi lengkap dan mendetail mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing metode tersebut, sehingga calon pengguna kontrasepsi dapat membuat keputusan yang tepat sesuai kebutuhannya.

Selain ketersediaan berbagai pilihan metode kontrasepsi, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kontrasepsi juga menjadi elemen penting dalam upaya preventif ini. Akses terhadap kontrasepsi berarti bahwa layanan tersebut tidak hanya tersedia tetapi juga mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti klinik kesehatan keluarga, Puskesmas, Posyandu, maupun layanan kesehatan bergerak. Pemerintah dan stakeholder terkait juga terus melakukan inovasi, misalnya dengan menyediakan layanan kontrasepsi gratis atau subsidi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, yang bertujuan mengurangi hambatan biaya yang sering menjadi kendala utama dalam mengakses layanan kontrasepsi.

Lebih lanjut, edukasi mengenai cara penggunaan kontrasepsi yang benar, aman, dan efektif juga merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya preventif ini. Kesalahan penggunaan metode kontrasepsi, seperti lupa meminum pil secara teratur, salah memahami metode kalender, atau pemasangan alat kontrasepsi yang kurang tepat, dapat menyebabkan efektivitas kontrasepsi menurun drastis, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, petugas kesehatan dituntut untuk memberikan edukasi yang jelas, rinci, dan mudah dipahami tentang cara pemakaian, kemungkinan efek samping, tanda bahaya, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi masalah dalam penggunaan kontrasepsi. Edukasi ini biasanya diberikan melalui konsultasi langsung, penyuluhan kelompok, maupun media edukasi yang informatif seperti leaflet, video, dan aplikasi digital yang mudah diakses masyarakat.

Penting juga untuk diperhatikan bahwa dalam upaya preventif ini, pelayanan kontrasepsi harus selalu mempertimbangkan aspek keamanan medis. Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan profesional, sebelum menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan, merupakan langkah penting untuk menghindari komplikasi kesehatan, seperti efek samping yang tidak diinginkan ataupun komplikasi medis yang serius. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan preventif menekankan pada skrining kesehatan sebelum pemakaian kontrasepsi, pemantauan rutin selama pemakaian kontrasepsi, serta konseling

berkelanjutan guna memastikan bahwa pengguna kontrasepsi tetap aman dan nyaman dalam menjalani metode yang dipilihnya.

Selain itu, upaya preventif dalam perencanaan keluarga juga harus melibatkan peran serta aktif dari masyarakat, khususnya keluarga dan pasangan. Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya merencanakan jumlah anak, jarak antar kehamilan, serta manfaat jangka panjang dari penggunaan kontrasepsi secara konsisten dan tepat. Keterlibatan pasangan, terutama suami, juga sangat penting agar tercipta kesepakatan bersama tentang perencanaan keluarga yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Dengan pelaksanaan yang tepat dan efektif dari berbagai aspek tersebut, upaya preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi tidak hanya mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan tetapi juga mampu memperbaiki kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Upaya ini merupakan investasi jangka panjang dalam mewujudkan kesehatan reproduksi yang optimal serta kesejahteraan keluarga yang lebih baik, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

C. Strategi Promotif yang Efektif

Strategi promotif yang efektif dalam konteks perencanaan keluarga dan kontrasepsi memerlukan perencanaan matang yang melibatkan pendekatan terpadu dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keefektifan strategi promotif sangat bergantung pada bagaimana strategi tersebut mampu mengakomodasi karakteristik masyarakat sasaran, baik dari segi budaya, kepercayaan, adat-istiadat, maupun kondisi sosial-ekonomi mereka. Strategi ini bukanlah pendekatan tunggal, melainkan gabungan dari beberapa metode yang diintegrasikan secara harmonis untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara optimal.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam implementasi strategi promotif adalah pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai mitra aktif dalam program, bukan sekadar penerima pasif dari pesan-pesan kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, proses edukasi dan promosi perencanaan keluarga dilakukan secara partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan program, implementasi, hingga evaluasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan promotif ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, sehingga program yang berjalan dapat berkelanjutan dan lebih diterima oleh masyarakat. Misalnya, melalui kelompok diskusi masyarakat (community discussion groups), masyarakat dapat mengidentifikasi secara mandiri

hambatan-hambatan dalam perencanaan keluarga dan secara kolektif menentukan solusi yang tepat berdasarkan konteks lokal.

Selain pendekatan berbasis masyarakat, keterlibatan kader kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam strategi promotif yang efektif. Kader kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lapangan. Mereka biasanya berasal dari masyarakat lokal dan telah menerima pelatihan khusus mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta metode kontrasepsi. Keunggulan dari keterlibatan kader ini adalah kemampuan mereka dalam memahami budaya lokal, bahasa sehari-hari, serta kebiasaan masyarakat di daerahnya. Mereka mampu menyampaikan pesan kesehatan secara lebih efektif dan akrab dibandingkan tenaga profesional dari luar yang mungkin tidak terlalu memahami budaya setempat. Kader kesehatan juga memainkan peran penting dalam melakukan kunjungan rumah secara rutin, memantau kondisi kesehatan keluarga, serta memberikan dukungan langsung dalam edukasi kontrasepsi, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap program KB.

Pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari strategi promotif juga semakin penting dan relevan di era digital saat ini. Media sosial menawarkan peluang yang sangat besar untuk menjangkau berbagai kelompok usia, terutama generasi muda dan usia produktif yang umumnya aktif menggunakan platform digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, maupun TikTok. Melalui media sosial, pesan mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan informasi kontrasepsi dapat dikemas secara kreatif, menarik, dan interaktif, sehingga lebih mudah menarik perhatian audiens. Strategi ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi dengan cepat, luas, serta memungkinkan adanya interaksi langsung antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi yang aktual, terupdate, serta edukatif dengan biaya yang relatif rendah, sehingga sangat efisien untuk menjangkau kelompok besar secara cepat dan masif.

Strategi lain yang sangat efektif adalah pendidikan berbasis keluarga. Pendidikan berbasis keluarga berpusat pada rumah tangga sebagai unit edukasi utama, mengingat keluarga adalah lingkungan pertama tempat individu memperoleh nilai, norma, dan perilaku. Dalam konteks ini, edukasi tentang perencanaan keluarga dan kontrasepsi tidak hanya ditujukan kepada individu yang sudah menikah, melainkan juga kepada remaja dan orang dewasa muda yang sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Pendidikan berbasis keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga dalam diskusi mengenai pentingnya mengatur jumlah anak, manfaat kontrasepsi, serta implikasi kesehatan jangka panjang dari kehamilannya yang tidak direncanakan. Dengan pendidikan yang

dilakukan di lingkungan keluarga, setiap individu sejak dini memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, yang pada akhirnya membantu mencegah berbagai masalah kesehatan reproduksi di kemudian hari.

Selain mempertimbangkan berbagai pendekatan tersebut, penting pula bahwa setiap strategi promotif dirancang secara fleksibel dan adaptif terhadap konteks budaya serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah atau komunitas yang masih memegang teguh tradisi tertentu, pendekatan promotif harus dikemas dengan metode sederhana, menggunakan bahasa lokal, serta melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediator informasi. Di sisi lain, dalam komunitas perkotaan yang lebih modern dan terdidik, pendekatan promotif bisa dikembangkan dengan pendekatan digital, webinar edukasi, serta kampanye sosial yang bersifat interaktif dan inovatif.

Keseluruhan strategi promotif tersebut, bila diterapkan secara terintegrasi dan konsisten, akan mampu menciptakan perubahan perilaku masyarakat yang positif terhadap perencanaan keluarga dan kontrasepsi, sekaligus memastikan bahwa setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, terencana, dan berkualitas. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, tujuan akhir dari program keluarga berencana dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas tinggi dapat tercapai secara optimal.

D. Strategi Preventif yang Efektif

Strategi preventif yang efektif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi memerlukan implementasi berbagai langkah komprehensif yang bertujuan untuk memastikan agar kehamilan tidak direncanakan dapat dicegah secara optimal. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada tersedianya berbagai alat kontrasepsi saja, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting yang memastikan masyarakat dapat secara mudah, aman, dan terjangkau mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang dibutuhkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap keluarga memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Peningkatan akses terhadap metode kontrasepsi merupakan elemen kunci dalam strategi preventif yang efektif. Akses terhadap metode kontrasepsi tidak hanya berarti alat kontrasepsi tersedia di fasilitas kesehatan, melainkan juga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil, daerah dengan keterbatasan infrastruktur, maupun mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Peningkatan akses ini diwujudkan melalui penguatan jaringan layanan kesehatan yang mencakup Puskesmas, klinik kesehatan

keluarga, Posyandu, hingga pelayanan kesehatan keliling yang rutin menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menyediakan layanan kontrasepsi gratis atau bersubsidi juga merupakan langkah penting dalam memperluas akses, sehingga masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat memilih dan menggunakan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya tanpa terkendala biaya.

Dalam memastikan efektivitas strategi preventif ini, pelatihan tenaga kesehatan menjadi aspek yang sangat krusial. Tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan kader kesehatan, harus dilatih secara khusus untuk memberikan konseling KB yang efektif dan komprehensif. Pelatihan tersebut mencakup berbagai materi penting, mulai dari pemahaman mendalam tentang masing-masing metode kontrasepsi, teknik komunikasi dan konseling yang baik, hingga kemampuan menangani berbagai situasi klinis maupun psikososial yang mungkin terjadi dalam praktik pelayanan KB. Melalui pelatihan yang terstruktur, tenaga kesehatan akan mampu memberikan pelayanan kontrasepsi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi, melainkan juga pada peningkatan kepercayaan dan motivasi pengguna kontrasepsi untuk secara konsisten dan tepat dalam menggunakan alat kontrasepsi. Konseling KB yang baik memastikan bahwa setiap klien mendapatkan informasi lengkap, mampu memilih metode kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan, preferensi pribadi, serta kebutuhan sosial-ekonominya.

Strategi preventif yang efektif juga melibatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi secara kontinu. Tidak jarang ditemukan situasi di mana pengguna kontrasepsi mengalami kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi karena stok yang tidak teratur atau bahkan kosong di fasilitas kesehatan terdekat. Oleh karena itu, strategi preventif yang efektif harus didukung oleh sistem logistik dan manajemen persediaan alat kontrasepsi yang andal dan efisien. Sistem ini mencakup perencanaan pengadaan yang baik, distribusi yang tepat waktu ke seluruh fasilitas kesehatan, serta monitoring ketat yang memastikan stok kontrasepsi selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan siap digunakan kapan saja. Dengan memastikan ketersediaan alat kontrasepsi secara kontinu, maka risiko terputusnya pemakaian kontrasepsi dapat ditekan, yang pada akhirnya akan mengurangi kejadian kehamilan yang tidak direncanakan secara signifikan.

Selain itu, memastikan bahwa alat kontrasepsi tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam strategi preventif yang efektif. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan lembaga terkait perlu mengupayakan kebijakan yang mendukung subsidi harga atau bahkan layanan kontrasepsi gratis untuk kelompok masyarakat tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi yang sering kali menjadi faktor

utama mengapa masyarakat tidak menggunakan atau berhenti menggunakan alat kontrasepsi tertentu, meskipun mereka membutuhkannya. Dalam jangka panjang, kebijakan subsidi atau kontrasepsi gratis ini menjadi investasi kesehatan yang efektif, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk menangani berbagai komplikasi kesehatan akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Lebih jauh lagi, strategi preventif ini harus bersifat inklusif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai manfaat penggunaan kontrasepsi, serta dilibatkan dalam program-program komunitas yang berorientasi pada pencegahan kehamilan tidak direncanakan. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuka adat dalam program KB merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan sosial-budaya terhadap penggunaan kontrasepsi, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung dan kondusif untuk implementasi strategi preventif secara berkelanjutan.

Kesimpulannya, strategi preventif yang efektif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi memerlukan integrasi berbagai elemen penting seperti aksesibilitas layanan, kapasitas tenaga kesehatan yang memadai dalam memberikan konseling, serta sistem pengelolaan persediaan kontrasepsi yang andal dan terjangkau. Semua elemen tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, akan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk secara sadar dan konsisten menggunakan kontrasepsi demi mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

E. Hambatan dan Solusi dalam Upaya Promotif dan Preventif

Pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi sering kali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, yang berasal dari berbagai aspek seperti sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, hingga sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Memahami hambatan-hambatan ini secara mendalam adalah langkah awal penting agar solusi yang tepat dapat dirancang, sehingga upaya promotif dan preventif bisa terlaksana dengan optimal dan berhasil mencapai tujuannya.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif adalah faktor budaya yang kuat di masyarakat. Di banyak komunitas, norma-norma tradisional dan nilai budaya tertentu masih mendominasi pandangan masyarakat terhadap perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi.

Contohnya, di beberapa daerah masih terdapat kepercayaan bahwa banyak anak adalah sumber rezeki, atau bahwa menggunakan alat kontrasepsi bertentangan dengan nilai agama atau adat-istiadat setempat. Kondisi budaya seperti ini menyebabkan resistensi terhadap pesan-pesan KB yang disampaikan tenaga kesehatan, sehingga pesan tersebut tidak mudah diterima atau bahkan ditolak secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pula kepercayaan terhadap mitos-mitos negatif mengenai penggunaan kontrasepsi, seperti efek samping yang berlebihan atau ketakutan terhadap gangguan kesehatan, yang memperparah penolakan terhadap upaya-upaya promotif dan preventif yang dilakukan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi hambatan yang signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif KB. Rendahnya pendidikan masyarakat membuat mereka kurang mampu memahami informasi kesehatan yang kompleks atau teknis, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan metode kontrasepsi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai manfaat KB juga menyebabkan masyarakat kurang termotivasi atau kurang percaya diri dalam memilih dan menggunakan kontrasepsi yang tepat untuk kebutuhan mereka sendiri. Hal ini juga berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran akan hak reproduksi serta pentingnya perencanaan keluarga sebagai bagian dari kehidupan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau terisolasi secara geografis. Banyak masyarakat yang tinggal di wilayah ini sulit mendapatkan akses pelayanan kontrasepsi yang memadai, baik karena fasilitas kesehatan yang jaraknya terlalu jauh, infrastruktur transportasi yang buruk, atau keterbatasan ketersediaan metode kontrasepsi di fasilitas kesehatan setempat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya tenaga kesehatan yang terampil, yang mampu memberikan konseling dan edukasi kontrasepsi yang baik. Akibatnya, meskipun masyarakat memiliki keinginan menggunakan kontrasepsi, mereka mengalami hambatan fisik dan teknis yang signifikan dalam mengakses layanan tersebut.

Selain hambatan di atas, stigma sosial juga merupakan hambatan serius dalam upaya promotif dan preventif KB. Di beberapa lingkungan masyarakat, penggunaan kontrasepsi atau membicarakan perencanaan keluarga secara terbuka masih dianggap tabu, tidak sopan, atau bahkan menimbulkan rasa malu. Hal ini menyebabkan banyak individu, terutama perempuan dan remaja, enggan membicarakan kebutuhan kontrasepsi mereka secara terbuka dengan tenaga kesehatan atau bahkan anggota keluarga sendiri. Stigma ini membuat mereka terisolasi secara sosial, sehingga sulit mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan perencanaan keluarga secara efektif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan solusi-solusi yang terpadu dan strategis. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan advokasi pada pemangku kebijakan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Melalui advokasi, pemangku kebijakan dapat lebih memahami pentingnya program KB dan merumuskan kebijakan yang lebih berpihak, seperti penyediaan dana khusus untuk program KB, pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemberian subsidi kontrasepsi yang lebih luas bagi masyarakat yang kurang mampu. Advokasi ini juga penting untuk memastikan komitmen politik yang kuat dan konsisten dalam mendukung program keluarga berencana.

Selain itu, solusi efektif lainnya adalah mengembangkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai institusi, seperti dinas kesehatan, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta institusi agama. Kolaborasi lintas sektor memungkinkan program KB mendapatkan dukungan yang lebih luas dan komprehensif, sehingga mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Kolaborasi ini juga membuka peluang adanya inovasi program yang mampu mengatasi hambatan pendidikan dan akses pelayanan, seperti program edukasi KB berbasis sekolah, pelayanan kesehatan keliling, atau inovasi digital dalam promosi kesehatan reproduksi.

Pelibatan tokoh masyarakat merupakan solusi yang sangat penting dan strategis dalam upaya mengatasi hambatan sosial-budaya serta stigma sosial. Tokoh masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, maupun pemimpin informal lainnya, memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan sikap masyarakat. Dengan melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan edukasi, penyuluhan, dan kampanye KB, maka pesan kesehatan yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani antara nilai budaya lokal dengan kebutuhan perencanaan keluarga yang modern, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan tradisi atau norma yang mereka yakini.

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan juga harus terus dilakukan secara konsisten dan terencana. Dengan tenaga kesehatan yang lebih kompeten dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, maka pelayanan KB yang diberikan akan lebih berkualitas, informatif, dan bersahabat. Ini akan memperbesar kemungkinan masyarakat mau menerima dan memanfaatkan layanan kontrasepsi secara optimal.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi yang komprehensif ini, maka berbagai hambatan dalam kegiatan promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi dapat diminimalkan atau bahkan diatasi sepenuhnya. Hasilnya adalah terwujudnya lingkungan sosial yang mendukung, akses yang mudah

dan terjangkau terhadap kontrasepsi, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap manfaat dan pentingnya perencanaan keluarga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perawat komunitas sedang merencanakan kegiatan promotif tentang keluarga berencana (KB) di suatu desa terpencil. Desa tersebut memiliki budaya yang percaya bahwa banyak anak berarti banyak rezeki. Upaya awal apakah yang paling efektif dilakukan oleh perawat agar kegiatan promotif berhasil?

- A. Mengadakan penyuluhan massal langsung di balai desa
- B. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk promosi KB
- C. Melibatkan tokoh masyarakat lokal dalam perencanaan program KB
- D. Membagikan brosur KB kepada masyarakat
- E. Memberikan ceramah di Puskesmas desa terdekat

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Melibatkan tokoh masyarakat lokal merupakan strategi promotif yang efektif, khususnya di masyarakat dengan norma budaya kuat. Tokoh lokal lebih dipercaya masyarakat dan efektif mengurangi resistensi terhadap konsep KB.

Soal 2

Di suatu wilayah, ditemukan tingginya angka kehamilan tidak direncanakan akibat rendahnya pengetahuan perempuan tentang penggunaan pil KB secara tepat. Sebagai perawat, langkah preventif apa yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini?

- A. Mengganti pil KB dengan metode kondom
- B. Memberikan edukasi rinci tentang cara penggunaan pil KB yang benar
- C. Menyediakan layanan kontrasepsi hormonal secara gratis
- D. Melakukan kampanye media sosial tentang pentingnya KB
- E. Mengajukan metode kontrasepsi permanen

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Edukasi yang rinci tentang cara penggunaan pil KB yang benar merupakan langkah preventif paling efektif untuk memastikan efektivitas metode kontrasepsi dan mencegah kehamilan tidak direncanakan akibat kesalahan penggunaan.

Soal 3

Seorang bidan di Posyandu mendapatkan keluhan dari beberapa pasangan muda bahwa stok kontrasepsi di Puskesmas sering kosong sehingga menghambat kelanjutan program KB mereka. Strategi preventif apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini?

- A. Melakukan penyuluhan rutin tentang pentingnya KB
- B. Memberikan layanan konseling KB secara intensif
- C. Mengadvokasi penguatan sistem logistik persediaan kontrasepsi
- D. Melakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan di Puskesmas
- E. Mengadakan kampanye media sosial secara berkala

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Penguatan sistem logistik persediaan kontrasepsi memastikan ketersediaan alat kontrasepsi secara kontinu, menghindari terputusnya pemakaian kontrasepsi yang menjadi faktor utama kegagalan program KB.

Soal 4

Di suatu kecamatan ditemukan stigma negatif yang tinggi terhadap wanita pengguna KB hormonal, dengan keyakinan bahwa metode tersebut menyebabkan infertilitas permanen. Strategi promotif mana yang paling tepat dilakukan oleh tenaga kesehatan?

- A. Memberikan edukasi berbasis keluarga tentang manfaat KB hormonal
- B. Menyediakan kontrasepsi gratis di Puskesmas terdekat
- C. Melakukan kampanye digital di platform YouTube
- D. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di desa
- E. Mengganti metode kontrasepsi hormonal dengan IUD secara massal

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Edukasi berbasis keluarga efektif mengatasi stigma sosial karena melibatkan seluruh anggota keluarga untuk memahami secara bersama-sama manfaat dan risiko KB hormonal sehingga stigma negatif dapat diluruskan secara bertahap.

Soal 5

Perawat di suatu desa terpencil menemukan hambatan berupa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menyebabkan kesulitan dalam memahami informasi KB yang bersifat teknis. Apa solusi terbaik yang dapat dilakukan perawat dalam situasi ini?

- A. Menggunakan istilah medis sederhana dan bahasa lokal dalam penyuluhan
- B. Menyebarkan brosur tentang metode KB di tempat umum
- C. Melakukan penyuluhan melalui media sosial
- D. Menyarankan masyarakat menggunakan metode KB yang paling mudah didapat
- E. Memberikan metode kontrasepsi secara gratis

Kunci Jawaban: A

Rasional:

Menggunakan bahasa lokal dan istilah medis sederhana sangat penting pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah agar pesan tentang KB mudah dipahami, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi promotif maupun preventif.

G. Rangkuman Materi

Upaya promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi merupakan elemen penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Upaya promotif secara aktif meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan sikap positif masyarakat melalui edukasi kesehatan, penyuluhan secara berkala, kampanye sosial berbasis media, serta komunikasi interpersonal yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Upaya ini menciptakan lingkungan kondusif di mana masyarakat secara sadar dapat mengambil keputusan terkait jumlah anak, jarak kelahiran, serta memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan individu maupun keluarga.

Sementara itu, upaya preventif berfokus pada pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan melalui penyediaan layanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan mudah diakses. Upaya ini didukung oleh edukasi intensif mengenai cara penggunaan kontrasepsi yang benar, serta pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan konseling yang informatif dan terpercaya. Strategi preventif juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan KB di seluruh wilayah, ketersediaan alat kontrasepsi yang kontinu, serta kebijakan subsidi atau layanan kontrasepsi gratis bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun, implementasi kegiatan promotif dan preventif ini menghadapi berbagai hambatan kompleks seperti faktor budaya yang kuat, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan stigma sosial terkait penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasinya, seperti melakukan advokasi intensif kepada pemangku kebijakan, mengembangkan kolaborasi lintas sektor, serta secara aktif melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam edukasi dan kampanye kesehatan

reproduksi. Solusi-solusi tersebut mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam penerimaan sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KB, serta mengatasi tantangan budaya dan stigma yang selama ini menjadi kendala.

Dengan penerapan strategi promotif dan preventif yang efektif serta solusi yang terintegrasi dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya masyarakat, tujuan akhir dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, serta sadar akan pentingnya perencanaan keluarga dapat tercapai secara optimal. Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada aspek kesehatan fisik dan mental keluarga, tetapi juga secara jangka panjang memperkuat kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan.

H. Glosarium

Advokasi

Proses pemberian informasi dan dorongan kepada para pemangku kebijakan agar mendukung dan mengadopsi kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, dalam hal ini untuk mendukung program keluarga berencana (KB).

Aksesibilitas

Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan atau memanfaatkan layanan kontrasepsi, baik dari aspek jarak geografis, ketersediaan sarana kesehatan, maupun biaya yang terjangkau.

Edukasi Berbasis Keluarga

Pendekatan edukasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga sebagai unit pendidikan utama, bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi.

Edukasi Kesehatan

Proses penyampaian informasi kesehatan secara sistematis oleh tenaga kesehatan profesional kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif terkait perencanaan keluarga.

Hambatan Budaya

Nilai-nilai, kepercayaan, atau adat istiadat dalam masyarakat yang bertentangan atau menghambat penerimaan terhadap penggunaan metode kontrasepsi dan konsep perencanaan keluarga.

Kader Kesehatan

Individu dari masyarakat lokal yang telah mendapat pelatihan khusus untuk membantu petugas kesehatan dalam melakukan edukasi, promosi, serta penyuluhan terkait keluarga berencana di lingkungan masyarakatnya.

Kampanye Sosial

Kegiatan komunikasi publik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai media komunikasi seperti brosur, pamflet, televisi, radio, dan media sosial tentang manfaat KB dan kontrasepsi.

Keluarga Berencana (KB)

Suatu gerakan atau program yang bertujuan mengatur jumlah anak, jarak antar kelahiran, dan waktu kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi, demi terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama antara berbagai institusi atau sektor seperti kesehatan, pendidikan, pemerintah, LSM, swasta, dan agama, guna memperkuat pelaksanaan program KB secara efektif dan komprehensif.

Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi yang menggunakan hormon buatan untuk mencegah kehamilan, seperti pil KB, suntikan KB, dan implan atau susuk.

Kontrasepsi Non-Hormonal

Metode kontrasepsi yang tidak mengandung hormon, seperti kondom, diafragma, atau alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) yang berbahan tembaga.

Konseling KB

Proses pemberian informasi serta diskusi mendalam antara tenaga kesehatan dan individu atau pasangan tentang pemilihan dan penggunaan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Metode Alami

Teknik pencegahan kehamilan dengan mengandalkan pengamatan siklus menstruasi perempuan seperti metode kalender atau pantang berkala.

Metode Kontrasepsi

Cara atau teknik yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan, tersedia dalam bentuk hormonal, non-hormonal, maupun alami.

Pemangku Kebijakan

Individu atau kelompok yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program KB dan kesehatan reproduksi.

Penyuluhan Kesehatan

Aktivitas edukasi dan diskusi kesehatan yang dilakukan secara rutin di komunitas untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait penggunaan kontrasepsi dan pentingnya perencanaan keluarga.

Preventif

Upaya pencegahan yang dilakukan secara sistematis untuk menghindari terjadinya kehamilan tidak direncanakan melalui pemberian layanan kontrasepsi yang mudah, aman, dan efektif.

Promotif

Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta sikap positif masyarakat mengenai manfaat perencanaan keluarga melalui edukasi, kampanye sosial, dan penyuluhan kesehatan.

Skrining Kesehatan

Pemeriksaan medis awal yang dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan calon pengguna kontrasepsi sebelum pemilihan dan penggunaan metode kontrasepsi tertentu, guna mencegah risiko komplikasi kesehatan.

Stigma Sosial

Pandangan negatif atau tabu dalam masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi, yang sering menyebabkan rasa malu atau ketidaknyamanan seseorang dalam menggunakan layanan KB.

Strategi Berbasis Masyarakat

Pendekatan dalam program KB yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap program tersebut.

Tenaga Kesehatan Profesional

Orang-orang yang terlatih secara formal dalam bidang kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan, yang bertanggung jawab atas penyampaian layanan kesehatan reproduksi dan edukasi KB secara profesional.

I. Daftar Pustaka

- BKKBN. (2021). Rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2020-2024. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dewi, R. K., & Andriani, R. (2022). Efektivitas edukasi berbasis masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap penggunaan kontrasepsi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi Indonesia*, 13(2), 120–128. <https://doi.org/10.22435/kespro.v13i2.5580>
- Hastuti, Y. S., & Nugroho, A. S. (2020). Hambatan sosio-budaya dalam program keluarga berencana di pedesaan: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(1), 35–45. <https://doi.org/10.14710/jpki.v15i1.28925>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan keluarga berencana di fasilitas kesehatan primer. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Mahmudah, R., & Ratnasari, D. (2021). Pengaruh edukasi keluarga terhadap persepsi dan penggunaan kontrasepsi hormonal pada pasangan usia subur. *Journal of Midwifery and Public Health*, 3(2), 135–142. <https://doi.org/10.25157/jmph.v3i2.5520>
- Nurjanah, S., & Kusumawati, D. A. (2022). Strategi pemberdayaan kader kesehatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berencana di daerah terpencil. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 18(1), 51–57. <https://doi.org/10.30659/jikk.18.1.51-57>
- Putri, S. A., & Fitriani, D. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pelayanan kontrasepsi di wilayah perbatasan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 77–84. <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.2.2021.77-84>
- Rahmawati, L., & Wardani, E. (2022). Pengaruh kampanye sosial melalui media sosial terhadap sikap generasi muda terhadap penggunaan kontrasepsi. *Indonesian*

Journal of Health Promotion and Behavior, 4(1), 30–38.
<https://doi.org/10.26911/theijhpb.2022.04.01.04>

Setiawan, D., & Pratiwi, E. W. (2020). Pelatihan tenaga kesehatan dalam konseling keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(2), 98–105.
<https://doi.org/10.33024/jik.v11i2.3196>

Susanti, R., & Yuliana, I. (2020). Evaluasi efektivitas pelayanan kontrasepsi gratis dalam menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan di perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(4), 146–154.
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i4.3237>

World Health Organization (WHO). (2020). Family planning/contraception methods and guidelines. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/contraception>

Yuliani, M., & Saputra, A. (2021). Upaya advokasi lintas sektor dalam peningkatan pelayanan kontrasepsi di daerah dengan akses terbatas. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(2), 89–97. <https://doi.org/10.22146/jkki.60795>

BAB 5

KONSELING KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN, DAN KONTRASEPSI DARURAT

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip konseling kontrasepsi berdasarkan metode yang tersedia (sederhana, alami, modern, dan darurat) untuk membantu individu atau pasangan dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu memahami Konsep Konseling Kontrasepsi (pengertian, tujuan, dan manfaat konseling kontrasepsi, Prinsip Konseling KB)
- Mahasiswa mampu menjelaskan Konseling dengan Metode sederhana / Tradisional (Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal dan Coitus Interruptus)
- Mahasiswa mampu menjelaskan Konseling dengan Metode Alami (MAL, Metode Sympto-thermal)
- Mahasiswa mampu menjelaskan Konseling dengan Metode Modern (Hormonal dan Non Hormonal)
- Mahasiswa mampu menjelaskan Konseling Kontrasepsi Darurat (Jenis, Indikasi, Efektivitas)
- Mahasiswa mampu Menerapkan Pendekatan individual dalam konseling kontrasepsi

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran Umum:

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memberikan layanan konseling kontrasepsi secara profesional dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based*), menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien, serta mempertimbangkan faktor medis, sosial, dan budaya dalam pemilihan metode kontrasepsi.

Capaian Pembelajaran Khusus (CPLK)

• Pengetahuan (Cognitive Domain)

- a. Mahasiswa memahami konsep dasar konseling kontrasepsi (Pengertian, tujuan, manfaat)
- b. Mahasiswa Menguraikan jenis-jenis metode kontrasepsi, baik sederhana, alami, modern, maupun kontrasepsi darurat.
- c. Mahasiswa menguraikan teknik komunikasi efektif dalam memberikan layanan konseling KB yang berorientasi pada kebutuhan klien.

• Keterampilan (Psychomotor Domain)

- a. Mahasiswa mampu melaksanakan sesi konseling KB dengan pendekatan komunikasi terapeutik dan berbasis empati.
- b. Mahasiswa mampu Membimbing klien dalam memahami cara penggunaan kontrasepsi.

• Sikap (Affective Domain)

- a. Mahasiswa menunjukkan sikap profesional, empati, dan menghargai hak klien dalam setiap proses konseling KB.
- b. Mahasiswa menghormati keputusan klien dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan keyakinan dan kondisinya.
- c. Mahasiswa Berkomitmen dalam memberikan layanan KB yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.
- d. Mahasiswa Menjaga etika dan kerahasiaan informasi klien dalam layanan konseling KB.

Seringkali efek samping dari penggunaan kontrasepsi menjadi faktor utama penyebab

putus pakai. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) melaporkan tingkat putus pakai kontrasepsi dalam satu tahun relatif tinggi, dan meningkat dari 27% tahun 2012 menjadi 29% tahun 2017. Efek samping timbul karena pilihan kontrasepsi yang kurang sesuai dan klien tidak memahami bagaimana mengatasi efek samping. Konseling kepada klien mengenai pemilihan kontrasepsi menjadi bagian penting dari pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas. Melalui konseling, petugas kesehatan penyedia layanan membantu klien memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan fertilitas dan Kesehatan mereka. Berdasarkan Laporan Family Planning 2020, kualitas konseling KB di Indonesia masih rendah, di tingkat indeks informasi metode hanya 30% pada tahun 2015-2017. Konseling yang baik dapat membantu ibu memilih kontrasepsi yang sesuai dan mengatasi efek samping yang mungkin timbul. Dengan kata lain, konseling KB yang baik dapat menurunkan tingkat putus KB. Modul Konseling KB ini menjelaskan cara memberikan konseling KB yang baik dengan menggunakan

Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB (ABPK) dan penapisan kriteria kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi (Roda KLOP). (RI, 2019)

Pendahuluan

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, keterampilan dalam memberikan konseling kontrasepsi menjadi hal yang esensial. Buku ini disusun sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan dalam memberikan konseling KB yang berkualitas, berbasis bukti, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien.

Sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi, saya menyusun buku ini berdasarkan pengalaman klinis, hasil penelitian, serta berbagai pedoman dan rekomendasi terkini. Harapannya, buku ini dapat membantu mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, dan praktisi KB dalam memahami serta menerapkan konseling kontrasepsi yang efektif dan berorientasi pada klien.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri dari Konsep Konseling Kontrasepsi, Konseling Metode sederhana / Tradisional, Konseling dengan Metode Alami, Konseling dengan Metode Modern (Hormonal / Non hormonal), Konseling kontrasepsi darurat.

A. Konsep Konseling Kontrasepsi

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah sebuah interaksi antara seorang konselor dan konseli yang bersifat diadic (dua arah) dan bertujuan meningkatkan kemampuan konseli. (Hartini & Ariana, 2016)

Konseling merupakan hubungan timbal balik antara konselor dan konseli. Hubungan tersebut bersifat profesional dan bertujuan untuk membantu konseli menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hubungan timbal balik antara konselor dan konseli dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena proses konseling kecil kemungkinan hanya terjadi satu kali pertemuan. (Agungbudiprabowo, 2021)

Konseling adalah proses pertukaran informasi dan interaksi positif antara klien-petugas untuk membantu klien mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Konseling merupakan tindak lanjut dari KIE dan dibutuhkan bila seseorang menghadapi suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri (Setyorini, 2020)

Konseling ialah pertemuan tatap muka antara kedua pihak, dimana satu pihak yang membantu pihak lain dalam mengambil keputusan secara tepat bagi dirinya sendiri dan kemudian melakukan tindakan sesuai dengan keputusannya. (Sukarni et al., 2020) Konseling merupakan proses yang berjalan dan menyatu dengan seluruh aspek pelayanan Keluarga Berencana. Dalam konseling tidak hanya memberikan informasi pada satu kali kesempatan saat pemberian pelayanan. Teknik konseling yang baik dan informasi yang memadai harus diterapkan dan didiskusikan secara lugas selama kunjungan klien dengan kaidah yang sesuai dengan budaya di dalam masyarakat tersebut. (Kusumawardani & Azizah, 2021)

Berdasarkan pengertian di atas Konseling merupakan proses interaksi profesional yang bersifat timbal balik antara konselor dan konseli dengan tujuan membantu konseli menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kemampuannya. Konseling tidak hanya berlangsung dalam satu pertemuan, tetapi dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan konseli. Selain sebagai bentuk pertukaran informasi dan interaksi positif,

konseling juga membantu klien dalam mengenali kebutuhannya, memilih solusi terbaik, dan membuat keputusan yang tepat. Sebagai bagian dari tindak lanjut Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling menjadi penting bagi individu yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Konseling Keluarga Berencana adalah proses komunikasi yang dibangun oleh penyedia layanan ditujukan kepada klien atau pasangan suami dan istri dengan kebutuhan berKB.(RI, 2019)

Menurut dari Sarwono, pengertian dari konseling ialah proses yang berjalan dan menyatu dengan semua aspek pelayanan KB dan bukan hanya informasi yang diberikan serta dibicarakan pada satu kesempatan yaitu pada saat pemberian pelayanan Keluarga Berencana. Aspek sangat penting dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) adalah konseling.(Everett, 2007) Dengan melaksanakan sebuah konseling maka berarti petugas KIE membantu klien dalam memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya. Disamping itu, konseling dapat membuat klien mempunyai perasaan lebih puas. (Kusumawardani & Azizah, 2021)

Konseling Keluarga Berencana (KB) adalah proses interaksi profesional antara pemberi layanan KB dan individu atau pasangan yang bertujuan membantu mereka memahami dan menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Melalui konseling, klien diberikan informasi mengenai berbagai metode kontrasepsi, termasuk cara penggunaan, manfaat, efek samping, serta bagaimana mengatasi perasaan negatif seperti keraguan atau ketakutan terkait penggunaan kontrasepsi. Proses ini juga mencakup identifikasi kebutuhan klien, pemilihan metode yang aman dan sesuai, serta pemberian informasi tentang cara mendapatkan layanan KB. Konseling KB yang efektif dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan klien untuk memastikan penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif. Konseling KB dapat dikembangkan agar dapat dilakukan oleh petugas pelayanan KB dalam batas yang sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

2. Tujuan Konseling (RI, 2019)

Tujuan memberikan konseling KB kepada klien antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan
- b. Penerimaan klien terhadap konseling KB lebih baik ketika informasi disampaikan dengan benar, terdapat diskusi bebas, dan komunikasi non verbal
- c. Menjamin pilihan yang cocok

- d. Konseling yang benar membantu petugas dan klien dalam menentukan pilihan terbaik metode KB sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien
- e. Menjamin efektivitas penggunaan kontrasepsi
- f. Konseling yang efektif dapat membantu klien mengetahui metode KB yang sesuai dan mengatasi isu-isu yang keliru mengenai penggunaan kontrasepsi
- g. Menjamin durasi pemakaian yang lebih lama
- h. Durasi pemakaian KB dapat ditingkatkan dengan melibatkan klien dalam memilih metode KB, memberikan pengetahuan klien tentang cara kerja dan efek samping penggunaan KB, dan memberitahu klien kapan harus melakukan kunjungan ulang

3. Manfaat Konseling(RI, 2019)

- a. Klien memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan reproduksinya
- b. Puas terhadap pilihannya sehingga dapat mengurangi keluhan atau penyesalan
- c. Memberdayakan klien untuk menentukan metode dan lama penggunaan alat kontrasepsi
- d. Membangun rasa saling percaya
- e. Menghormati hak klien dan petugas
- f. Menambah dukungan terhadap pelayanan KB
- g. Menghilangkan rumor, mitos,

4. Jenis Konseling Keluarga Berencana

Dalam pelayanan Keluarga Berencana terdapat komponen penting yang dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap-tahap tersebut yaitu konseling awal pada waktu menerima klien, konseling khusus tentang cara berKB dan konseling tindak lanjut.

a. Konseling Awal.

Dalam konseling awal mempunyai tujuan untuk menentukan metode atau jenis kontrasepsi Keluarga Berencana apa yang cocok digunakan. Pada saat konseling awal, tenaga kesehatan juga harus mengenalkan pada klien semua cara dan jenis kontrasepsi Keluarga Berencana atau mengenalkan pelayanan kesehatan pada klien. Selain itu, tenaga kesehatan harus mengenalkan pula prosedur klinik dari masing-masing jenis dari KB tersebut, kebijakan-kebijakan berKB dan bagaimana pengalaman dari klien pada kunjungannya itu. (Murad,

1994) Apabila dilaksanakan secara efektif, maka konseling awal yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membantu klien dalam menentukan jenis kontrasepsi KB yang cocok untuk dirinya. Pada saat melakukan konseling awal, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya : menanyakan kepada klien cara atau metode apa yang disukainya atau diinginkannya dan apa yang sudah dia ketahui tentang cara atau metode tersebut. Pada saat melaksanakan kegiatan konseling awal, sebaiknya juga memberikan sebuah pemahaman secara ringkas tentang cara kerja kontrasepsi, kelebihan-kelebihan kontrasepsi, dan kekurangan dari masing-masing jenis kontrasepsi KB.

b. **Konseling Khusus.**

Informasi lebih jelas dan rinci tentang cara berKB yang sudah tersedia dan kontrasepsi yang ingin dipilih klien akan didapatkan juga oleh klien pada kegiatan konseling ini. Selain itu, klien juga akan mendapatkan bantuan untuk memilih metode Keluarga Berencana yang cocok serta mendapat penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana cara menggunakan metode tersebut dengan efektif, aman dan memuaskan klien. Pada konseling khusus ini mengenai metode kontrasepsi Keluarga Berencana diharapkan dapat memberi kesempatan pada klien untuk menanyakan tentang bagaimana cara berKB dan membicarakan tentang pengalamannya.

c. **Konseling Tindak lanjut.**

Apabila terdapat klien yang datang kembali atau kunjungan ulang untuk mendapatkan obat baru atau untuk melakukan pemeriksaan ulang memerlukan konseling sebelumnya dan pada konseling sebelumnya juga dapat dijadikan pijakan atau acuan. Pada saat melakukan kunjungan ulang, klien akan memperoleh konseling yang lebih dalam. Misalnya tenaga kesehatan harus memberi tahu tentang apa yang harus dilakukan pada kondisi tertentu kepada klien. Tenaga kesehatan juga harus memberikan suatu pemahaman tentang perbedaan antara masalah yang serius dan harus segera ditangani serta masalah yang ringan yang dapat diselesaikan di tempat oleh klien itu sendiri.

(Kusumawardani & Azizah, 2021)

5. Langkah Konseling KB

a. **GATHER menurut Gallen dan Leitenmaier (Tahun 1987).**

Satu akronim atau singkatan yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan program KB diberikan oleh Gallen dan Leitenmaier. Singkatan ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan konseling. Singkatan tersebut yaitu GATHER yang merupakan singkatan dari :

G: Greet.

Merupakan memberikan salam, memperkenalkan diri dan memulai komunikasi dengan klien.

A: Ask atau Assess.

Berarti menanyakan keluhan atau kebutuhan pasien dan menentukan apakah keluhan atau keinginan yang disampaikan oleh klien tersebut memang sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat itu.

T: Tell.

Tenaga kesehatan memberitahukan bahwa masalah atau keluhan pokok yang dihadapi oleh pasien ialah seperti yang terlihat dari hasil berbagai informasi dan harus dicarikan solusi atau upaya dan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

H: Help

Membantu klien supaya mampu memahami masalah atau keluhan yang utama terjadi pada dirinya. Tenaga kesehatan juga harus menjelaskan cara-cara untuk menyelesaikan keluhan atau masalahnya tersebut dan juga harus menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing metode atau cara kontrasepsi. Tenaga kesehatan harus membiarkan dan meminta klien untuk memutuskan metode atau cara yang paling baik bagi dirinya sendiri.

E: Explain.

Menjelaskan tentang cara atau metode yang telah dipilih dan memang dianjurkan serta hasil yang akan diharapkan mungkin dapat segera terlihat atau harus diobservasi selama beberapa saat sehingga dapat menampakkan hasil yang diinginkan. Tenaga kesehatan juga perlu menjelaskan siapa dan dimana klien dapat mendapatkan pertolongan lanjutan atau pertolongan darurat yang dapat diperolehnya.

R: Refer dan Return visit.

Melaksanakan rujukan jika fasilitas yang diberikan tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan klien atau tenaga kesehatan membuat jadwal kunjungan ulang apabila pelayanan yang terpilih telah diberikan kepada klien.

b. Langkah –langkah Konseling SATU TUJU

1) SA: Sapa dan Salam

Proses konseling KB harus dimulai dengan menyapa dan mengucapkan salam terhadap klien secara terbuka dan sopan. Jangan lupa untuk menyatakan secara eksplisit mengenai kerahasiaan data klien yang terjamin dalam proses konseling KB. Sapaan terhadap klien juga disertai dengan

pertanyaan mengenai informasi keadaan klien saat ini, seperti kondisi kesehatannya, keluhan yang dialami, pemikiran mengenai alat kontrasepsi yang hendak digunakan, dan berbagai pertimbangan yang dimiliki klien saat ini.

2) T: Tanyakan

Agar dapat memudahkan klien untuk menemukan metode KB yang sesuai, maka kenalilah kebutuhan klien dengan bertanya. Ajak klien untuk mendiskusikan beberapa hal berikut, yaitu kondisi kesehatan saat ini, pengalaman ber-KB, pengetahuan mengenai program KB, rencana memiliki anak, kesehatan reproduksi, pemahaman mengenai HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya, sikap pasangan mengenai rencana ber-KB, dan ragam pertimbangan yang dimiliki oleh klien. Dalam hal ini, keterampilan penyedia layanan dalam melakukan observasi dan bertanya serta menanggapi cerita dan informasi dari klien juga perlu diasah dengan baik.

Berikut adalah keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh penyedia layanan agar proses tanya ini bisa berjalan dengan baik :

- Observasi
- Memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup
- Memberikan dorongan
- Melakukan parafrase
- Merefleksikan perasaan
- Merefleksikan arti
- Membuat Kesimpulan

Untuk memudahkan proses bertanya dan menggali kelayakan medis dalam penggunaan KB, penyedia layanan dapat pula menggunakan Roda KLOP

c. U: Uraikan

Dalam proses ini, penyedia layanan telah memiliki satu atau dua metode KB yang dapat ditawarkan kepada klien. Penyedia layanan harus menguraikan metode KB yang hendak ditawarkan tersebut dengan mengaitkannya pada berbagai pertimbangan klien yang dimilikinya saat ini, termasuk mengenai kriteria kelayakan medis, efek samping, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh klien.

d. Tu: Bantu

Dalam proses ini, penyedia layanan membantu klien untuk membuat keputusan

dengan mempertimbangkan kondisi medis, karakteristik klien, efektivitas, efek

samping, dan durasi penggunaan metode KB. Oleh karena itu, penyedia layanan

perlu memastikan bahwa klien telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode KB yang menjadi pilihannya.

e. J: Jelaskan

Setelah klien memutuskan alat kontrasepsi yang akan digunakan, penyedia layanan harus menjelaskan secara lengkap mengenai cara menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Dalam hal ini, informasi yang tercantum dalam ABPK dapat membantu klien lebih memahami cara menggunakan alat kontrasepsi yang akan digunakan tersebut. Klien juga harus mampu menampilkan perencanaan yang baik mengenai bagaimana ia akan menjalankan program KB yang diinginkannya.

f. U: Kunjungan Ulang

Penyedia layanan perlu mendorong klien untuk kembali apabila ia memiliki pertanyaan, pertimbangan, maupun permasalahan saat menjalankan program KB yang telah ia pilih.

(RI, 2019)

B. Konseling dengan Metode sederhana / Tradisional

1. Metode Kalender (Metode Ritmik)

Definisi: Metode Kalender, juga dikenal sebagai Metode Ritmik atau Metode Ogino-Knaus, adalah teknik kontrasepsi yang melibatkan perhitungan siklus menstruasi untuk mengidentifikasi periode subur dan tidak subur seorang wanita.

Cara Kerja:

a. Pengamatan Siklus: Wanita mencatat panjang siklus menstruasinya selama minimal 6 bulan.

b. Perhitungan Periode Subur:

1) Hari pertama masa subur dihitung dengan mengurangi 18 hari dari siklus terpendek.

2) Hari terakhir masa subur dihitung dengan mengurangi 11 hari dari siklus terpanjang.

Contoh:

Jika siklus terpendek adalah 26 hari dan terpanjang 30 hari:

Hari pertama subur: $26 - 18 =$ hari ke-8

Hari terakhir subur: $30 - 11 =$ hari ke-19

Maka, periode subur adalah hari ke-8 hingga ke-19.

Keunggulan:

- Tidak memerlukan alat atau biaya.

- Dapat meningkatkan pemahaman tentang siklus reproduksi.

Keterbatasan:

- Memerlukan siklus menstruasi yang teratur.
- Efektivitasnya lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi modern.

2. Metode Lendir Serviks (Metode Ovulasi Billings)

Definisi: Metode Lendir Serviks, atau Metode Ovulasi Billings, adalah teknik kontrasepsi yang didasarkan pada pengamatan perubahan lendir serviks untuk menentukan masa subur.

Cara Kerja:

- a. Pengamatan Harian: Wanita memeriksa konsistensi dan jumlah lendir serviks setiap hari.
- b. Identifikasi Perubahan:
 - Masa tidak subur: Lendir sedikit, kental, dan lengket.
 - Masa subur: Lendir lebih banyak, jernih, elastis, dan licin, mirip putih telur mentah.

Keunggulan:

- Tidak memerlukan alat atau biaya.
- Meningkatkan kesadaran tentang siklus tubuh.

Keterbatasan:

- Memerlukan pelatihan dan pemahaman yang baik.
- Perubahan lendir dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti infeksi atau penggunaan spermisida.

3. Metode Suhu Basal Tubuh (Basal Body Temperature Method)

Definisi: Metode Suhu Basal Tubuh adalah teknik kontrasepsi yang melibatkan pengukuran suhu tubuh basal setiap hari untuk mendeteksi ovulasi.

Cara Kerja:

- a. Pengukuran Harian: Suhu tubuh diukur setiap pagi sebelum beraktivitas.
- b. Identifikasi Ovulasi: Setelah ovulasi, suhu basal tubuh biasanya meningkat sekitar 0,2-0,5°C dan tetap tinggi hingga menstruasi berikutnya.
- c. Periode Subur: Dianggap 2-3 hari sebelum kenaikan suhu dan 1-2 hari setelahnya.

Keunggulan:

- Tidak memerlukan alat kontrasepsi tambahan.
- Meningkatkan pemahaman tentang siklus menstruasi.

Keterbatasan:

- Memerlukan konsistensi dalam pengukuran suhu setiap hari.
- Faktor eksternal seperti penyakit atau kurang tidur dapat mempengaruhi akurasi suhu.

4. Coitus Interruptus (Senggama Terputus)

Definisi: Coitus Interruptus, atau senggama terputus, adalah metode kontrasepsi di mana pria menarik penisnya dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita.

Cara Kerja:

Penarikan Sebelum Ejakulasi: Pria harus memiliki kontrol yang baik untuk menarik penis sebelum ejakulasi terjadi.

Keunggulan:

- a. Tidak memerlukan alat atau biaya.
- b. Dapat digunakan tanpa persiapan sebelumnya.

Keterbatasan:

- Memerlukan kontrol diri yang tinggi dari pihak pria.
- Efektivitas rendah karena kemungkinan sperma terdapat dalam cairan pra-ejakulasi.

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021; WHO, 2016, 2022; World Health Organization, 2015)

C. Konseling dengan Metode Alami

1. Metode Amenore Laktasi (MAL)

Definisi: Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami yang memanfaatkan periode amenore (tidak menstruasi) selama masa menyusui eksklusif untuk mencegah kehamilan. Menyusui secara eksklusif dapat menunda kembalinya ovulasi dan menstruasi setelah melahirkan.

Syarat Efektivitas: Agar MAL efektif sebagai metode kontrasepsi, tiga kriteria utama harus dipenuhi:

- a. Amenore: Ibu belum mengalami menstruasi sejak melahirkan.
- b. Menyusui Eksklusif: Bayi disusui secara eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
- c. Usia Bayi Kurang dari 6 Bulan: Efektivitas MAL menurun setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan.

Keunggulan:

- a. Efektivitas Tinggi: Jika ketiga kriteria dipenuhi, MAL memiliki efektivitas sekitar 98% dalam mencegah kehamilan.
- b. Tidak Memerlukan Alat atau Obat: MAL adalah metode alami tanpa intervensi medis atau alat kontrasepsi.
- c. Manfaat Tambahan: Menyusui eksklusif memberikan nutrisi optimal bagi bayi dan memperkuat ikatan ibu-anak.

Keterbatasan:

- a. Waktu Terbatas: Efektivitas MAL hanya berlaku selama 6 bulan pertama postpartum.
- b. Kepatuhan Ketat: Memerlukan komitmen untuk menyusui eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
- c. Tidak Melindungi dari Infeksi Menular Seksual (IMS): Seperti metode kontrasepsi lainnya, MAL tidak memberikan perlindungan terhadap IMS.

2. Metode Sympto-Thermal

Definisi: Metode Sympto-Thermal adalah metode kontrasepsi alami yang menggabungkan beberapa indikator fisiologis untuk menentukan masa subur wanita. Indikator utama yang digunakan meliputi:

- a. Suhu Basal Tubuh (BBT): Pengukuran suhu tubuh saat istirahat yang cenderung meningkat setelah ovulasi.
- b. Lendir Serviks: Perubahan konsistensi dan jumlah lendir serviks yang menandakan masa subur.
- c. Gejala Fisik Lainnya: Seperti nyeri ovulasi atau perubahan pada payudara.

Cara Kerja: Dengan memantau dan mencatat indikator-indikator tersebut setiap hari, wanita dapat mengidentifikasi pola siklus menstruasinya dan menentukan periode subur serta tidak subur. Selama periode subur, pasangan dapat memilih untuk menghindari hubungan seksual atau menggunakan metode penghalang untuk mencegah kehamilan.

Keunggulan:

- a. Efektivitas Tinggi: Dengan penerapan yang tepat, metode ini dapat mencapai efektivitas hingga 98%.
- b. Peningkatan Kesadaran Tubuh: Wanita menjadi lebih sadar akan siklus dan tanda-tanda fisiologis tubuhnya.
- c. Tidak Memerlukan Alat atau Obat: Metode ini sepenuhnya alami tanpa intervensi medis.

Keterbatasan:

- a. Pembelajaran Awal: Memerlukan waktu dan pelatihan untuk memahami dan mengenali tanda-tanda tubuh dengan akurat.
- b. Konsistensi dan Disiplin: Dibutuhkan pengamatan dan pencatatan harian yang konsisten.
- c. Faktor Pengganggu: Kondisi seperti stres, penyakit, atau perubahan rutinitas dapat mempengaruhi indikator fisiologis.

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021; RI, 2019; Rosidah, 2024; Seran, Agustina A; Rosidah, Lely K dan Umamy, 2024)

D. Konseling dengan Metode Modern (Hormonal dan Non Hormonal)

Konseling mengenai metode kontrasepsi modern, penting bagi tenaga kesehatan untuk:

- Memberikan Informasi yang Komprehensif: Jelaskan cara kerja, efektivitas, keuntungan, dan keterbatasan setiap metode.
- Menilai Kesesuaian Metode: Pertimbangkan kondisi kesehatan, preferensi, dan kebutuhan individu atau pasangan.
- Menghormati Pilihan Klien: Berikan dukungan terhadap pilihan klien dan pastikan mereka merasa nyaman dengan keputusan yang diambil.
- Memberikan Edukasi tentang Penggunaan yang Benar: Pastikan klien memahami cara penggunaan atau prosedur metode yang dipilih untuk mencapai efektivitas optimal.

1. Metode Kontrasepsi Hormonal

Definisi: Metode kontrasepsi hormonal adalah metode yang menggunakan hormon sintetis, seperti estrogen dan/atau progestin, untuk mencegah kehamilan. Hormon-hormon ini bekerja dengan menghambat ovulasi, menebalkan lendir serviks, dan menipiskan endometrium, sehingga mencegah fertilisasi dan implantasi.

Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Hormonal:

- a. Pil KB Kombinasi: Mengandung estrogen dan progestin.
- b. Pil Progestin (Mini Pil): Hanya mengandung progestin.
- c. Suntik KB: Mengandung progestin yang disuntikkan setiap 1 atau 3 bulan.
- d. Implan (AKBK): Batang kecil yang ditanam di bawah kulit dan melepaskan progestin secara bertahap.

Keuntungan:

- a. Efektivitas Tinggi: Jika digunakan dengan benar, efektivitas mencapai lebih dari 99%.
- b. Regulasi Siklus Menstruasi: Dapat membantu mengatur siklus menstruasi dan mengurangi nyeri haid.
- c. Manfaat Kesehatan Lain: Dapat mengurangi risiko kanker ovarium dan endometrium.

Keterbatasan:

- a. Efek Samping: Seperti mual, peningkatan berat badan, perubahan mood, dan perdarahan di luar siklus.
- b. Tidak Melindungi dari IMS: Metode hormonal tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.
- c. Kepatuhan Pengguna: Beberapa metode memerlukan kepatuhan tinggi, seperti pil yang harus diminum setiap hari pada waktu yang sama.

2. Metode Kontrasepsi Non-Hormonal

Definisi: Metode kontrasepsi non-hormonal adalah metode yang tidak menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Metode ini bekerja dengan menghalangi sperma mencapai sel telur atau dengan mencegah implantasi.

Jenis-jenis Metode Kontrasepsi Non-Hormonal:

- a. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) Tembaga: Alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim dan melepaskan ion tembaga yang toksik bagi sperma.
- b. Kondom Pria dan Wanita: Penghalang fisik yang mencegah sperma masuk ke dalam rahim.
- c. Diafragma dan Cervical Cap: Alat yang ditempatkan di serviks untuk menghalangi masuknya sperma.
- d. Sterilisasi (Tubektomi dan Vasektomi): Prosedur permanen yang memotong atau mengikat saluran reproduksi.

Keuntungan:

- a. Tidak Ada Efek Hormon: Cocok bagi mereka yang sensitif atau memiliki kontraindikasi terhadap hormon.
- b. Beberapa Melindungi dari IMS: Kondom dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual.
- c. Pilihan Jangka Panjang: Seperti IUD tembaga yang dapat bertahan hingga 10 tahun.

Keterbatasan:

- a. Efektivitas Bervariasi: Tergantung pada metode dan kepatuhan pengguna.
- b. Beberapa Memerlukan Prosedur Medis: Seperti pemasangan IUD atau sterilisasi.
- c. Kemungkinan Ketidaknyamanan: Beberapa pengguna mungkin mengalami ketidaknyamanan atau efek samping lokal.

(Direktorat Kesehatan Keluarga, 2021; Rosidah, 2024; Seran, Agustina A; Rosidah, Lely K dan Umamy, 2024)

E. Konseling Kontrasepsi Darurat

1. Definisi Kontrasepsi Darurat

Kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah terjadinya hubungan seksual tanpa perlindungan atau ketika metode kontrasepsi yang digunakan mengalami kegagalan. Metode ini sering disebut sebagai "kontrasepsi pasca-senggama" atau "morning after pill".

2. Indikasi Penggunaan

Kontrasepsi darurat digunakan dalam situasi berikut:

- a. Hubungan seksual tanpa proteksi: Ketika tidak ada metode kontrasepsi yang digunakan.
- b. Kegagalan kontrasepsi: Misalnya, kondom bocor atau lupa minum pil KB.
- c. Kasus kekerasan seksual: Untuk mencegah kehamilan akibat pemerkosaan.

3. Jenis-Jenis Metode Kontrasepsi Darurat

- a. Pil Kontrasepsi Darurat:
 - 1) Pil Levonorgestrel: Mengandung 1,5 mg levonorgestrel yang diminum sekali dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual tanpa proteksi. Efektivitasnya menurun seiring berjalannya waktu setelah hubungan seksual.
 - 2) Pil Kombinasi Estrogen dan Progestin (Yuzpe regimen): Menggunakan pil KB kombinasi dosis tinggi yang diminum dalam dua dosis dengan interval 12 jam. Metode ini kurang efektif dan memiliki lebih banyak efek samping dibandingkan pil levonorgestrel.
 - 3) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Tembaga:
 - 4) AKDR Tembaga: Dapat dipasang hingga 5 hari setelah hubungan seksual tanpa proteksi. Selain sebagai kontrasepsi darurat, AKDR tembaga juga berfungsi sebagai kontrasepsi jangka panjang.

4. Mekanisme Kerja

- a. Pil Kontrasepsi Darurat: Bekerja dengan menghambat atau menunda ovulasi sehingga mencegah fertilisasi.
- b. AKDR Tembaga: Mencegah fertilisasi dengan menciptakan lingkungan yang toksik bagi sperma dan sel telur, serta mencegah implantasi embrio.

5. Efektivitas

- a. Pil Levonorgestrel: Efektif mencegah kehamilan jika diminum dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual tanpa proteksi, dengan efektivitas menurun seiring berjalannya waktu.
- b. AKDR Tembaga: Memiliki tingkat efektivitas lebih dari 99% jika dipasang dalam waktu 5 hari setelah hubungan seksual tanpa proteksi.

6. Keuntungan dan Keterbatasan

Keuntungan:

- a. Pil Kontrasepsi Darurat:
 - 1) Mudah diakses dan digunakan.
 - 2) Tidak memerlukan prosedur medis.
- b. AKDR Tembaga:
 - 1) Memberikan perlindungan jangka panjang hingga 10 tahun.

- 2) Tidak mengandung hormon, sehingga cocok bagi wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi hormonal.

Keterbatasan:

- a. Pil Kontrasepsi Darurat:
 - 1) Efektivitas menurun seiring berjalannya waktu setelah hubungan seksual.
 - 2) Dapat menyebabkan efek samping seperti mual dan muntah.
- b. AKDR Tembaga:
 - 1) Memerlukan prosedur pemasangan oleh tenaga medis terlatih.
 - 2) Mungkin tidak cocok bagi wanita dengan kondisi medis tertentu.

7. Pertimbangan dalam Konseling

- a. Edukasi: Memberikan informasi yang akurat mengenai jenis, mekanisme kerja, efektivitas, serta keuntungan dan keterbatasan setiap metode kontrasepsi darurat.
- b. Aksesibilitas: Membantu klien memahami cara mendapatkan kontrasepsi darurat dan prosedur yang diperlukan, terutama untuk pemasangan AKDR.
- c. Efek Samping: Menyampaikan kemungkinan efek samping dan cara mengatasinya.
- d. Tindak Lanjut: Menganjurkan klien untuk melakukan konsultasi lanjutan dan mempertimbangkan penggunaan metode kontrasepsi rutin untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di masa mendatang.

(Eliansa & Setyawati, 2024; Ismainar, Heny; Aprianti, 2025; Kementerian Kesehatan RI & BKKBN, 2018)

F. Latihan Soal

1. Seorang wanita dengan siklus menstruasi teratur 28 hari ingin menggunakan metode kalender sebagai kontrasepsi. Hari berapa ia harus menghindari hubungan seksual untuk mencegah kehamilan?
 - A. Hari ke-1 hingga hari ke-7
 - B. Hari ke-7 hingga hari ke-14
 - C. Hari ke-10 hingga hari ke-17
 - D. Hari ke-20 hingga hari ke-28
 - E. Hari ke-1 hingga hari ke-28
2. Pada metode lendir serviks, masa subur ditandai dengan:
 - A. Lendir serviks kental, berwarna putih, dan lengket
 - B. Lendir serviks jernih, elastis, dan menyerupai putih telur mentah
 - C. Lendir serviks berwarna kecoklatan dan sedikit
 - D. Tidak adanya lendir serviks

- E. Lendir serviks berwarna kuning dengan bau khas
3. Dalam metode suhu basal, kapan seorang wanita dapat mengidentifikasi masa tidak subur?
- A. Ketika suhu tubuhnya menurun drastis
 - B. Ketika suhu tubuhnya tetap konstan selama siklus menstruasi
 - C. Ketika terjadi lonjakan suhu basal tubuh sekitar 0,3–0,5°C setelah ovulasi
 - D. Ketika suhu tubuhnya terus menurun setelah ovulasi
 - E. Ketika suhu tubuhnya tidak berubah selama 7 hari setelah menstruasi
4. Seorang wanita berusia 25 tahun datang ke klinik setelah mengalami hubungan seksual tanpa perlindungan 48 jam yang lalu. Sebagai tenaga kesehatan, metode kontrasepsi darurat yang paling direkomendasikan untuknya adalah:
- A. Pil kombinasi estrogen dan progestin (Metode Yuzpe)
 - B. Pil levonorgestrel dosis tunggal 1,5 mg
 - C. Pemasangan implan kontrasepsi
 - D. Suntikan kontrasepsi progestin
 - E. Sterilisasi tubektomi
5. Kontrasepsi darurat yang memiliki efektivitas paling tinggi dalam mencegah kehamilan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan adalah:
- A. Pil kombinasi estrogen dan progestin (Metode Yuzpe)
 - B. Pil levonorgestrel dosis tunggal 1,5 mg
 - C. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) tembaga
 - D. Kontrasepsi suntik DMPA
 - E. Patch kontrasepsi hormonal

Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. B
- 3. C
- 4. B
- 5. C

G. Rangkuman Materi

Buku ini membahas berbagai metode kontrasepsi, mulai dari metode sederhana (tradisional) seperti kalender, lendir serviks, suhu basal, dan coitus interruptus, hingga metode alami seperti Metode Amenore Laktasi (MAL) dan

Metode Sympto-Thermal. Selain itu, dibahas juga kontrasepsi modern, baik hormonal (pil KB, suntik KB, implan, patch, cincin vagina) maupun non-hormonal (AKDR tembaga, kondom, diafragma, sterilisasi). Kontrasepsi darurat, seperti pil levonorgestrel dan AKDR tembaga, juga dijelaskan sebagai metode pencegahan kehamilan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan.

Selain pemaparan metode, buku ini menekankan pentingnya pendekatan individual dalam konseling, dengan memperhatikan kondisi medis, sosial, dan budaya klien. Berbagai teknik komunikasi dan alat bantu seperti ABPK dan Roda KLOP dijelaskan untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang lebih optimal.

Buku ini dilengkapi dengan teori, ilustrasi, studi kasus, serta latihan dan evaluasi, sehingga dapat menjadi referensi penting bagi tenaga kesehatan dalam mendukung keberhasilan program KB dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

H. Glosarium

AKBK	: Alat Konterasepsi bawah Kulit
AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
KB	: Keluarga Berencana
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
MA	L: Metode Amenorea Laktasi

I. Daftar Pustaka

- Agungbudiprabowo. (2021). Modul Ketrampilan Dasar Konseling. Universitas Ahmad Dahlan.
- Direktorat Kesehatan Keluarga. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana. In Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Vol. 1, Issue November). Kemenkes RI.
- Eliansa, E., & Setyawati, N. (2024). Efektivitas Kontrasepsi Darurat (Kondar). *OVUM : Journal of Midwifery and Health Sciences*, 4(1), 43–50. <https://doi.org/10.47701/ovum.v4i1.3856>
- Hartini, N., & Ariana, A. D. (2016). Psikologi Konseling Perkembangan Dan Penerapan Konseling Dalam Psikologi. In Airlangga University Press.
- Ismainar, Heny; Aprianti, R. dkk. (2025). Kontrasepsi dan Perencanaan Keluarga (D. E. Misbah, Siti Rachmi dan Cessaria (ed.)). EUREKA MEDIA AKSARA IKAPI.

- Kementrian Kesehatan RI, & BKKBN. (2018). Kriteria Kelayakan Medis Untuk Penggunaan Kontrasepsi. In Kemenkes RI (Vol. 65, Issue 3).
- Kusumawardani, P. A., & Azizah, N. (2021). Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB. In Umsida Press (Vol. 185, Issue 1).
- RI, K. (2019). PELAYANAN KONTRASEPSI BAGI DOKTER DAN BIDAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MPI 1. Konseling Keluarga Berencana. In Modul Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Vol. 2, Issue 2, pp. 37–65).
- Rosidah, L. K. dkk. (2024). Bunga Rampai: Ketrampilan Klinis dalam Praktik Kebidanan untuk DIII Kebidanan (R. Dewi (ed.)). Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Seran, Agustina A; Rosidah, Lely K dan Umamy, F. (2024). Buku Ajar Keluarga Berencana. In Buku Ajar Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi. PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta. https://drive.google.com/file/d/1E-hohwYynKFXxoExgy9oeGnT3KIInVe_/view?usp=drive_link
- Setyorini, D. dkk. (2020). Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (A. Mundandar (ed.)). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- WHO. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use (Third).
- WHO. (2022). Family planning global handbook.
- World Health Organization. (2015). Medical eligibility criteria for contraceptive use - Executive summary (5th ed.). WHO.

BAB 6

MEMBUAT PERMINTAAN OBAT KONTRASEPSI DARURAT, MENYIMPAN DAN MEMBERIKAN KONTRASEPSI DARURAT SESUAI KEWENANGAN, KEBIJAKAN LOKAL, PROTOKOL, PERATURAN DAN HUKUM

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan yang komprehensif pada pasien dengan kebutuhan pelayanan kontrasepsi darurat (kondar) berdasarkan peraturan dan hukum yang diterapkan.

Tujuan Intruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyimpanan dan pemberian Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengawasan Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu mengedukasi Pasca Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu menerapkan Kebijakan lokal Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu menerapkan protokol Kontrasepsi Darurat (Kondar)
- Mahasiswa mampu menerapkan Peraturan dan Hukum Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan konsep Kontrasepsi Darurat (Kondar) dan pemberian kontrasepsi darurat sesuai dengan kewenangan Bidan.
- Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan kontrasepsi darurat dalam skenario klinis.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melakukan tindakan pelayanan kontrasepsi darurat (kondar) secara tepat, seperti penyimpanan, pemberian, edukasi sesuai dengan peraturan dan hukum di Indonesia.

Afektif:

Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi permasalahan utama bidang kesehatan serta masih jauh dari target global SDGs. Dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menyebutkan AKI 305/100.000 Kelahiran Hidup (KH), dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 untuk AKI sebesar 183/100.000 Kelahiran Hidup. Target 2030 secara global untuk AKI adalah 70/100.000 KH, AKB mencapai 12/1.000 KH dan AKN 7/1.000 KH. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pendekatan Safe motherhood, dimana terdapat empat pilar dalam menurunkan angka kematian ibu, yaitu keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, persalinan bersih dan aman, serta PONEK dan PONEK. Pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana merupakan intervensi strategis dalam menurunkan AKI dan AKB.

Penggunaan kontrasepsi bertujuan untuk memenuhi hak reproduksi setiap orang, membantu merencanakan kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan, dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan salah satunya yaitu kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera setelah hubungan seksual. Hal ini sering disebut "kontrasepsi pascasenggama" atau "morning after treatment", kontrasepsi darurat dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kontrasepsi darurat hanya efektif sebelum kehamilan terjadi.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep Kontrasepsi Darurat (Kondar), penyimpanan dan pemberian Kontrasepsi Darurat (Kondar), pengawasan Kontrasepsi Darurat (Kondar), edukasi Pasca Kontrasepsi Darurat (Kondar), Kebijakan lokal Kontrasepsi Darurat (Kondar), penerapan protokol Kontrasepsi Darurat (Kondar) dan Peraturan dan Hukum Kontrasepsi Darurat (Kondar) dalam Asuhan pelayanan kontrasepsi kebidanan.

A. Konsep Dasar Kontrasepsi Darurat (Kondar)

1. Pengertian Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Kontrasepsi darurat (emergency contraception) disebut pula sebagai kontrasepsi pascasenggama karena digunakan setelah melakukan senggama. Hal ini berbeda dengan kontrasepsi pada umumnya yang digunakan sebelum senggama. Kontrasepsi ini sering pula disebut sebagai kontrasepsi sekunder atau morning after pil atau morning after treatment (BKKBN, 2017).

Kontrasepsi darurat yang digunakan sebelum perkiraan waktu implantasi, yang bertujuan mencegah kehamilan pasca-senggama yang tidak terlindung atau kasus perkosaan. Pengguna kontrasepsi darurat dapat menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan hingga 50%, tetapi banyak tenaga medis dan masyarakat yang belum mengenal metode ini.

Menurut WHO kontrasepsi darurat mengacu pada kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan setelah hubungan seksual. metode ini direkomendasikan untuk digunakan dalam waktu 5 hari, tetapi akan lebih efektif jika digunakan lebih cepat setelah hubungan seksual.

2. Jenis Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Terdapat dua metode kontrasepsi darurat, yaitu pil kontrasepsi darurat dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang menggunakan tembaga.

a. Pil kontrasepsi darurat dengan LNG

Pil kontrasepsi darurat dengan menggunakan turunan progesteron terdiri dari 0,75 mg LNG yang terbagi dalam dua dosis. Pemberian obat dimulai dalam jangka waktu 48 jam pasca senggama.

b. Pil kontrasepsi darurat dengan UPA

Ulipristal acetate (UPA) ialah modulator reseptor progesteron yang merupakan turunan dari 19-norprogesteron dan dikembangkan untuk meningkatkan spesifisitas terhadap PR. UPA diberikan sebagai dosis tunggal 30 mg dan dapat dikonsumsi dalam 120 jam setelah hubungan intim tanpa kondom.

c. Pil kontrasepsi oral kombinasi

Pil kombinasi estrogen-progesteron, secara keseluruhan cara ini terdiri dari 200 µg etinilestradiol dan 1,0 mg LNG. Pemberian dapat dimulai segera setelah senggama hingga 72 jam kemudian dengan dosis 100 µg etinilestradiol dan 0,5 mg LNG dengan dosis yang sama diulang 12 jam kemudian.

d. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR atau Intrauterine Device (IUD), contohnya: CuT 380A, Copper T, Multiload, Nova T. AKDR merupakan satu-satunya kontrasepsi darurat mekanik yang mengandung logam tembaga. Jika dipasang dalam waktu 5-7 hari setelah senggama, AKDR ini mampu mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi ini melepaskan ion tembaga yang mematikan sperma dan menyebabkan perubahan pada endometrium sehingga mencegah nidasi. AKDR tembaga pasca senggama menunjukkan bahwa angka kegagalannya tidak lebih dari 0,1%.

3. Mekanisme Kerja Kontrasepsi Darurat (Kondar)

a. Pil kontrasepsi darurat

Levonorgestrel 1,5 mg efektif mencegah kehamilan karena bekerja dengan cara mencegah atau memperlambat ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit mencapai telur serta mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada rahim. Dosis oral levonorgestrel (LNG) sebesar 1,5 mg aman dan efektif bilandikonsumsi sebelum ovulasi, namun tidak memiliki dampak nyata terhadap risiko kehamilan bila dikonsumsi setelahnya.

b. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Mekanisme kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma masuk kedalam tuba falopii, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai cavum uteri, AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu / walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk kedalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus.

4. Indikasi pemakaian Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Kontrasepsi darurat harus dipertimbangkan untuk setiap wanita yang datang dalam lima hari setelah senggama tanpa kondom atau tidak terlindungi dengan baik dan yang tidak ingin hamil. Pemasangan AKDR tembaga dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual tanpa kondom. Hubungan intim tanpa kondom dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- 1) Kegagalan menggunakan kontrasepsi
- 2) Kondom rusak atau bocor saat berhubungan
- 3) Terlepasnya diafragma atau cervical cap

- 4) Satu pil KB yang tidak dikonsumsi pada minggu pertama kombinasi pil kontrasepsi kombinasi.
- 5) Tiga atau lebih pil KB yang tidak dikonsumsi pada minggu kedua atau ketiga pil kontrasepsi kombinasi
- 6) Lupa meminum pil progestin
- 7) Terlepasnya kontrasepsi koyo
- 8) Penghentian kontrasepsi cincin vagina
- 9) Injeksi Depo-Provera terlambat 2 minggu
- 10) Ejakulasi pada genitalia eksterna; dan
- 11) Pemerkosaan

5. Kontra Indikasi Kontrasepsi Darurat (Kondar)

World Health Organization (WHO) tidak mendapatkan kontraindikasi untuk penggunaan kontrasepsi darurat hormonal atau AKDR pada wanita menyusui, dan tidak ada kontraindikasi medis yang diketahui untuk penggunaan kontrasepsi darurat hormonal, kecuali alergi terhadap salah satu dari konstituen.

6. Kelebihan Kontrasepsi Darurat (Kondar)

- 1) Tidak menyebabkan keguguran
- 2) Dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan
- 3) Mencegah aborsi
- 4) Tidak menimbulkan cacat bawaan bila diketahui ibu hamil
- 5) Efektif bekerja dengan cepat, mudah relative murah untuk pemakaian jangka pendek

7. Kekurangn Kontrasepsi Darurat (Kondar)

- 1) Tidak dapat dipakai secara permanent
- 2) Harus dengan resep dokter
- 3) Tidak semua apotek tersedia
- 4) Tidak efektif setelah 3 x 24 jam

B. Penyimpanan dan pemberian Kontrasepsi Darurat (Kondar)

1. Penyimpanan Kontrasepsi Darurat (Kondar)

- a. Bersihkan dan suci hamakan tempat penyimpanan alat/obat kontrasepsi secara teratur.
- b. Simpan alat/obat kontrasepsi dalam keadaan kering, tidak lembab, mendapat ventilasi udara yang baik, dan tidak terkena sinar matahari langsung.
- c. Pastikan bahwa alat pengaman bahaya kebakaran berada dalam kondisi baik, serta siap dan mudah diambil/digunakan.
- d. Tempatkan dus kondom yang terbuat dari karton agar dijauhkan dari sumber listrik/lampu, untuk mencegah bahaya kebakaran.

- e. Tempatkan dus penyimpanan alat/obat kontrasepsi (yang berada di gudang):
± 10 cm di atas lantai; ± 30 cm dari dinding, tinggi susunan dus tidak lebih dari 2,5m.
- f. Agar diatur dus karton sedemikian rupa sehingga kartu identitas/label yang berisi batas waktu kadaluwarsa atau waktu pembuatan di pabrik dapat mudah dilihat.
- g. Tempatkan alat/obat kontrasepsi pada posisi yang memungkinkan untuk pendistribusian pada sistem First Expire First Out (FEFO) yaitu alokon yang lebih awal masa kadaluwarsanya agar lebih awal didistribusikan/dipakai oleh klien.
- h. Tempatkan tiap jenis alat/obat kontrasepsi secara terpisah, dan jauhkan dari bahan-bahan yang mengandung insektisida, bahan kimia, arsip tua/lama, peralatan kantor dan material lain.
- i. Pisahkan alat dan obat kontrasepsi yang sampai pada batas waktu kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan pemerintah atau pemberi bantuan.
- j. Pastikan bahwa penyimpanan alat/obat kontrasepsi benar-benar dalam posisi aman.

2. Pemberian Kontrasepsi Darurat (Kondar)

a. Pada Remaja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja merupakan bagian upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup. Di dalam Pasal 103 Ayat (1) PP Nomor 28 disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja diatur di dalam Pasal 103 Ayat (4) adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. Hal ini tertuang di dalam Pasal 103 Ayat (4) huruf e.

b. Pada PUS

Dalam peraturan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional republik indonesia no.1 tahun 2023 tentang pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi PUS dalam pelayanan keluarga berencana dijelaskan pada pasal 3 bahwa, Pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB meliputi tahapan:

- 1) seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- 2) perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
- 3) penyediaan dan pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi;

- 4) Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
- 5) monitoring dan evaluasi.

C. Pengawasan dan Edukasi Pasca Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Pemeriksaan laboratorium tidak dibutuhkan pada pemberian kontrasepsi darurat. Pada kondisi dimana PKD levonorgestrel dimuntahkan dalam 2 jam setelah konsumsi, maka dosis diulang dan ditambahkan antiemetik. Sedangkan bila PKD kombinasi dimuntahkan dalam 1 jam setelah konsumsi, maka dosis diulang dan diberikan obat antiemetik.

Pada pasien yang menggunakan kontrasepsi hormonal, menstruasi terjadi dalam 1 minggu dari waktu perkiraan menstruasi berikutnya. Penggunaan kontrasepsi darurat bukan bertujuan untuk aborsi. Pemeriksaan dugaan kehamilan perlu dilakukan pada kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada menstruasi dalam 3 - 4 minggu pasca pemberian kontrasepsi
2. Tidak adanya menstruasi yang disertai gejala akut abdomen (kemungkinan kehamilan ektopik)
3. Jarak waktu yang lama antara berhubungan seksual tanpa proteksi dan pemberian kontrasepsi darurat
4. Masa ovulasi dapat diperkirakan, dan pasien datang pasca ovulasi

D. Kebijakan Lokal Kontrasepsi darurat (Kondar)

Dalam PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dijelaskan bahwa pelayanan kontrasepsi darurat diberikan pada ibu yang tidak terlindungi kontrasepsi atau korban perkosaan untuk mencegah kehamilan. Pemberian kontrasepsi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai standar.

Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini mengatur layanan kontrasepsi darurat dan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual. Layanan kontrasepsi darurat bagi korban perkosaan diatur dalam Pasal 110, sementara layanan aborsi aman bagi korban perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 124.

E. Protokol Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Protokol kontrasepsi darurat meliputi pil, alat kontrasepsi tembaga intrauterin (AKDR), dan IUD pelepas levonorgestrel.

1. Pil kontrasepsi darurat

- Minum dua tablet sekaligus setelah berhubungan seksual
- Maksimal 72 jam (3 hari) setelah berhubungan seksual
- Lebih efektif jika diminum sesegera mungkin

Tabel 1. Dosis berbagai merek pil yang diperlukan sebagai kontrasepsi darurat

	Isi	Jumlah yang harus diminum	
Nama pil	EE: ethinylestradiol LNG: levonorgestrel NG: dl-norgestrel	Maksimal 72 jam setelah hubungan seksual tanpa perlindungan	12 jam kemudian
I. Pil Kombinasi (metode Yuzpe)			
Neogynon , Noral, Nordiol, Ovidon, Ovran, Tetragynon/PC4, Neo-Primovlar 4, E-Gen-C, Fertilan Eugynon 50 , Ovral	EE 50 mg + LNG 250 mg	2	2
	EE 50 mg + NG 500 mg	2	2
Microgynon 30 , Nordette , Rigevidon LO/Femenal, Ovral L	EE 30 mg + LNG 150 mg	4	4
	EE 30 mg + NG 300 mg	4	4
II. Pil hanya progestin			
Postinor, Postinor-2*	LNG 750 mg	1	1
Microlut , Microval, Norgeston Ovrette	LNG 30 mg	25	25
	NG 75 mg	20	20

Catatan:

- Nama pil dengan garis bawah dan dicetak tebal adalah pil-pil yang tersedia di Indonesia
- * Masih dalam proses registrasi untuk dipasarkan di Indonesia

2. AKDR

- Alat kontrasepsi mekanik yang mengandung tembaga
- Pasang dalam waktu 5-7 hari setelah berhubungan seksual

- c. Mencegah kehamilan dengan melepaskan ion tembaga yang mematikan sperma

3. IUD pelepas levonorgestrel

- a. Alat kontrasepsi yang mungkin memerlukan pemasangan dalam waktu 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa pengaman.

F. Peraturan dan Hukum Kontrasepsi Darurat (Kondar)

Peraturan terkait kontrasepsi darurat di Indonesia meliputi PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021.

PP Nomor 28 Tahun 2024 yaitu:

- a. Mengatur layanan kontrasepsi darurat dan aborsi aman bagi perempuan korban kekerasan seksual
- b. Memberikan peluang bagi Lembaga layanan korban kekerasan seksual untuk memberikan keterangan

G. Latihan Soal

Latihan dibuat dalam bentuk

1. Ny S umur 27 tahun, mempunyai anak 2 yang terkecil umur 1 tahun, datang ke PMB mengatakan 3 hari yang lalu melakukan hubungan suami istri, klien mengatakan selama ini menggunakan alkon suntik 3 bulan, dan seharusnya sudah suntik lagi 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan belum siap untuk hamil lagi. Hasil pemeriksaan bidan: T: 120/80mmHg, N:80x/menit, S: 36⁰C, P; 24x/menit, terdapat radang panggul. Apakah Alkon yang cocok untuk kasus diatas?
 - A. IUD
 - B. Strerilisasi
 - C. Suntik ulang
 - D. Pil Kombinasi
 - E. Pil kontrasepsi darurat
2. Ny S umur 27 tahun, mempunyai anak 2 yang terkecil umur 1 tahun, datang ke PMB mengatakan 3 hari yang lalu melakukan hubungan suami istri, klien mengatakan selama ini menggunakan alkon suntik 3 bulan, dan seharusnya sudah suntik lagi 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan belum siap untuk hamil lagi. Hasil pemeriksaan bidan : T: 120/80mmHg, N:80x/menit, S: 36⁰C, P;

- 24x/menit, terdapat radang panggul. Bidan memberikan pil kondar. Berapa harikah Alkon akan efektif mencegah kehamilan setelah pasca sanggama
- A. Maksimal 3 hari setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
 - B. Maksimal 4 hari setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
 - C. Maksimal 5 hari jam setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
 - D. Maksimal 6 hari setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
 - E. Maksimal 7 hari setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
3. Ny S umur 27 tahun, mempunyai anak 2 yang terkecil umur 1 tahun, datang ke PMB mengatakan 3 hari yang lalu melakukan hubungan suami istri, klien mengatakan selama ini menggunakan alkon suntik 3 bulan, dan seharusnya sudah suntik lagi 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan belum siap untuk hamil lagi. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan semua dalam batas normal. Berapa jarak / jam antara minum pil yang satu dengan pil yang berikutnya?
- A. 4 jam
 - B. 6 jam
 - C. 12 jam
 - D. 24 jam
 - E. 72 jam
4. Ny S umur 27 tahun, mempunyai anak 2 yang terkecil umur 1 tahun, datang ke PMB mengatakan 3 hari yang lalu melakukan hubungan suami istri, klien mengatakan selama ini menggunakan alkon suntik 3 bulan, dan seharusnya sudah suntik lagi 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan belum siap untuk hamil lagi. Hasil pemeriksaan didapatkan semua dalam batas normal. Kemudian bidan memberikan pil kondar, tetapi dihari ke 3, klien muntah setelah 1 jam minum pil. Apakah yang harus dilakukan?
- A. Didiamkan saja
 - B. Dikasih obat anti muntah
 - C. Diganti dengan Alkon yang lain
 - D. Mengulang kembali pil yang diminum saat itu
 - E. Diberikan KIE bahwa itu adalah hal yang biasa terjadi
5. kontrasepsi darurat utamanya diberikan bagi perempuan korban kekerasan seksual, hal ini sesuai dengan peraturan apa?
- A. PP Nomor 28 Tahun 2024
 - B. PP Nomor 29 Tahun 2024
 - C. PP Nomor 30 Tahun 2024

- D. PP Nomor 31 Tahun 2024
- E. PP Nomor 32 Tahun 2024

Kunci Jawaban

1. E. Pil kontrasepsi darurat
2. A. Maksimal 3 hari setelah pasca sanggama yang tak terlindungi
3. C. 12 jam
4. D. Mengulang kembali pil yang diminum saat itu
5. A. PP Nomor 28 Tahun 2024

H. Rangkuman Materi

Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera setelah hubungan seksual. Hal ini sering disebut “kontrasepsi pascasenggama” atau “morning after treatment”, kontrasepsi darurat dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, kontrasepsi darurat hanya efektif sebelum kehamilan terjadi.

1. Terdapat dua metode kontrasepsi darurat, yaitu pil kontrasepsi darurat dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang menggunakan tembaga. Pil kontrasepsi darurat dengan LNG, Pil kontrasepsi darurat dengan UPA, Pil kontrasepsi oral kombinasi dan IUD Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
2. Indikasi pemakaian Kontrasepsi Darurat (Kondar) harus dipertimbangkan untuk setiap wanita yang datang dalam lima hari setelah senggama tanpa kondom atau tidak terlindungi dengan baik dan yang tidak ingin hamil. Pemasangan AKDR tembaga dapat dilakukan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual tanpa kondom.
3. Protokol kontrasepsi darurat Pil: Minum dua tablet sekaligus setelah berhubungan seksual, maksimal 72 jam (3 hari) setelah berhubungan seksual dan lebih efektif jika diminum sesegera mungkin.
4. Protokol kontrasepsi darurat AKDR: Alat kontrasepsi mekanik yang mengandung tembaga, pasang dalam waktu 5-7 hari setelah berhubungan seksual dan Mencegah kehamilan dengan melepaskan ion tembaga yang mematikan sperma
5. Peraturan terkait kontrasepsi darurat di Indonesia meliputi PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021

I. Glosarium

- Kontrasepsi darurat : kontrasepsi pascasenggama karena digunakan setelah melakukan senggama.
- Ulipristal acetate (UPA) : modulator reseptor progesteron yang merupakan turunan dari 19-norprogesteron dan dikembangkan untuk meningkatkan spesifisitas terhadap PR
- AKDR atau Intrauterine Device (IUD): kontrasepsi darurat mekanik yang mengandung logam tembaga

J. Daftar Pustaka

- Batmomolin, A., Harahap, R.N., et al. (2023). Bunga Rampai Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. Media Pustaka Indo.
- BKKBN. (2017). Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dan Keguguran, 64.
- BKKBN. (2020). Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 69(555), 1–53.
- C. S, B. (2022). Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi. UNISMA PRESS
- Kemenkes RI. (2021). Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 288.
- Kemenkes RI. (2023). Keluarga berencana. Jurnal Kesehatan, 2, 1–8.
- Kusumawardani, P. A., & Azizah, N. (2021). Konsep Kependudukan dan KIE Dalam Pelayanan KB. In Umsida Press (Vol. 185, Issue 1).
- Matahari Ratu, Fitriana Putri Utami, S. S. (2018). BUKU AJAR KELUARGA BERENCANA DAN KONTRASEPSI (1st ed.). CV.Pustaka Ilmu Group yogyakarta. https://eprints.uad.ac.id/24374/1/buku_ajar_Keluarga_Berencana_dan_Kontrasepsi.pdf

- Megawati, Friska Sitorus, J. M. S. (2018). PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU. *Midwifery Journal*, 3(2), 114–119. <https://media.neliti.com/media/publications/278699-pelayanan-keluarga-berencana-pasca-persa-2844ac0f.pdf>
- Merlly Amalia. (2017). Pelayanan Keluarga Berencana (KB). [https://books.google.co.id/books?id=CpxxEAAAQBAJ&lpg=PA23&ots=VYIikNfuTg&dq=Pelayanan Keluarga Berencana \(KB\) Merlly Amalia \(2017&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Pelayanan Keluarga Berencana \(KB\) Merlly Amalia &f=false](https://books.google.co.id/books?id=CpxxEAAAQBAJ&lpg=PA23&ots=VYIikNfuTg&dq=Pelayanan+Keluarga+Berencana+(KB)+Merlly+Amalia+(2017&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Pelayanan+Keluarga+Berencana+(KB)+Merlly+Amalia+&f=false)
- Mushy, S. E., Tarimo, E. A. M., Fredrick Massae, A., & Horiuchi, S. (2020). Barriers to the uptake of modern family planning methods among female youth of Temeke District in Dar es Salaam, Tanzania: A qualitative study. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 24(June 2019), 100499. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2020.100499>
- Nurjanah, S., Pratiwi, E. N., Wijayanti, W., & Murharyati, A. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Kader Dengan Modul Konseling Kb Pasca Persalinan Berdasarkan Information Motivation Behavioral Skills (IMB) Model. *Jurnal Salam Sehat Masyarakat (JSSM)*, 2(2), 6–12. <https://doi.org/10.22437/jssm.v2i2.13610>

BAB 7

TREND DAN ISSUE PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan trend dan issue pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Tujuan Instruksional Khusus

- Mahasiswa mampu menjelaskan trend dalam pelayanan Keluarga Berencana
- Mahasiswa mampu menjelaskan issue dalam pelayanan Keluarga Berencana
- Mahasiswa mampu menjelaskan trend dan issue dalam Kesehatan Reproduksi

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan trend dan issue pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu mengidentifikasi trend dan issue dalam pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati dan etika profesional dalam mengasumsikan trend dan issue dalam pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi

Pendahuluan:

Bidan memiliki peran penting dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, di antaranya: Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi, Memberikan alat kontrasepsi, seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), alat kontrasepsi bawah kulit (implan), kondom, dan alat kontrasepsi oral, Melakukan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual (IMS), Mensukseskan program KB yang dicanangkan pemerintah, Memberikan pendidikan kesehatan kepada perempuan dan masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang trend dan issue pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan trend dan issue Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Sasaran pembaca

buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan. Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah. Pada Bab ini juga akan diuraikan trend dan issue pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari trend dalam pelayanan Keluarga Berencana, issue dalam pelayanan Keluarga Berencana, trend dalam Kesehatan Reproduksi, issue dalam Kesehatan Reproduksi.

A. Trend Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program keluarga berencana (KB) memiliki ciri dan karakteristik berbeda-beda dilihat dalam tiga masa besar yaitu:

1. Masa orde lama

Pada saat Presiden Soekarno memimpin, dimulai pada tahun 1945 hingga 1967 yang merupakan lahirnya Negara Republik Indonesia, kondisi Indonesia baru saja merdeka sehingga pemerintah dan peraturan hukum negara masih dalam penyesuaian dan pembangunan. Program keluarga berencana belum menjadi fokus utama.

Masa kepemimpinan Soekarno, terdapat kelompok swadaya masyarakat yang bernama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Meski bapak Soekarno, tidak setuju dengan penerapan KB menurut beliau Indonesia masih memerlukan banyak sumber daya untuk dapat melawan kapitalisme barat dan melakukan pembangunan di tiap wilayah, sehingga Bapak Soekarno lebih memilih untuk pronatalis. Presiden Soekarno mempunyai pandangan bahwa perempuan yang mempunyai anak banyak menyimpulkan bahwa perempuan itu merupakan suatu kekuatan, ketahanan dan kecantikan.

Tercatat pada masa kepemimpinan Soekarno laju pertumbuhan penduduk (LPP) sekitar 2%-2,31% dengan tingginya Angka Kelahiran Total (AKT) sekitar 5,6 pada tahun 1971, yang artinya setiap perempuan memiliki 5-6 anak, untuk menekan kepadatan penduduk yang dilakukan adalah program transmigrasi. Dengan demikian pembangunan dapat dilakukan di daerah-daerah yang belum terjamah. (Gayatri et al., 2020).

2. Masa orde baru

Peralihan pemerintah dari masa Presiden Soekarno menuju masa Presiden Soeharto adalah tonggak sejarah yang sangat penting di Indonesia terutama dalam menegakkan Keluarga Berencana. Pada masa orde baru, program keluarga berencana sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung oleh Presiden pada kala itu yakni Presiden Soeharto. Dukungan dari dalam negeri maupun dukungan dari luar yang diperoleh saat itu merupakan dukungan dana yang sangat besar. Selain itu pada masa orde baru, promosi program keluarga berencana berhasil menggugah banyak masyarakat hingga ke bagian pelosok Indonesia.

Pada tahun 1970 hingga tahun 1980, penyelenggaraan program KB Nasional dikenal dengan nama "*Management for The People*". Pada periode ini, pemerintah lebih banyak melakukan inisiatif dan partisipasi masyarakat menjadi sangat rendah. Pasalnya, program ini sangat memiliki orientasi target serta implementasinya sehingga terkesan kurang demokratis, disebabkan karena otoriter atau sentralisasi pemerintah sehingga Presiden langsung menerima laporan dan langsung memberikan kebijakan dan arahan. (Putri, 2019). Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi program yang memiliki sifat "*top down approach*" artinya pemerintah melalui BKKBN membentuk jaringan struktural dari atas ke bawah, dari tingkat pusat ke tingkat provinsi, kabupaten serta kota sampai kelurahan dan posyandu yang tersebar di tingkat-tingkat rukun keluarga. Lalu berubah menjadi Gerakan Keluarga Berencana pada tahun 1980. Pola kebijakan program KB Nasional berubah menjadi masyarakat "*Management with The People*". Dengan memiliki slogan "Dua Anak Cukup". (Dina Dewi Anggraini; dkk, 2021). Presiden Soeharto melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melalui media massa. (Rendi Arandi, 2016).

Program KB pada masa era baru ini berhasil mencapai target nasional. Keberhasilannya juga diakui oleh dunia internasional dengan didapatkannya penghargaan yakni *United Nation (UN) Population Award* oleh UNFPA pada tahun 1989.

3. Masa reformasi

Pada awal reformasi, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia belum stabil sehingga sulit untuk Indonesia memperbaiki terutama dalam bidang kesehatan. Serta terkait dengan pengendalian penduduk karena masih banyak konflik yang melemahkan elit nasional.

Kebijakan kependudukan terabaikan sehingga pemerintah lebih menyerahkan masalah kebijakan kependudukan ini pada pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, namun pemerintah daerah cenderung fokus pada pembangunan politik dan ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memiliki AKT di angka 2,6 per wanita, namun perubahan terjadi dengan dikeluarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 terkait penguatan status keberadaan BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB. (Gayatri et al., 2020). Untuk pelaksanaan program KB di provinsi dan kabupaten atau kota akan diawasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena adanya peraturan

pemerintah yang tumpang tindih, sehingga ragu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program KB tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, program KB disesuaikan dengan program Nawacita sebagai agenda pembangunan. BKKBN mengikuti program yang dijalankan pemerintah yaitu memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan pembentukan kampung KB. (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Tujuan dari kampung KB adalah penguatan program KB yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan melibatkan mitra dan lintas sektor terkait. Belum terkonfirmasi keefektifitasan dari program tersebut, tetapi tahun 2018 menunjukkan AKT Indonesia berada di angka 2,4 per wanita dengan LPP 1,36%.

Program KB dapat diterapkan dengan baik dengan adanya program yang kuat dan masif yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah sehingga dapat mencapai dampak yang cukup signifikan. Keluarga berencana dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Elsyra et al., 2018). Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

B. Issue Pelayanan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan *issue* penting dalam perkembangan suatu negara. Masalah kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia semakin hari semakin rumit bukan semakin sederhana. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) menyatakan bahwa permasalahan kependudukan dan KB di negara Indonesia sudah semakin kompleks dan telah menjadi *issue* nasional yang harus dicarikan solusinya.

Lima *issue* kependudukan dan KB adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM)

Program keluarga berencana berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa, karena melalui Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) keluarga akan mampu mewujudkan generasi muda yang sehat, bergizi, cerdas dan berpendidikan serta memiliki lima dimensi utama seperti:

a. Dimensi kelahiran

Setiap kelahiran diharapkan dan merupakan tindakan sadar dan harus direncanakan. Inilah titik awal konsep keluarga berencana.

b. Dimensi kesehatan

Sikap dan perilaku untuk hidup sehat sangat penting untuk dapat dipromosikan dan diimplementasikan dalam keluarga.

c. Dimensi pendidikan

Bahwa anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga tidak boleh dibedakan pendidikannya, semuanya harus dilakukan secara seimbang.

d. Dimensi kesejahteraan

Bahwa lebih kepada martabat dari keluarga bukan sekadar memiliki kekayaan.

e. Dimensi masa depan

Seluruh keluarga harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, harus dihindarkan keluarga- keluarga yang terperangkap kepada nilai-nilai masa lalu yang konservatif.

Sekitar 30% sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia memiliki kualitas di bawah standar. Ketidaksiapan pasangan saat menikah menimbulkan banyak risiko kesehatan terhadap ibu dan bayi yang dilahirkan. (Trianziani, 2018). Ketidaksiapan ini menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi baru yang berkualitas.

2. Menikah usia muda

Usia kawin pertama merupakan indikator dalam sosial dan demografi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan di Indonesia. Perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas (BKKBN, 2017). Semakin muda usia wanita saat menikah maka akan semakin panjang juga masa reproduksinya. Hal tersebut membuat usia kawin pertama merupakan salah satu indikator dalam fertilitas yang berpengaruh dalam jumlah penduduk di suatu negara. Satu dari sembilan anak perempuan usia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. (Merri Sri Hartati, 2021). Saat ini ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global. Banyak di antara mereka tidak paham tentang masalah bagaimana mengatur jarak aman kelahiran agar anak bisa lahir dengan sehat dan tidak stunting. (Hanum & Tukiman, 2015).

3. Melahirkan usia muda

Setiap tahunnya, banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia sekitar 15 hingga 19 tahun. Jumlahnya mencapai setengah juta orang. Bayi-bayi yang lahir dari ibu yang masih sangat muda itu berpotensi lahir dengan ukuran di bawah standar sekitar 10% dan prematur mencapai 20%.

Sementara, kita semua telah memahami bahwa perempuan sebaliknya jangan menikah di bawah usia 21 tahun adalah karena organ reproduksi belum siap, bisa menyebabkan hamil tidak sehat, mengalami perdarahan serta kanker mulut rahim setelah berhubungan. Mengatur kelahiran merupakan hal rencana jangka panjang yang sangat efisiensi. Kegiatan ini nampak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia. (Haris.M.Si., 2020). Upaya yang akan dilakukan adalah mengadakan penyuluhan perkawinan, sehingga usia dalam melahirkan pun dapat diatur dan tidak terlalu singkat dalam memiliki anak.

Kehamilan yang tidak diinginkan membuat bayi menjadi tidak sehat dan mengarah kepada tindakan aborsi yang tidak aman dengan konsekuensi kesakitan dan kematian maternal. Kehamilan terlalu muda (usia ibu 15-19 tahun), terlalu tua (usia 35-49 tahun), terlalu dekat (jarak dengan kehamilan sebelumnya kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak), berisiko tinggi untuk ibu dan anak mengalami kematian, serta dapat mengakibatkan komplikasi pada ibu saat hamil, persalinan dan nifas. (Waluyo et al., 2022).

4. Kurangnya pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak

Hingga saat ini kesadaran untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan bayi belum sesuai harapan. Sementara, kecukupan asupan nutrisi dan gizi pada rentang usia tersebut menjadi kunci agar bayi yang dilahirkan menjadi generasi baru yang unggul dan berkualitas. Anak yang tidak cukup mendapatkan asupan gizi dan nutrisi bisa mengalami gizi buruk dan memicu terjadinya stunting. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) menunjukkan angka yang cukup bagus terkait dengan masalah stunting. Angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2% pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Meski trend stunting mengalami penurunan, hal ini masih dibawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu kurang dari 20%. Maka harus disiapkan pasangan suami istri agar dapat memiliki pengetahuan yang maksimal dalam tumbuh kembang anak. Dalam masa kehamilan, ibu harus rutin dan mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) atau pelayanan kesehatan ibu selama masa kehamilan atau setelah melahirkan. Faktor yang lain bisa dikarenakan asupan nutrisi yang kurang bergizi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

5. Kurangnya perencanaan keluarga

Remaja saat ini perlu memahami pentingnya lima tahap kehidupan yaitu melaksanakan pola hidup sehat dengan makan-makanan bergizi, meraih cita-cita melalui pendidikan yang baik, memiliki karir atau pekerjaan baik laki-laki

maupun perempuan, menjadi anggota masyarakat dan berkeluarga. (Samuel & Mandas, 2018).

C. Trend Dan Issue Dalam Kesehatan Reproduksi

Tantangan memelihara kesehatan reproduksi berbagai isu seputar kesehatan seksual yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yang optimal antara lain (Ahmad, Mukhlisiana, 2020):

1. Akses terbatas dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal. Banyak wilayah di dunia, terutama di negara-negara berkembang mengalami kesulitan menyediakan akses yang memadai untuk pelayanan kesehatan reproduksi. Faktor-faktor seperti jarak geografis, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur termasuk transportasi yang buruk, serta ketidakmampuan membayar pelayanan kesehatan menjadi hambatan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.
2. Kekerasan berbasis gender, meliputi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kekerasan yang dialami dapat menyebabkan cedera fisik dan emosional serta berdampak negatif pada kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi.
3. Pendidikan seksual yang tidak memadai. Pendidikan seksual yang komprehensif dan tepat sejak masa anak dan remaja masih menjadi tantangan para orang tua dan guru. Kurangnya pengetahuan tentang organ reproduksi, hubungan yang sehat, kontrasepsi, dan perlindungan diri menyebabkan meningkatnya risiko kehamilan remaja, penularan penyakit menular seksual, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.
4. Penyimpangan Seksual

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormality*). Terjadinya penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak sewajarnya didapat oleh setiap orang (Fitria, Y, 2020). Penyimpangan seksual kadang dengan ketidakwajaran seksual yaitu perilaku-perilaku seksual atau fantasi- fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual di masyarakat yang bisa diterima secara umum. Menurut Suyatno, 2009 penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut

adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Menurut Sarwono, Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktorial, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi yang saling berkaitan.

Penyimpangan seksual dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. *Eksibisionisme* dari kata *exhibition* yang memiliki arti menunjukkan atau memperlihatkan alat kelaminnya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi seperti ini sebagian besar pelakunya adalah pria, modusnya dengan memperlihatkan alat kelaminnya yang bisa dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi. Bisa juga pelaku tanpa rasa malu menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain sekedar untuk menunjukkannya dengan rasa bangga.
- b. *Fetishism*: merupakan ekspresi seksual seseorang di mana subyek sangat memuja atau menyukai sesuatu hal yang di luar normal dari lawan jenisnya. Benda tersebut bisa berupa benda mati yang dimiliki lawan jenis yang disukainya atau bagian tubuh dari lawan jenisnya.
- c. *Froteurisme*: suatu bentuk parafilia di mana seorang individu laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menggesekkan atau menggosokkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum.
- d. *Pedophilia*: merupakan orang yang senang berhubungan dengan anak-anak di mana anak tersebut masih belum mencapai masa puber dan perbedaan umur anak minimal 5 tahun dengan pelaku.
- e. *Voyeurisme*: Pengidap kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Ejakulasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya.
- f. *Incest*: hubungan seks yang dilakukan dengan sesama anggota keluarga sendiri.
- g. *Nekrofilia*: Bentuk parafilia dimana individu pelaku nekrofilia memiliki orientasi kepuasan seksual melalui kontak fisik yang bersifat merangsang atau hubungan seksual dengan pasangan yang dipilih adalah jenazah atau orang yang telah meninggal.

- h. *Zoofilia*: salah satu bentuk parafilia dimana terdapat orang atau individu yang terangsang melihat hewan dan selanjutnya melakukan hubungan seks dengan hewan.
5. Perilaku seksual kompulsif: adalah pengulangan tindakan erotik tanpa kenikmatan. Kompulsi seksual ini bisa berupa telepon seks yang tanpa akhir, *one-night stand* (affair singkat), atau masturbasi beberapa kali dalam sehari.
6. Kekerasan Seksual (Perkosaan)

Saat ini istilah "perkosaan" cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti "perkosaan" hak-hak sipil. "Perkosaan" ekologis (lingkungan hidup), "perkosaan" terhadap harkat kemanusiaan lainnya. Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pertama, paksaan dan kekerasan, kedua gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun". Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pengertian perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).

7. Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian

ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu:

- a. Pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu permintaan- permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2012).

D. Latihan Soal

Untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan diatas silahkan anda mengerjakan soal dibawah ini

Pilihan Ganda:

1. Berikut ini yang bukan merupakan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk adalah...
 - A. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
 - B. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
 - C. Peningkatan angka pengangguran di masyarakat
 - D. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

- E. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga
2. Hubungan seksual dengan pasangan yang masih mempunyai pertalian darah.
- A. *Incest*
 - B. Sodomi
 - C. Transeksual
 - D. homoseksualitas
 - E. transvestite
3. Seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan mengintip orang yang sedang mandi.
- A. *Incest*
 - B. Sodomi
 - C. Transeksual
 - D. *Voyeurisme*
 - E. Transvestite
4. Memegang dada orang lain secara paksa termasuk?
- A. Bercanda
 - B. Hal yang wajar
 - C. Pelecehan seksual
 - D. Hal yang biasa
 - E. Perzinahan
5. Kejadian yang bisa diusahakan oleh manusia (preventive checks) yang bisa menjadi penghambat laju pertumbuhan penduduk di antaranya ...
- A. Bencana alam
 - B. Kelaparan
 - C. Menunda perkawinan
 - D. Penyakit menular
 - E. Pembunuhan

Essay

1. Berikan contoh bentuk- bentuk pelecehan seksual yang ada dilingkungan tempat tinggal anda!
2. Tuliskan lima dimensi yang harus ada dalam kualitas SDM!
3. Mengapa kesehatan reproduksi sering dikaitkan dengan perempuan!

4. Jelaskan trend pelayanan keluarga berencana pada masa reformasi!
5. Berikan contoh jenis-jenis penyimpangan seksual!

Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. D
4. C
5. C

E. Rangkuman Materi

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Sejahtera disebutkan bahwa Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, Bahagia dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah suatu program masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Tantangan memelihara kesehatan reproduksi berbagai isu seputar kesehatan seksual yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yang optimal antara lain: Akses terbatas dalam memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang optimal, Kekerasan seksual berbasis gender, Pendidikan seksual yang tidak memadai penyimpangan seksual, Perilaku seksual kompulsif, Kekerasan seksual perkosaan) pelecehan seksual.

F. Glosarium

AKDR	: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
AKT	: Angka Kelahiran Total
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana
IMS	: Infeksi Menular Seksual
KB	: Keluarga Berencana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Litbangkes	: Badan penelitian dan Pengembangan Kesehatan
LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
NKKBS	: Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PUP	: Pendewasaan Usia perkawinan
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
UNFPA	: <i>United Nation Population Award</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization

G. Daftar Pustaka

- Ahmad, Mukhlisiana. (2020). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi. Media Sains Indonesia. Bandung.
- BKKBN. (2017). Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran. Direktorat Kesehatan Reproduksi.
- Dina Dewi Anggraini; dkk. (2021). Pelayanan Kontrasepsi (Janner Simarmata, Ed.; Abdul Karim).
- Elsyra, N., Rusnaini, S., Tinggi, S., dkk. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo. IKRAITH-Humanira, 23.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Keluarga Berencana. 1–18.
- Gayatri, M., Arum Romadlona, N., dkk. (2020). Tren Kebutuhan Dan Penggunaan Kontrasepsi Di Indonesia 2022-2017 Sub Nasional Analisis Program Keluarga Berencana. Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). <http://jurnal.iakmi.id/index.php/FITIAKMI>

- Hanum, Y., & Tukiman, D. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.
- Haris.M.Si., Dr. R. (2020). Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Kesehatan, P. M. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014. 2008, 139.
- Merri Sri Hartati. (2021). Parenting Pendidikan Seks (Kesehatan Reproduksi Untuk Masa depan Gemilang). K-Media
- Putri, P. K. D. (2019). Family Planning Institutional Programs and Their Achievements : From Centralization To Decentralization Era. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1).
- Rendi Arandi, S. M. (2016). Pengaruh Urbanisasi, Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Fertilitas Di Lima Kota Provinsi Aceh. 1, 208–216.
- Samuel, I., & Mandas, T. (2018). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62), 92–98.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development*, Edisi Ketigabelas. Jakarta: Erlangga.
- Trianziani, S. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Di Desa Karangjaladri Kecamatan prig Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 4(November), 131–149. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Undang-Undang RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. *Journal of Human Development*, 6(1), 1–22. <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-management/oecd/development/the-world-economy>.
- Waluyo, D., Fitriani, Mk., Indah Putri Ramadhanti, Mk., dkk (2022). Pengantar Kesehatan Reproduksi Wanita (M. Kes. Dr. R. S. Or. , M. Kes. Dr. M. Ns. , M. Sc. Dr. dr. I Putu Sudayasa, Ed.). CV. Eureka Media Aksara

BAB 8

MEMBERIKAN PELAYANAN KONTRASEPSI DENGAN METODE SEDERHANA, ALAMI, MODERN, DAN KONTRASEPSI DARURAT. PELAYANAN KONTRASEPSI PASCA ABORSI (KONDOM, PIL, SUNTIK),

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memberikan pelayanan kontrasepsi secara profesional dan komprehensif dengan pendekatan edukatif, komunikatif, dan berbasis kebutuhan individu, mencakup metode kontrasepsi sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat.

Tujuan Intruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan manfaat penggunaan kontrasepsi.
- Mahasiswa mampu Mengidentifikasi berbagai jenis metode kontrasepsi, termasuk metode alami, sederhana, modern, dan kontrasepsi darurat.
- Mahasiswa mampu Menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing metode kontrasepsi sesuai dengan kondisi klien.
- Mahasiswa mampu memberikan konseling kontrasepsi yang tepat dan efektif dengan pendekatan komunikasi empatik.
- Mahasiswa mampu Melakukan simulasi pelayanan kontrasepsi dengan standar prosedur yang benar.
- Mahasiswa mampu Menentukan pilihan metode kontrasepsi yang sesuai berdasarkan kondisi medis, psikologis, dan sosial klien.
- Mahasiswa mampu Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dan efek samping penggunaan kontrasepsi.

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa mampu memahami ilmu kebidanan untuk melakukan asuhan kebidanan secara profesional dengan menggunakan pendekatan asuhan kebidanan (CPL.02).
- Mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dan Memahami teori dan prinsip kontrasepsi alami, sederhana, modern, dan darurat. Mampu menjelaskan mekanisme kerja, efektivitas, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping masing-masing metode kontrasepsi kepada klien melalui kerja tim (CPL.03).
- Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi kebidanan, memberikan konseling dan edukasi kontrasepsi kepada klien dan prosedur pelayanan kontrasepsi sesuai SOP dan kondisi klien (CPL.05).

Pendahuluan

Pentingnya kontrasepsi dalam kesehatan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk mengatur dan merencanakan kelahiran, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kontrasepsi merupakan alat yang efektif dalam memberikan kontrol kepada individu atau pasangan dalam menentukan waktu dan jumlah anak. Penggunaan kontrasepsi yang tepat tidak hanya membantu dalam merencanakan keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik pada ibu maupun bayi, seperti tingginya angka kematian ibu, kelahiran prematur, dan masalah kesehatan lainnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai metode kontrasepsi kini tersedia, mulai dari metode hormonal, alat kontrasepsi dalam rahim, hingga metode alami dan darurat. Setiap metode memiliki mekanisme yang berbeda dalam mencegah kehamilan, seperti dengan mencegah ovulasi, menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur, atau mengubah kondisi rahim sehingga tidak mendukung nidasi. Namun, pemilihan metode kontrasepsi yang tepat sangat bergantung pada kondisi kesehatan, preferensi, serta tujuan masing-masing individu. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan, seperti bidan dan dokter, untuk memberikan pelayanan kontrasepsi yang bersifat personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, usia, status pernikahan, serta potensi efek samping yang mungkin terjadi.

Mengingat pentingnya peran kontrasepsi dalam kesehatan reproduksi, kesadaran masyarakat mengenai berbagai pilihan kontrasepsi perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat.

Kontrasepsi juga memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan aborsi yang tidak aman, serta meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga. Oleh karena itu, penguatan pelayanan kontrasepsi yang berbasis pada pemahaman yang komprehensif tentang manfaat, risiko, dan pilihan yang ada sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan reproduksi masyarakat.

Uraian Materi

A. Pelayanan Kontrasepsi dengan Metode Sederhana, Modern, dan Kontrasepsi Darurat

1 Kontrasepsi sederhana

Metode kontrasepsi sederhana pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan dengan alat. Metode kontrasepsi sederhana tanpa alat terdiri dari metode alamiah (metode kalender, suhu basal badan, lendir serviks, symtho thermal), metode amenorrhoe laktasi (MAL) dan coitusinterruptus. Metode kontrasepsi alamiah pada dasarnya meningkatkan pengetahuan sistem reproduksi dari pasangan, tanpa risiko kesehatan sehingga tidak ada efek samping sistemik namun dalam penggunaannya dibutuhkan banyak latihan, dan keterlibatan dari pasangan. Sedangkan MAL dapat efektif apabila ibu menyusukan secara asi eksklusif dan dianjurkan terutama kepada wanita yang tidak bekerja.

Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat terdiri dari mekanik (kondom, diafragma) dan kimiawi (spermisid). Metode kontrasepsi sederhana ini sering digunakan bersama-sama antara mekanik dan kimiawi sehingga efektivitas kontrasepsi akan jauh lebih baik dan angka kegagalan semakin menurun.

a. Metode Kontrasepsi Sederhana tanpa Alat

1) Metode Kalender

Metode kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan dengan menghindari atau menunda hubungan seksual selama masa subur untuk mencegah kehamilan. Sebelum menggunakan metode ini, pasangan suami-istri perlu memahami masa subur yang bervariasi pada setiap perempuan. Masa subur biasanya terjadi pada hari ke-8 hingga ke-19 dalam siklus menstruasi, dengan dasar bahwa ovulasi umumnya terjadi 12–16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Untuk memastikan efektivitas, diperlukan pengamatan dan pencatatan siklus haid minimal selama 6 siklus, atau hingga 9 siklus untuk hasil yang lebih akurat. Namun, metode ini memiliki tantangan karena banyak perempuan tidak memiliki siklus haid yang teratur, sehingga sulit menentukan waktu ovulasi secara pasti. Kombinasi dengan kontrasepsi lain, seperti kondom, dapat meningkatkan keberhasilan metode ini. kalender, disarankan untuk mengombinasikannya dengan metode kontrasepsi lain, seperti penggunaan kondom.

a) Manfaat Metode Kalender

(1) Manfaat Kontrasepsi

- Dapat digunakan untuk mencegah atau merencanakan kehamilan.

- Dapat membantu pasangan yang ingin merencanakan kehamilan dengan memahami masa subur.
- Mendorong pasangan untuk bekerja sama dan meningkatkan pemahaman tentang siklus reproduksi.

(2) Manfaat Non Kontrasepsi

- Meningkatkan pengetahuan pasangan tentang sistem reproduksi.
- Membantu pasangan suami-istri menghindari hubungan seksual selama masa subur untuk mencegah kehamilan.
- Menambah pengetahuan kedua pasangan tentang masa subur/ovulasi, terutama bagi yang menginginkan keturunan.
- Memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pasangan.

b) Keuntungan Metode Kalender

Keuntungan menggunakan kontrasepsi metode kalender adalah sebagai berikut:

- (1) Metode kalender dapat digunakan oleh semua perempuan yang dalam kondisi sehat.
- (2) Dalam pelaksanaannya, metode kalender sangat mudah dan sederhana tanpa mengganggu pasangan suami-istri saat melakukan hubungan seksual.
- (3) Untuk menggunakan metode kalender, tidak diperlukan pemeriksaan khusus, maupun tempat pelayanan khusus.
- (4) Metode kalender dapat menghindari risiko yang timbul akibat efek kontrasepsi yang menggunakan alat, bahan, dan obat.
- (5) Metode kalender hanya menghindari hubungan seksual selama masa subur, tetapi tidak membatasi aktivitas seksual di luar waktu tersebut.

c) Kekurangan Metode Kalender

Kekurangan yang dimiliki oleh metode kalender adalah:

- (1) Penggunaan bersama kontrasepsi lain menjadikan metode kalender lebih efektif.
- (2) Harus ada komitmen, komunikasi, dan disiplin antara pasangan suami-istri dalam menggunakan metode kalender.
- (3) Pasangan suami-istri harus mengetahui secara tepat masa suburnya, dengan mengamati siklusnya minimal selama 6 kali haid secara berturut-turut; lebih baik jika observasi siklus dilakukan sampai 12 bulan.
- (4) Dengan metode kalender, pasangan suami-istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat jika menginginkan, karena harus menghindari masa subur.

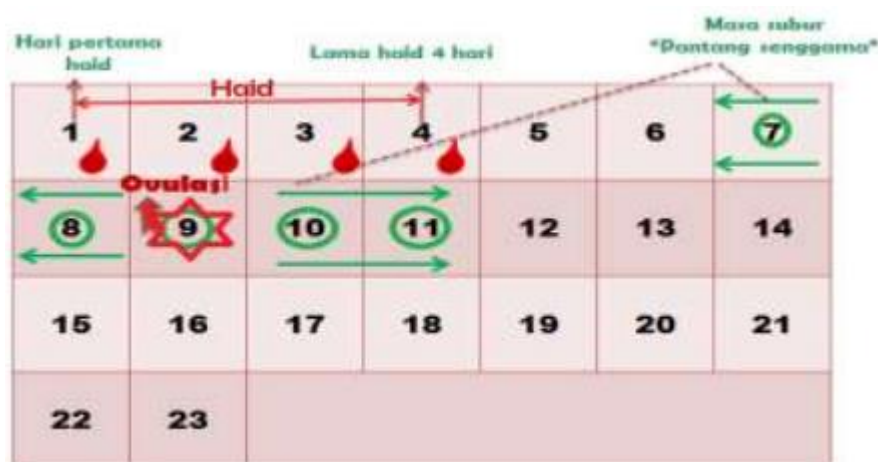
- (5) Untuk dapat menerapkan metode kalender dengan benar, perlu adanya contoh-contoh dan konseling secara intens.
- (6) Pasangan (istri) yang memiliki siklus haid tidak teratur akan sulit menggunakan metode kalender.
- (7) Mediator atau tenaga terlatih non-medis diperlukan untuk memastikan kesinambungan informasi dan komunikasi yang tepat.
- (8) Metode kalender tidak memberikan perlindungan terhadap penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

d) Cara Menentukan Masa Subur

Selain kemampuan menentukan masa subur, perlu diketahui bahwa kemampuan hidup sel telur setelah ovulasi adalah 24 jam, sedangkan kemampuan hidup sperma dalam saluran reproduksi adalah 3x 24 jam

(1) Haid dengan siklus pendek (23 hari)

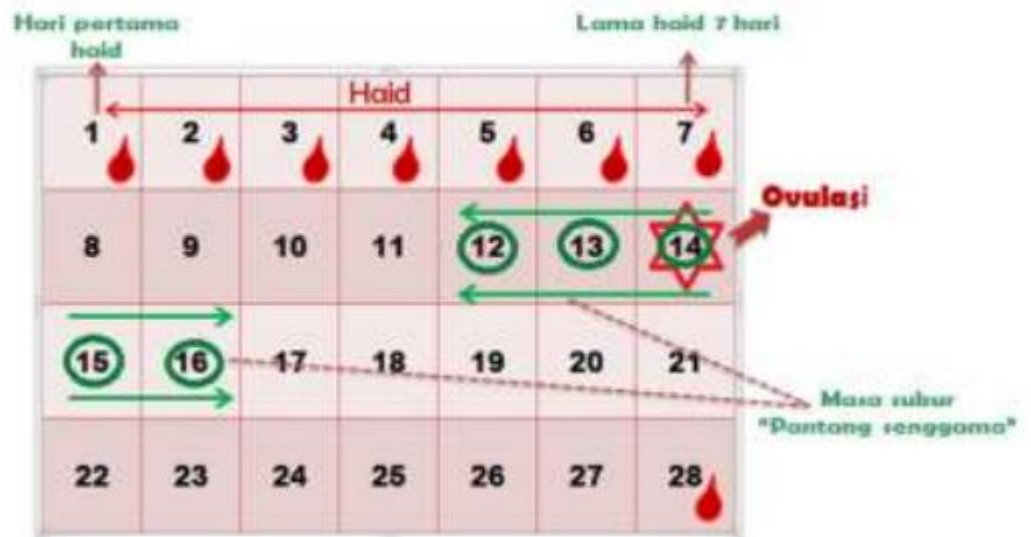
Hari pertama haid dalam siklus 23 hari jatuh pada tanggal 1 (hari ke-1), lama haid 4 hari dan ovulasi terjadi pada hari ke 14 sebelum haid yang akan datang yang jatuh pada tanggal 9. Sehingga masa subur terjadi 2 hari sebelum ovulasi yang jatuh pada tanggal 7 dan 8 dan 2 hari setelah ovulasi yang jatuh pada tanggal 10, 11 setelah ovulasi)



Gambar 1 Haid dengan siklus pendek (23 hari)

(2) Haid teratur dengan siklus normal (28 hari)

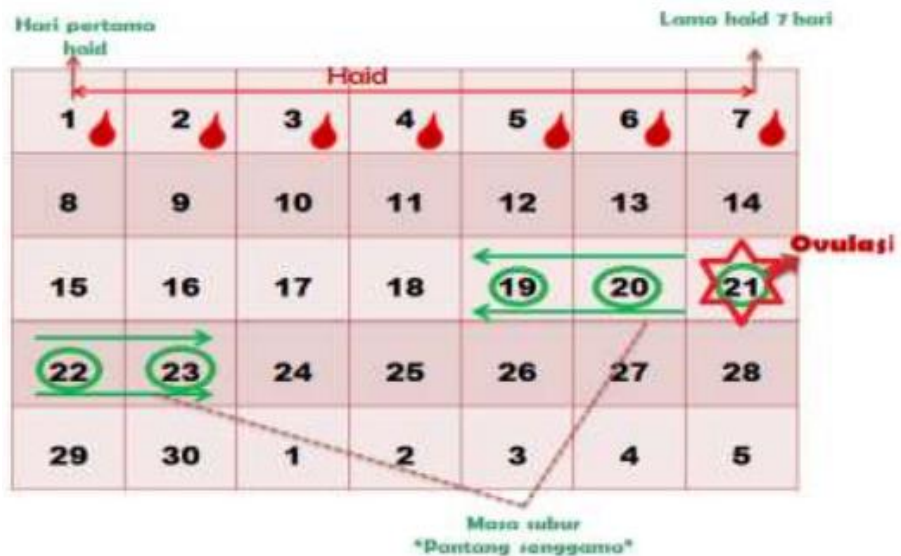
Hari pertama haid dalam siklus 28 hari jatuh pada tanggal 1 (hari ke-1) dan ovulasi terjadi pada hari ke 14 sebelum haid yang akan datang yang jatuh pada tanggal 14. Sehingga masa subur terjadi 2 hari sebelum ovulasi yaitu tanggal 12 dan 13 dan sesudah ovulasi yaitu tanggal 15, 16



Gambar 2 Haid teratur dengan siklus normal (28 hari)

(3) Haid dengan siklus panjang (35 hari)

Hari pertama haid dalam siklus 35 hari jatuh pada tanggal 1 (hari ke-1) dan ovulasi terjadi pada hari ke 14 sebelum haid yang akan datang yang jatuh pada tanggal 21. Sehingga masa subur terjadi 2 hari sebelum ovulasi yaitu tanggal 19,20 kemudian 2 hari setelah ovulasi yang jatuh pada tanggal 22 dan 23



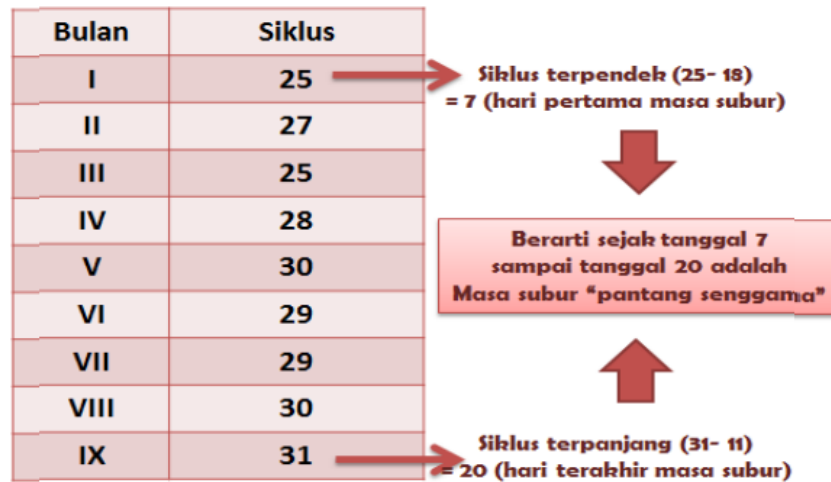
Gambar 3 (Haid dengan siklus panjang (35 hari))

(4) Haid yang tidak teratur

Yaitu dengan mencatat minimal 6x siklus haid sampai 12 siklus haid. Kemudian dari siklus terpendek – 18 (sebagai hari pertama masa subur) dan siklus terpanjang – 11 (sebagai hari terakhir masa subur). Misalnya siklus terpendek 25 hari – 18 = 7 dan siklus terpanjang – 11

= 20, sehingga tanggal 7 sampai tanggal 20 adalah masa subur pada siklus haid yang tidak teratur.

Contoh :



Gambar 4 Haid yang tidak teratur

2) Metode Suhu Basal Badan

Metode suhu basal badan (Basal Body Temperature, BBT) adalah teknik yang digunakan untuk menentukan masa subur wanita dengan cara mengukur suhu tubuh saat istirahat. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat, efek samping, keuntungan, kerugian, dan cara penggunaan metode ini.

a) Manfaat Metode Suhu Basal

- Menentukan Masa Subur: Metode ini membantu mengidentifikasi kapan ovulasi terjadi dengan memantau kenaikan suhu basal yang terjadi setelah ovulasi.
- Meningkatkan Kesadaran Tubuh: Wanita menjadi lebih sadar akan perubahan dalam tubuh mereka, termasuk pola siklus menstruasi dan tanda-tanda ovulasi.
- Deteksi Dini Kehamilan: Suhu yang tetap tinggi selama lebih dari 18 hari setelah ovulasi dapat menjadi indikasi awal kehamilan.
- Kendali Penuh: Wanita dapat mengontrol metode ini tanpa memerlukan alat kontrasepsi hormonal atau medis lainnya

b) Efek samping

- Ketidakakuratan: Pengukuran suhu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti infeksi atau gangguan tidur, yang bisa membuat hasilnya tidak akurat
- Keterbatasan dalam Penggunaan: Metode ini tidak efektif jika digunakan sendiri tanpa metode lain, terutama bagi wanita dengan siklus menstruasi yang tidak teratur

c) Keuntungan

- Alami dan Tanpa Efek Samping Kimia: Tidak ada efek samping kimiawi karena tidak menggunakan obat atau alat kontrasepsi.
- Mudah Digunakan dan Murah: Hanya memerlukan termometer basal dan sedikit perhatian terhadap pola suhu tubuh.
- Peningkatan Kesadaran Tubuh: Membantu wanita lebih memahami kondisi tubuh mereka, terutama terkait dengan siklus menstruasi.

d) Kerugian

- Memerlukan Disiplin yang Tinggi: Harus dilakukan setiap hari pada waktu yang sama, biasanya di pagi hari setelah bangun tidur.
- Mungkin Tidak Efektif jika Tidak Tepat: Suhu basal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penyakit, tidur yang tidak cukup, atau perubahan gaya hidup, yang dapat mengganggu akurasi metode.
- Tidak Memberikan Perlindungan dari Penyakit Menular Seksual (PMS): Metode ini hanya mencegah kehamilan dan tidak memberikan perlindungan dari PMS.

e) Cara penggunaan

- Pengukuran Suhu: Gunakan termometer basal untuk mengukur suhu tubuh setiap pagi, segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas apapun. Catat suhu setiap hari pada grafik atau aplikasi khusus.
- Identifikasi Perubahan Suhu: Suhu tubuh biasanya sedikit lebih rendah pada awal siklus menstruasi dan akan meningkat setelah ovulasi (sekitar 0,2–0,5 derajat Celsius) dan tetap tinggi selama fase luteal.
- Menentukan Masa Subur: Masa subur terjadi beberapa hari sebelum kenaikan suhu yang stabil. Pengamatan yang konsisten selama beberapa bulan dapat membantu menentukan pola suhu tubuh.
- Menghindari Kehamilan: Selama periode masa subur (sekitar beberapa hari sebelum dan sesudah ovulasi), hindari hubungan seksual atau gunakan metode kontrasepsi tambahan.

3) Metode Lender Serviks (ovulasi billings)

Metode ovulasi billings merupakan suatu metode manajemen kesuburan yang dapat membantu para wanita mengenali sinyal alami kesuburan tubuhnya melalui pengamatan lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi dengan mengidentifikasi waktu subur dan tidak subur dalam siklusnya (Jalilah & ruly, 2020).

Pengamatan lendir serviks digunakan dalam metode ovulasi Billings untuk menentukan kesuburan. Lendir serviks yang subur melindungi sperma dan

dapat mempertahankan daya pembuahan selama 3-5 hari. Tanpa lendir subur, sperma cepat rusak. Lendir serviks dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron, menghasilkan empat jenis lendir: S, L, P, dan G. Lendir subur (S dan P) muncul akibat estrogen, sedangkan lendir tidak subur (P dan G) muncul akibat progesteron. Ciri lendir subur: bening, licin, dan dapat direntangkan, sedangkan lendir tidak subur: pekat, lengket, dan tidak bisa direntangkan. Lendir subur muncul 5-7 hari sebelum ovulasi, sementara lendir tidak subur muncul setelah ovulasi hingga menjelang menstruasi. Pola lendir ini memungkinkan perempuan mengenali masa subur dan tidak subur, dengan siklus menstruasi 28 hari, setengahnya masa pantang dan setengahnya masa subur.

a) Kelebihan Metode Lendir Serviks (Amalia, Merlly . 2017)

- Mudah digunakan untuk mencegah kehamilan
- Dalam kendali wanita
- Metode alami dengan mengamati tanda –tanda kesuburan
- Memberikan kesempatan kepada pasangan menyentuh tubuhnya
- Tidak memerlukan biaya
- Meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada tubuh

b) Kekurangan Metode Lendir Serviks

Sebagai metode keluarga berencana (KB) alami mempunyai beberapa efek keterbatasan (Corniawati. 2017)

- Tidak cocok untuk wanita yang memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur tiap bulannya
- Membutuhkan komitmen
- Tidak efektif bila digunakan sendiri, alangkah lebih baiknya dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lainnya (misal dengan simptoothermal)
- Wanita yang menghasilkan sedikit lendir
- Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dapat menyamarkan tanda – tanda kesuburan

c) Hal yang mempengaruhi lendir serviks

Keadaan lendir serviks pada wanita dapat dipengaruhi oleh :

- Wanita yang menyusui
- Penggunaan kontrasepsi hormonal
- Penggunaan produk kesehatan wanita yg dimasukan dalam alat reproduksi / pengguna spermisida
- Perimenopause
- Operasi serviks dengan cryotherapy atau electrocautery

- Adanya vaginitis & infeksi menular seksual (IMS)

d) Instruksi pengamatan pada wanita pengguna ovulasi billings

Petunjuk pengamatan pada wanita pengguna metode ovulasi billing (Jalilah & Ruly, 2020 dan Rokayah dkk. 2021)

- Wajib mengenali pola kesuburan dan pola dasar ketidaksuburan
- Cara mengenali masa subur dengan memantau lendir serviks yang keluar dari vagina. Pengamatan dilakukan tiap hari sepanjang pemantauan dan wajib dicatat pada malam harinya
- Memeriksa lendir dengan jari tangan atau tisu diluar vagina serta amati perubahan perasaan kering dan basah yang dialami
- Pasangan suami istri dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual minimal selama satu siklus yang berguna untuk mengetahui jenis lendir normal pada pola subur maupun tidak subur
- Saat hari – hari kering (tidak ada lendir) setelah terjadinya menstruasi maka hubungan seksual tergolong aman pada dua hari setelah menstruasi.
- Lendir basah, jernih, elastis menunjukan masa subur (dilarang berhubungan seksual) namun lendir kental, keruh, kuning dan lengket menunjukan masa tidak subur maka dianjurkan untuk bersenggama.
- Berikan tanda (√) pada hari terakhir adanya lendir bening, licin dan elastis. Saat ini berupa hari puncak dalam pola subur (fase paling subur)
- Dilarang berhubungan seks dilanjutkan hingga tiga hari setelah puncak subur untuk menghindari terjadi ovulasi / pembuahan
- Periode tidak subur dimulai pada hari lendir kering ketika empat hari setelah puncak subur sehingga berhubungan seksual dapat dilakukan sampai datang menstruasi berikutnya

4) Metode Amenorrhoe Laktasi (MAL)

Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami yang memanfaatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif untuk menunda kehamilan. Metode ini bekerja dengan cara mempertahankan kadar hormon prolaktin yang tinggi akibat rangsangan dari hisapan bayi selama menyusui. Prolaktin yang meningkat akan menghambat pelepasan hormon Luteinizing Hormone (LH), yang berperan penting dalam proses ovulasi, sehingga indung telur tidak melepaskan sel telur ke rahim.

Pada ibu yang tidak menyusui, kadar prolaktin kembali normal sekitar empat minggu setelah melahirkan, dan siklus menstruasi cenderung kembali lebih cepat. Sebaliknya, pada ibu yang menyusui secara eksklusif dan sering,

kadar prolaktin tetap tinggi sehingga menghambat ovulasi lebih lama. Selain itu, hormon Follicle Stimulating Hormone (FSH), yang berperan dalam pematangan sel telur, juga cenderung lebih rendah selama periode menyusui.

Efektivitas MAL sangat bergantung pada pemberian ASI secara eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain selama enam bulan pertama setelah melahirkan. Dalam kondisi ini, MAL tidak hanya dapat menunda kembalinya siklus menstruasi tetapi juga memberikan perlindungan efektif terhadap kehamilan jika dilakukan dengan konsisten dan benar.

a) Manfaat

- Mencegah Kehamilan Secara Alami: Selama ibu menyusui secara eksklusif, tubuh akan memproduksi hormon prolaktin yang dapat menghambat ovulasi, sehingga mencegah kehamilan.
- Kesehatan Ibu dan Bayi: Memberikan ASI eksklusif membantu dalam pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi serta memberikan nutrisi terbaik bagi bayi.
- Tanpa Efek Samping Obat: Tidak ada pengaruh kimiawi atau efek samping yang sering terlihat pada kontrasepsi hormonal atau alat kontrasepsi lainnya.

b) Keuntungan

- Kontrasepsi yang Alami dan Aman: Tidak memerlukan penggunaan obat atau alat kontrasepsi.
- Meningkatkan Ikatan Ibu dan Anak: Memberikan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif yang kaya nutrisi dan mempererat hubungan dengan bayi.
- Tidak Memerlukan Biaya: Tidak ada biaya terkait dengan metode ini, karena hanya mengandalkan pemberian ASI.

c) Kerugian

- Hanya Efektif untuk 6 Bulan Pertama: Keefektifan berkurang setelah ibu mulai mengenalkan makanan tambahan atau setelah menstruasi kembali.
- Kesulitan dalam Menjaga Konsistensi: Beberapa ibu mungkin sulit untuk memberikan ASI eksklusif tanpa tambahan, yang dapat mempengaruhi efektivitas metode ini.

d) Cara penggunaan MAL

- ASI Eksklusif: Memberikan ASI eksklusif (tanpa tambahan makanan atau minuman lainnya) kepada bayi selama 6 bulan pertama setelah melahirkan.

- Tanpa Menstruasi: Efektivitas metode ini optimal jika ibu belum mengalami menstruasi kembali.
- Pemberian ASI secara Teratur: Ibu harus menyusui bayi minimal 6 kali sehari, termasuk pada malam hari, untuk menjaga kadar prolaktin tetap tinggi dan menghambat ovulasi.

5) Metode Coitusinterruptus

Coitus interruptus, atau yang dikenal sebagai pull-out method atau withdrawal method, adalah metode kontrasepsi sederhana di mana pria mengeluarkan penis dari vagina dan menjauhkannya dari vulva sebelum ejakulasi, untuk mencegah sperma memasuki vagina dan menghindari terjadinya kehamilan.

a) Kelebihan

Metode coitus interruptus memiliki kelebihan diantaranya:

- Efektif bila dilakukan dengan benar
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya
- Tidak terdapat efek samping
- Dapat digunakan setiap waktu sebagai metode kontrasepsi utama ataupun cadangan
- Tidak memerlukan biaya
- Tidak memerlukan persediaan atau kunjungan klinik
- Tidak memerlukan waktu pemulihan kembalinya kesuburan apabila menggunakan metode kontrasepsi coitus interruptus
- Meningkatkan keterlibatan suami dalam kegiatan keluarga berencana
- Meningkatkan bonding dan rasa saling pengertian antar pasangan

b) Kekurangan

- Tidak melindungi pasangan terhadap penyakit menular seksual
- Efektivitas sangat bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan coitus interruptus setiap melakukan aktivitas hubungan seksual
- Efektivitas menurun apabila pasangan akan melakukan hubungan seksual yang ke 2 atau ke 3 dan seterusnya dalam waktu yang berdekatan (dikhawatirkan ada sperma yang tertinggal di kepala penis)
- Mengurangi kenikmatan pada saat melakukan hubungan seksual.

c) Indikasi

Coitus interruptus tepat digunakan pada pasangan yang:

- Pasangan yang tidak memiliki metode kontrasepsi lain pada saat ingin melakukan hubungan seksual.
- Pasangan sedang menunggu untuk memulai metode kontrasepsi lain.
- Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur
- Pasangan yang membutuhkan metode pendukung
- Pasangan yang keberatan untuk menggunakan metode kontrasepsi lain baik dengan alasan Kesehatan ataupun kepercayaan.

d) Kontra Indikasi

- Pria yang mengalami ejakulasi dini.
- Pria yang mengalami kelainan fisik ataupun psikologis
- Pria yang kesulitan untuk konsisten melakukan coitus interruptus setiap melakukan hubungan seksual,
- Pasangan kurang dapat berkomunikasi satu sama lainnya
- Pasangan tidak bersedia melakukan coitus interruptus.

e) Instruksi Cara Melakukan

- Sebelum memutuskan untuk memilih kontrasepsi coitus interruptus pasangan harus membangun rasa saling mengerti dan harus mendiskusikan terkait pelaksanaan coitus interruptus
- Sebelum melakukan hubungan seksual, pria terlebih dahulu membersihkan penis, terutama apabila ingin mengulang hubungan seksual setelah terjadi ejakulasi. Pria harus mengosongkan kandung kemih, membasuh hingga bersih, kemudian mengeringkan ujung penis untuk memastikan tidak ada sisa sperma yang tertinggal di penis.
- Pada saat melakukan hubungan seksual, dan pria sudah merasa akan ejakulasi maka segera mengeluarkan penis dari liang vagina dan mengeluarkan cairan sperma di luar vagina. Dan pastikan sperma tidak mengenai bagian vulva
- Pastikan pria tidak terlambat mencabut penis dari vagina pada saat ejakulasi.
- Sebaiknya menghindari melakukan hubungan seksual pada masa subur.

2. Kontrasepsi Darurat

Kontrasepsi darurat adalah metode kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan setelah terjadi hubungan seksual tanpa perlindungan atau ketika metode kontrasepsi yang digunakan mengalami kegagalan, seperti kondom yang sobek atau lupa minum pil KB. Metode ini bertujuan untuk

mencegah kehamilan sebelum terjadinya implantasi sel telur yang telah dibuahi di dinding rahim.

a. Jenis Kontrasepsi Darurat:

1) Pil Kontrasepsi Darurat (Emergency Contraceptive Pills/ECP):

- a) Levonorgestrel: Diminum sesegera mungkin setelah hubungan seksual tanpa perlindungan, idealnya dalam waktu 72 jam (3 hari), namun dapat digunakan hingga 120 jam (5 hari) dengan efektivitas yang menurun. Levonorgestrel tersedia dalam dua dosis, yaitu 1,5 mg yang diminum sekali atau 0,75 mg yang diminum dua kali dengan jeda 12 jam.
- b) Ulipristal Asetat: Diminum sekali dalam dosis 30 mg, efektif hingga 120 jam setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Ulipristal asetat lebih efektif dibandingkan levonorgestrel dalam mencegah kehamilan.

2) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Tembaga:

- a) Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim oleh tenaga medis dalam waktu 5 hari setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. AKDR tembaga sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi jangka panjang hingga 10 tahun.

3) Cara Kerja:

a) Pil Kontrasepsi Darurat:

- Mencegah atau menunda ovulasi (pelepasan sel telur dari ovarium).
- Mengganggu proses fertilisasi (pembuahan) dengan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit mencapai sel telur.
- Tidak efektif jika sel telur yang telah dibuahi sudah berimplantasi di dinding rahim.

b) AKDR Tembaga

- Mengganggu pergerakan sperma sehingga pembuahan tidak terjadi.
- Mencegah implantasi sel telur yang telah dibuahi di dinding rahim.

4) Efektivitas

- a) Pil kontrasepsi darurat lebih efektif jika diminum secepat mungkin setelah hubungan seksual tanpa perlindungan. Efektivitasnya mencapai lebih dari 95% jika dikonsumsi dalam 24 jam pertama dan menurun seiring berjalannya waktu.
- b) AKDR tembaga adalah metode kontrasepsi darurat paling efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%.

5) Efek Samping:

a) Pil Kontrasepsi Darurat:

- Mual, muntah.
- Pusing, lemas.

- Nyeri payudara.
 - Gangguan menstruasi (haid lebih awal atau terlambat).
- b) AKDR Tembaga:
- Kram atau nyeri di perut setelah pemasangan.
 - Pendarahan atau spotting.

B. Pelayanan kontrasepsi pasca aborsi (Kondom, Pil, Suntik)

Pasca aborsi, tubuh wanita membutuhkan waktu untuk pulih, tetapi ovulasi dapat kembali terjadi dalam waktu singkat (kurang dari dua minggu). Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi segera sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan alat mencakup penggunaan perangkat yang dirancang untuk mencegah kehamilan. Dua metode yang umum digunakan adalah kondom dan diafragma (spermisida).

1. Kondom

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi berbentuk selubung atau tabung yang tidak tembus cairan. Kebanyakan kondom terbuat dari karet atau lateks, tetapi ada juga yang terbuat dari plastik (vinil, polietilen) dan bahan alami yang berasal dari jaringan hewan (kulit domba). Kondom berbentuk silinder dengan lapisan pangkal yang tebal dan terbuka, memiliki ujung yang buntu berfungsi sebagai penampung sperma, bila digulung berbentuk rata.

a. Cara kerja

Sebagai salah satu alat kontrasepsi dengan metode barrier, cara kerja kondom adalah menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan menahan sel sperma tetap berada di ujung selubung karet kondom yang terpasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Selain itu kondom juga dapat digunakan sebagai pelindung terhadap penularan infeksi menular seksual, termasuk HIV apabila digunakan dengan benar (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil).

b. Jenis – jenis kondom

Klasifikasi kondom berdasarkan pemakaian terdiri dari kondom untuk pria dan wanita:

1) Kondom Pria

Kondom untuk pria berbentuk lonjong seperti selubung atau tabung dan umumnya terbuat dari karet tipis. Memiliki diameter kurang lebih 31-36,5 mm dan panjang kurang lebih 19 mm. Standar ketebalan kondom yaitu 0,02-0,05 mm. Kondom ini dipasang pada penis sebelum memulai hubungan seksual, berfungsi sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak masuk ke dalam

vagina. Bentuknya ada dua macam, yaitu polos dan berputing. Kelebihan dari kondom berputing yaitu untuk menampung sperma setelah terjadi ejakulasi.

2) Kondom Wanita

Kondom untuk wanita dirancang khusus dalam bentuk silinder dengan panjang kurang lebih 15 cm dan garis tengah kurang lebih 7 cm. Kondom ini memiliki dua cincin lentur yang berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom. Cincin yang kecil (inner ring) menyerupai diafragma dimasukkan ke dalam vagina ke arah mulut rahim, sedangkan cincin yang lebih besar (outer ring) berfungsi untuk mempertahankan kondom agar tetap berada di luar vagina.

Umumnya, kondom wanita terbuat dari bahan polyurethane yang kurang menyebabkan reaksi alergi dibandingkan kondom lateks. Bahan tersebut lebih lembut, lebih fleksibel, lebih kuat, dan jarang robek (40% lebih kuat dari kondom lateks) serta lebih tipis sehingga sensasi hubungan seksual tetap dapat dipertahankan. Manfaat, keterbatasan, maupun efek samping yang ditimbulkan dari kondom wanita hampir sama dengan kondom pria. Kondom ini dapat mencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual termasuk HIV apabila digunakan dengan benar.



Gambar 4 kondom wanita

Saat ini, kondom tersedia dalam berbagai tekstur dan aroma. Beberapa jenis kondom yang banyak beredar di pasaran antara lain:

1) Kondom berpelumas

Telah dikembangkan variasi kondom yang berpelumas mengandung spermisida berwarna, memiliki rasa, dan beraroma.

2) Kondom anti alergi

- a) Terbuat dari karet lateks dengan rendah residu dan tidak dipralubrikasi.
- b) Kondom dengan aroma dan rasa
- c) Kondom berulir (Ribbed Condom)
- d) Memiliki permukaan karet yang berulir.
- e) Kondom ekstra tipis (Extra Thin Condom)
- f) Berbahan dasar karet dengan ukuran yang sangat tipis.

- 3) Kondom bintik (Dotted Condom)
 - a) Terdapat bintik-bintik pada permukaannya.
 - b) Kondom ekstra pengaman (Extra Safe Condom)
 - c) Memiliki tambahan lubrikan, serta mengandung perlindungan ekstra untuk mencegah kehamilan.
 - d) Kondom twist
 - e) Didesain secara khusus untuk menstimulasi area sensitif pada saat bersenggama.
- 4) Kondom getar (Vibrating Condom) Dilengkapi dengan cincin bergetar di bagian ujungnya yang menggunakan baterai khusus untuk menggerakkan cincin tersebut. Getaran pada kondom ini bisa bertahan hingga 30 menit.
- 5) Kondom baggy
 - a. Memiliki bentuk yang agak membesar di bagian ujung dan memiliki ulir di bagian badannya.
 - b. Kondom dengan tambahan obat kuat (Condoms with extra strong medicine)
 - c. Dilengkapi dengan lubrikan yang mengandung obat kuat.
 - d. Efektifitas kondom

Pemakaian kondom akan efektif jika digunakan secara baik dan benar serta konsisten setiap sebelum melakukan hubungan seksual. Angka kegagalan penggunaan kondom pria sangat sedikit, yaitu 2-13 kehamilan per 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Sedangkan angka kegagalan penggunaan kondom wanita adalah 5-21 kehamilan per 100 perempuan pada tahun pertama penggunaan. Selain itu, jika digunakan secara tepat, kondom memiliki keefektifan 80-95% dalam mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV.

Umumnya, kegagalan kondom terjadi bila karet kondom bocor atau robek, dan menarik penis setelah melemah sehingga sebagian sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Kehamilan dapat terjadi akibat penggunaan atau penanganan kondom yang tidak tepat. Kondom yang digunakan bersamaan dengan metode pantang berkala, spermisida, dan kontrasepsi oral mempunyai efektivitas yang semakin meningkat.

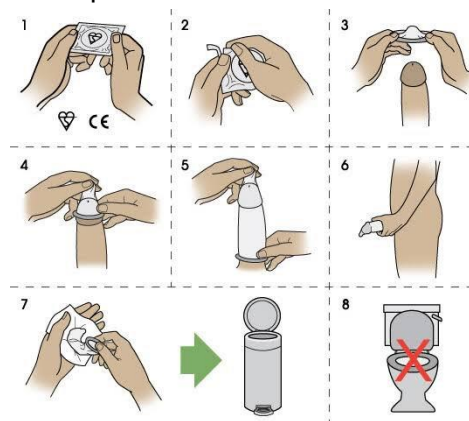
- e. Manfaat kondom
 - Memberi dorongan pria untuk berperan dalam program KB
 - Mencegah penularan IMS
 - Mencegah ejakulasi dini
 - Mengurangi insidensi kanker serviks dengan mencegah penularan HPV

- Timbulnya interaksi sesama pasangan
- Mencegah imuno-infertilitas.

f. Keterbatasan kondom

- Perlu digunakan secara hati-hati agar efektif
- Beberapa klien akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan ereksi
- Efektivitas tidak terlalu tinggi dan bergantung pada cara penggunaan kondom yang baik dan benar
- Adanya pengurangan sensitivitas pada penis
- Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual
- Ada perasaan malu ketika membeli di tempat umum
- Kondom wanita dapat terdorong masuk ke dalam vagina selama berhubungan seksual
- Pembuangan kondom bekas pakai akan menjadi masalah tersendiri
- Hanya dapat digunakan satu kali saja
- Membutuhkan latihan dan kesabaran dalam memasang kondom wanita dengan tepat.

g. Cara penggunaan kondom pria



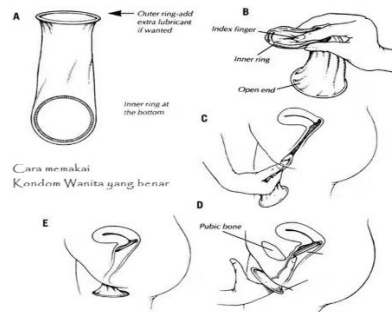
Gambar 5 cara penggunaan kondom pria

- Pastikan kemasan kondom dalam kondisi baik dan belum kedaluwarsa. Tekan bagian kemasan untuk memastikan tidak ada kebocoran udara, yang menunjukkan kondom masih utuh.
- Buka kemasan kondom menggunakan tangan. Hindari menggunakan benda tajam seperti gunting atau kuku agar kondom tidak rusak.
- Pegang ujung kondom (reservoir) dan pastikan gulungan berada di luar agar mudah digulung ke bawah.
- Letakkan ujung kondom di kepala penis yang sudah ereksi, sambil mencubit ujung kondom (reservoir) untuk mengeluarkan udara. Ini

membantu mencegah tekanan udara di dalam yang dapat menyebabkan kondom pecah.

- Gulung kondom hingga menutupi seluruh bagian penis dengan rapat. Pastikan kondom terpasang dengan benar dan tidak ada udara di dalamnya.
- Pastikan kondom tetap berada pada posisinya selama hubungan seksual untuk mencegah kebocoran atau tergelincir.
- Setelah ejakulasi dan sebelum penis kehilangan ereksi, pegang bagian pangkal kondom dan tarik penis keluar dengan hati-hati untuk menghindari kebocoran sperma.
- Ikat ujung kondom untuk mencegah tumpahnya cairan, bungkus dengan tisu, dan buang ke tempat sampah. Jangan buang kondom ke toilet karena dapat menyebabkan saluran pembuangan tersumbat.

h. Cara penggunaan kondom Wanita



Gambar 6 Cara penggunaan kondom wanita

- Periksa kondisi kemasan untuk memastikan kondom tidak rusak dan masih dalam masa kedaluwarsa. Kenali bagian kondom, yaitu inner ring (cincin bagian dalam) di ujung tertutup dan outer ring (cincin bagian luar) di ujung terbuka.
- Tekan cincin bagian dalam (inner ring) menggunakan jari telunjuk dan ibu jari hingga berbentuk lonjong untuk mempermudah pemasangan (gambar B).
- Masukkan kondom ke dalam vagina dengan posisi tubuh yang nyaman (berdiri dengan satu kaki diangkat atau duduk), masukkan cincin bagian dalam (inner ring) ke dalam vagina. Dorong cincin tersebut menggunakan jari telunjuk sejauh mungkin hingga mendekati leher rahim (gambar C).
- Pastikan kondom berada dalam posisi benar dengan cincin luar (outer ring) menutupi bagian luar vagina. Kondom harus berada dalam posisi lurus tanpa melipat atau terpuntir.

- Saat hubungan seksual berlangsung, pastikan cincin luar tetap berada di luar vagina dan tidak tergeser. Kondom wanita akan menampung sperma untuk mencegah kehamilan dan penularan penyakit menular seksual.
- Setelah selesai, pegang cincin luar (outer ring) dengan hati-hati dan tarik kondom keluar secara perlahan agar cairan sperma tidak tumpah (gambar E).
- Ikat bagian ujung kondom untuk mencegah cairan tumpah, lalu buang ke tempat sampah. Jangan membuang kondom ke toilet karena dapat menyumbat saluran pembuangan.

2 Kontrasepsi Modern

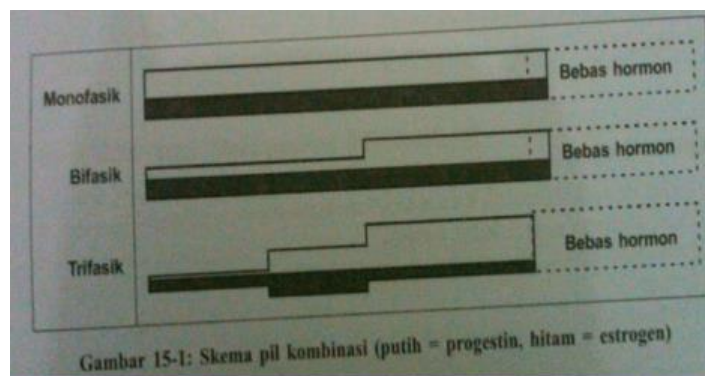
a. Pil kombinasi

Pil KB kombinasi adalah pil yang mengandung kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron. Metode ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi (hampir sama dengan efektivitas tubektomi). Metode KB ini memiliki angka kegagalan sebesar 9% atau 1 orang dari 11 pemakai pil mengalami kehamilan. Konsumsi setiap hari sesuai cara penggunaan dan tidak ada riwayat kesalahan konsumsi akan meningkatkan efektivitas < 1 kehamilan per 100 wanita pada tahun pertama (3 per 1000 wanita).

1) Cara kerja pil kombinasi

Bekerja terutama dengan mencegah pelepasan sel telur dari ovarium (ovulasi), mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui sperma, pergerakan tuba terganggu sehingga mengganggu pergerakan sel telur.

2) Jenis pil kombinasi



Gambar 7 jenis pil kombinasi

a) Monofasik

Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi hormon aktif estrogen/progestin dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.

b) Bifasik

Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi hormon aktif estrogen/progestin dengan 2 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.

c) Trifasik

Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang berisi hormon aktif estrogen/progestin dengan 3 dosis yang berbeda, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif.

3) Kelebihan, Efek Samping, dan Resiko Kesehatan

a) Kelebihan

- Tidak mengganggu hubungan seksual
- Kesuburan bisa kembali segera setelah penggunaan pil dihentikan
- Dapat dihentikan penggunaannya kapan saja
- Membantu melindungi terhadap : kanker ovarium, kanker endometrium, penyakit radang panggul, kista ovarium, dan anemia defisiensi besi.
- Mengurangi : nyeri haid, gejala PCOS (perdarahan tidak teratur, jerawat, pertumbuhan rambut berlebihan di wajah dan badan), gejala endometriosis (nyeri panggul, perdarahan tidak teratur)

b) Efek samping

- Merubah pola perdarahan haid (darah lebih sedikit dan hari lebih pendek, haid tidak teratur, bahkan tidak haid)
- Sakit kepala, pusing, mual
- Nyeri payudara
- Kenaikan berat badan
- Meningkatkan tekanan darah
- Tidak melindungi dari Infeksi Menular Seksual (IMS)

c) Resiko kesehatan

Jarang terjadi : Pembekuan darah pada pembuluh vena kaki atau paru-paru (trombosis vena atau emboli paru). Sangat jarang terjadi : Stroke, serangan jantung.

4) Indikasi dan Kontraindikasi Pil KB Kombinasi

a) Indikasi

- Wanita usia reproduksi.
- Belum atau sudah memiliki anak.
- Berat badan gemuk atau kurus.
- Setelah melahirkan tanpa menyusui eksklusif.
- Pasca keguguran, aborsi, atau kehamilan ektopik.

- Mengalami anemia akibat haid.
- Nyeri haid hebat.
- Siklus menstruasi tidak teratur.
- Riwayat kehamilan ektopik.
- Kelainan payudara jinak.
- Penderita diabetes tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata, atau saraf.
- Penderita HIV, baik yang sedang menjalani terapi ARV maupun tidak.

b) Kontraindikasi

- Hamil/diduga hamil
- Perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya
- Menyusui
- Penyakit hati akut (hepatitis)
- Penyakit jantung, stroke, atau tekanan darah > 180/110 mmHg
- Perokok dengan usia > 35 tahun
- Riwayat gangguan pembekuan darah/kencing manis > 20 tahun
- Migrain dan gejala neurologis fokal (riwayat epilepsi)
- Kanker payudara atau riwayat kanker payudara
- Sering lupa menggunakan pil

5) Cara Penggunaan

Pil kombinasi bisa digunakan setiap saat dan tidak sedang hamil. Kondisi klien yang berbeda menyebabkan beberapa perbedaan waktu dimulainya penggunaan.



Gambar 8 Pil Kombinasi

a) Siklus haid teratur dan kontrasepsi sebelumnya kontrasepsi non-hormonal

- Pil kombinasi diberikan pada hari ke 1-5 siklus haid (tidak perlu tambahan metode kontrasepsi lain).

- Jika pemberian melebihi hari ke 5 siklus haid, memerlukan metode kontrasepsi lain selama 7 hari pertama, atau hindari berhubungan seksual selama 7 hari.
- b) Tidak haid (amenorea) (bukan karena menyusui atau pasca persalinan)
Dapat diberikan setiap saat asal yakin tidak hamil. Memerlukan metode kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama, atau hindari berhubungan seksual selama 7 hari.
- c) Kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi hormonal
 - Dapat segera diberikan. Jika kontrasepsi sebelumnya digunakan dengan benar dan dipastikan tidak sedang hamil, tidak perlu menunggu haid berikutnya dan tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan.
 - Kontrasepsi sebelumnya adalah kontrasepsi suntikan, pil kombinasi dapat diberikan saat jadwal suntikan ulang.
- d) Pasca Keguguran
 - Segera diberikan (kurang dari 7 hari pasca keguguran)
 - Lebih dari 7 hari pasca keguguran, pil kombinasi diberikan kapan saja asal yakin tidak hamil.
- 6) Instruksi pada Klien
 - a) Pil kombinasi diminum setiap hari pada waktu yang sama
 - b) Pil pertama diminum pada hari 1-7 siklus haid atau disesuaikan dengan cara penggunaan pada poin 5.
 - c) Pemakaian berdasarkan jumlah pil
 - Paket 28 pil : jika paket 28 pil habis, langsung melanjutkan minum pil dari paket yang baru
 - Paket 21 pil : jika paket 21 pil habis, sebaiknya tunggu
 - 1 minggu baru kemudian mulai minum pil dari paket yang baru
 - d) Klien muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, minum pil yang lain (ulangi minum).
 - e) Klien muntah hebat atau diare >24 jam setelah minum pil, jika keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk keadaan klien, pil dapat diteruskan.
 - f) Muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, cara penggunaan mengikuti kondisi klien lupa minum pil.
 - g) Klien lupa 1 pil (hari 1-21), minum segera pil yang terlupa begitu ingat, walau harus minum 2 pil pada hari yang sama.
 - h) Klien lupa 2 pil atau lebih (hari 1-21), minum 2 pil setiap hari sampai sesuai dengan jadwal minum yang ditetapkan begitu ingat (gunakan

metode kontrasepsi lain atau tidak melakukan hubungan seksual sampai paket pil tersebut habis).

i) Klien tidak haid, lakukan tes kehamilan.

b. Pil progestin

Pil KB Progestin, banyak disebut sebagai mini pil, sebuah kontrasepsi oral yang berisikan hormon progesterone saja. Pil ini mampu bereaksi memberikan perlindungan setelah pemakaian pertama kali dalam 2 hari. Mini pil juga dapat diberikan pada wanita pasca keguguran. Bila klien, sebelumnya menggunakan kontrasepsi hormonal kemudian ingin beralih pada kontrasepsi ini, setelah dipastikan tidak hamil, maka tidak perlu menunggu masa haid berikutnya, maka ia diperbolehkan segera mengonsumsi pil ini. Terdapat beberapa kemasan pil progestin, yakni:

- Kemasan isi 35 Pil Memiliki kandungan 300µg levonorgestrel atau 350µg noretindron.
- Kemasan isi 28 pil Memiliki kandungan 75µg desogestrel
(Saifuddin, 2012)

1) Mekanisme

Kontrasepsi mini pil memiliki beberapa mekanisme untuk mengaktifkan dirinya sebagai alat kontrasepsi.

- a) Pil meningkatkan jumlah dan mengentalkan lendir serviks yang mencegah penetrasi dari sperma pada organ bawah Rahim.
- b) Pil ini juga mampu menekan ovulasi yang akan terjadi. Kondisi ini berbeda efek sampingnya pada setiap wanita, ditemukan terdapat 60% pengguna wanita dengan pil levonorgestrel yang mengalami anovulatory. Ovulasi juga mampu ditekan 97% pada wanita yang menggunakan pil desogestrel.
- c) Endometrium juga mengalami transformasi lebih awal sehingga mempersulit proses implantasi dan mereduksi aktivitas silia pada tuba falopii sehingga perpindahan ovum menjadi lambat.
- d) Mini pil juga menekan sekresi gonadotropin dari sintesis steroid seks di ovarium.

(Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, 2009)

2) Efektivitas

Kontrasepsi pil progestin secara oral memiliki angka kegagalan yang cukup tinggi jika memang konsumsi yang dilakukan tidak sama untuk waktu minum setiap harinya. Efektivitas level obat masuk dalam sirkulasi darah kurang lebih bertahan hingga 22 jam. Tenaga Kesehatan juga penting

mengingatkan kepada akseptor KB, untuk jangan sampai terlupa 1-2 tablet, dan juga jangan sampai terjadi gangguan gastrointestinal seperti muntah / diare, karena kemungkinan kehamilan akan sangat besar. Penggunaan obat mukolitik asetilsistein bersamaan dengan mini pil juga perlu dihindari, karena mukolitik dapat meningkatkan penetrasi sperma, sehingga akan mengganggu kemampuan kontraseptif.

3) Keuntungan Penggunaan Kontrasepsi

Pil kontrasepsi ini cocok diberikan untuk perempuan yang sedang menyusui namun masih ingin menggunakan proteksi ganda. Dengan dosis yang rendah maka ada beberapa keuntungan menggunakan mini pil:

- a) Tidak menimbulkan resiko tromboemboli
- b) Cocok digunakan bagi penderita diabetes
- c) Kesuburan / fertilitas cepat Kembali
- d) Dapat dihentikan setiap saat
- e) Cocok bagi pengguna yang kontraindikasi dengan estrogen seperti mereka yang pengguna rokok menahun
- f) Nyaman dan mudah untuk digunakan

Bagi wanita yang memilih untuk menggunakan pil ini dalam jangka Panjang, dapat digunakan hingga usia 55 tahun sampai tingkat fertilitasnya secara alami akan menurun. Sebagai bahan pertimbangan, para wanita berusia lebih dari 50 tahun dan mengalami amenorrhoeic, mereka dapat melanjutkan penggunaan pil ini hingga melakukan pengecekan kadar FSH selama 6 minggu. Jika hasil pengukuran FSH >30 IU/l ini menandakan adanya kegagalan ovarium dan bisa melanjutkan penggunaan pil maksimal selama 1 tahun.

4) Resiko

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pil ini tidak meningkatkan resiko kehamilan dengan penambahan berat badan maupun body mass index seorang wanita. Jika terjadi sebuah kehamilan, dalam penelitian menyebutkan hanya 1 dari 10 kehamilan yang memiliki resiko hamil ektopik. Perlu adanya pertimbangan penggantian kontrasepsi jika para wanita merasa

- a) Perdarahan pervaginam yang tidak jelas penyebabnya
- b) Menggunakan obat tuberkulosis (rifampicin) atau obat epilepsi (fenitoin dan barbiturat)
- c) Memiliki Riwayat kanker atau menderita kanker payudara
- d) Mioma uterus (progestin dapat memicu pertumbuhan miom)

- e) Riwayat stroke (progestin dapat menyebabkan spasme pembuluh darah). Kurang lebih 30-60% wanita mengalami gangguan haid bisa berupa spotting dan amenorea pada 2-3 bulan pertama pemakaian kontrasepsi. Pil ini tidak melindungi diri seorang wanita dari infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Hirsutisme (tumbuhnya rambut atau bulu berlebihan di sekitar area wajah) juga dapat menjadi salah satu resiko yang terjadi, namun angka kejadiannya tidak banyak. Segera datang ke dokter / bidan maupun tenaga kesehatan di klinik terdekat jika menjumpai masalah :
 - f) Beberapa bulan mengalami haid teratur, kemudian terlambat, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya proses kehamilan.
 - g) Mengalami keluhan bercak perdarahan disertai nyeri perut hebat, maka perlu dipikirkan adanya resiko kehamilan ektopik.
 - h) Problem Mata, dimana akseptor merasakan kehilangan penglihatan dan pandangan kabur, nyeri kepala hebat, maka perlu kewaspadaan adanya hipertensi maupun problem vaskuler lainnya.
- c. Kontrasepsi injeksi 1 bulan

KB suntik 1 bulan atau suntik bulanan merupakan kontrasepsi kombinasi yang mengandung 2 hormon, yaitu progesteron dan estrogen seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh wanita. Biasanya disebut juga kontrasepsi kombinasi, selain pil kombinasi yang berisi hormon yang sama (Wilopo, 2015).

Suntikan bulanan ini ada beberapa merk dagang yang ada, yaitu yang mengandung MPA (Medroxyprogesterone Acetate)/estradiol cypionate dan norethisterone enanthate (NETEN)/estradiol valerate. Cyclofem, Cyclofem, Cyclofemina, CycloProvera, Lunella, Novafem, dan lainnya yang dipasarkan dengan merk dagang tersebut berisi 25 mg MPA dan 5 mg estradiol cypionate. Sedangkan untuk merk dagang Mesygna dan Norigynon berisi 50 mg NET-EN dan 5 mg estradiol valerate dipasarkan dengan (Wilopo, 2015)

Cara kerja utama dari kontrasepsi ini adalah dengan mencegah pelepasan ovum dari ovarium (menekan ovulasi), mengentalkan lendir serviks, membuat atrofi jaringan endometrium. Efektivitas suntik bulanan ini bergantung dari ketepatan waktu saat kunjungan ulang. Risiko besar terjadi kehamilan apabila klien terlambat datang atau melewatkan saat kunjungan ulang. Ketika wanita menggunakan tepat waktu kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita pada tahun pertama (5 per 10.000 wanita) (Wilopo, 2015).

Rata – rata 5 bulan setelah suntik bulanan terakhir, wanita tersebut bisa hamil, setelah berhenti menggunakan suntik bulanan, seorang wanita mungkin akan mengalami ovulasi sebelum siklus menstruasinya. Penelitian yang dilakukan

oleh Harni (2017) rata – rata waktu kembali hamil setelah suntik bulanan yang terakhir yaitu 4,12 bulan, lebih cepat hamil dibandingkan dengan suntik 3 bulan yang rata – rata hamil setelah 8,63 bulan.

Beberapa keuntungan dari suntikan bulanan baik secara kontrasepsi dan non kontrasepsi adalah:

- 1) Risiko terhadap kesehatan kecil dan tidak berpengaruh pada hubungan suami istri
- 2) Tidak perlu penggunaan setiap hari dan dapat dihentikan kapan saja
- 3) Efek jangka panjang sehingga baik untuk menjarangkan kehamilan
- 4) Mengurangi nyeri haid, jumlah perdarahan
- 5) Mencegah anemia

Kerugian dari kontrasepsi suntik bulanan ini antara lain:

- 1) Perubahan pola menstruasi (menstruasi tidak teratur, bisa lebih sedikit dan pendek, ataupun amenorea)
- 2) Bergantung pada pelayanan Kesehatan karena harus kembali tiap 10 hari untuk mendapatkan suntikan
- 3) Efektivitas berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat – obat epilepsi dan tuberkulosis (Rifampisin)
- 4) Tidak melindungi dari IMS
- 5) Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah berhenti pemakaian

1) Indikasi

Yang boleh menggunakan suntikan kombinasi ini adalah:

- a) Usia reproduktif
- b) Telah memiliki anak, ataupun yang belum memiliki anak
- c) Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas tinggi
- d) Anemia
- e) Pascapersalinan dan tidak menyusui (apabila menyusui boleh digunakan pasca persalinan lebih dari 6 bulan)
- f) Haid teratur
- g) Sering lupa bila menggunakan kontrasepsi pil

2) Kontraindikasi

Kontraindikasi pada penggunaan kontrasepsi bulanan ini adalah:

- a) Hamil atau diduga sedang hamil
- b) Menyusui di bawah 6 bulan pasca salin
- c) Usia di atas 35 tahun yang merokok

- d) Riwayat penyakit hati, jantung, stroke, kelainan tromboemboli, atau dengan hipertensi, diabetes > 20 tahun
- e) Memiliki keganasan pada payudara
- f) Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migraine

3) Efek Samping dan Penanggannya

Beberapa wanita mungkin akan mengalami beberapa efek samping setelah pemakaian suntikan bulanan di antaranya yaitu:

- a) Menstruasi tidak teratur, jelaskan pada klien bahwa hal ini tidak membahayakan dan biasanya akan berhenti atau berkurang setelah beberapa bulan pertama pemakaian. Untuk meringankan keluhan jangka pendek bisa diberikan obat – obatan golongan NSAID seperti ibuprofen 3x1 selama 5 hari. Apabila keluhan berlanjut atau dicurigai terjadi hal yang tidak benar bisa dilakukan rujukan (Wilopo, 2015)
- b) Amenorea, apabila klien dipastikan tidak terjadi kehamilan tidak diperlukan pengobatan khusus. Klien dianjurkan kembali ke klinik apabila tidak datangnya menstruasi menjadi masalah. Apabila terjadi kehamilan, rujuk klien, hentikan penyuntikan, dan jelaskan bahwa pengaruh hormon dalam kontrasepsi sedikit sekali pengaruhnya pada janin (Affandi, 2016)
- c) Mual/ pusing/ muntah, pastikan klien tidak hamil dan hal ini adalah biasa, serta akan hilang dalam waktu dekat. Bila klien hamil lakukan rujukan (Affandi, 2016)

d. Kontrasepsi injeksi 3 bulan

KB suntik 3 bulan adalah alat kontrasepsi yang menggunakan single hormon medroksiprogesteron asetat (MPA) yang diberikan secara injeksi setiap 3 bulan sekali . Medroksiprogesteron asetat (MPA) disebut juga sebagai depot medroksiprogesteron asetat (DMPA) dan dijual dengan nama merek Depo-Provera yang mengandung hormon progestin. Depo-Provera ini sangat cocok untuk ibu post partum karena tidak mengganggu proses laktasi (Prawita & Gulo, 2019).

KB suntik 3 bulan mengandung hormon progesteron dan disuntikkan melalui bokong atau lengan atas setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Cara kerja KB suntik tersebut adalah menghambat pembuahan atau ovulasi dan menipiskan dinding endometrium. Setelah hormon progestin disuntikkan, maka secara perlahan hormon progestin tersebut akan dialirkan secara bertahap pada pembuluh darah dan hormon progestin akan bekerja untuk mencegah proses pembuahan dengan melalui 3 mekanisme yaitu : (1) Menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium, (2) Mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga spermatozoa terhalang dan sulit masuk ke tuba falopii untuk

melakukan pembuahan, (3) Membuat lapisan rahim menjadi tipis, sehingga jika ada sel yang berhasil dibuahi hasil konsepsi tersebut tidak akan berkembang karena kondisi uterus yang tidak mendukung (Affandi, 2014).

1) Kelebihan dan efek samping

KB suntik 3 bulan memiliki efektivitas tinggi dan efisien, tetapi disertai beberapa efek samping:

- a) Waktu kembali subur lama: Dibutuhkan waktu 10 bulan atau lebih untuk hamil kembali setelah berhenti menggunakan KB ini (Affandi, 2014).
- b) Mempengaruhi kepadatan tulang: Kandungan DMPA dapat menyebabkan hilangnya massa tulang, meski bersifat sementara dan risiko meningkat jika digunakan lebih dari dua tahun, seperti yang diperingatkan oleh FDA (Purwoastuti & Walyani, 2015).
- c) Perubahan siklus haid: Haid menjadi tidak teratur, dari pendarahan banyak hingga sedikit atau berhenti sepenuhnya setelah satu tahun pemakaian. Siklus haid biasanya kembali normal setelah suntikan dihentikan (Setyorini & Lieskusumastuti, 2020).
- d) Kenaikan berat badan: KB ini dapat menyebabkan retensi cairan, memicu kenaikan berat badan (Prawita & Gulo, 2019).
- e) Efek fisik lain: Beberapa wanita mengalami mual, sakit perut, kembung, sakit kepala, nyeri payudara, bercak darah, perubahan suasana hati, jerawat, rambut rontok, hingga menurunnya hasrat seksual (Yulizawati et al., 2019).
- f) Tidak melindungi dari IMS: KB ini tidak mencegah infeksi menular seksual dan dapat meningkatkan risiko klamidia dan HIV, meskipun penyebabnya belum jelas (Affandi, 2014).

2) Cara pemberian

KB suntik 3 bulan ini dapat bekerja efektif dan dapat diberikan setiap saat selama siklus menstruasi masih berjalan dan tidak hamil. Kontrasepsi ini cukup efektif jika diberikan pada hari ke 5-7 pertama dalam siklus menstruasi. Jika KB suntik 3 bulan ini diberikan saat siklus menstruasi sudah melewati hari ke-7, atau sudah melakukan hubungan seks, maka diperlukan alat kontrasepsi tambahan seperti pil KB atau kondom guna menghindari kehamilan. Apabila KB suntik 3 bulan diberikan pada ibu post partum yang sedang menyusui, maka KB suntik ini diberikan pada minggu ke-6 setelah bersalin atau melahirkan, sedangkan KB suntik yang diberikan pada ibu post partum yang tidak menyusui maka KB suntik ini bisa diberikan sewaktu-waktu. Jika KB suntik ini diberikan pada yang mengalami keguguran atau mengalami prosedur aborsi, kontrasepsi ini dapat diberikan sewaktu waktu,

tetapi jika pemberian dilakukan pada hari ke-5 setelah keguguran atau setelah tindakan aborsi dan telah melakukan hubungan seks, maka perlu menggunakan kontrasepsi tambahan selama 7 hari (Matahari, Utami, & Sugiharti, 2018).

C. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

1. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke puskesmas untuk berkonsultasi tentang metode kontrasepsi. Ia dan suaminya baru menikah 6 bulan dan berencana menunda kehamilan selama 1 tahun. Mereka tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi hormonal atau yang invasif. Wanita tersebut memiliki siklus haid yang teratur setiap 28 hari.

Metode kontrasepsi alami apakah yang paling tepat disarankan kepada pasien tersebut?

A. Kalender dan pengamatan lendir serviks

- B. Pil kombinasi
- C. Implan subdermal
- D. Suntik DMPA
- E. IUD tembaga

2. Seorang ibu berusia 35 tahun dengan 3 anak datang untuk mendapatkan KB yang mudah digunakan, tidak memerlukan kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan, dan tidak mengganggu kesuburan setelah dihentikan. Metode kontrasepsi sederhana apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut?

A. Suntik DMPA

B. Kondom pria

- C. Implan
- D. IUD
- E. Tubektomi

3. Seorang Perempuan, umur 22 tahun, belum menikah, datang ke klinik setelah melakukan hubungan seksual yang tidak direncanakan. Ia ingin mencegah kehamilan dan bertanya mengenai pilihan kontrasepsi yang bisa digunakan secara langsung dan efektif.

Kontrasepsi modern apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut?

- A. Metode kalender
- B. Pil KB kombinasi

C. Pil kontrasepsi darurat

- D. IUD
- E. Implan

4. Seorang Perempuan, umur 30 tahun datang ke bidan 2 hari setelah hubungan seksual tanpa kondom. Ia tidak sedang menggunakan metode kontrasepsi apapun. Ia khawatir akan terjadi kehamilan dan meminta solusi. Tindakan kontrasepsi darurat apakah yang paling tepat diberikan oleh bidan pada kasus tersebut ?

- A. Memberikan pil kombinasi untuk 7 hari
- B. Menyarankan menunggu haid datang

C. Memberikan pil kontrasepsi darurat maksimal 72 jam setelah hubungan

- D. Melakukan pemasangan implan segera
- E. Memberikan suntik 3 bulanan

5. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB. Mengeluh ingin memakai kontrasepsi tetapi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis: mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 150/100 mmHg, N 90x/menit, P 24x/menit S 36,7 °C. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut?

- A. Pil kombinasi
- B. IUD hormonal
- C. Pil mini (progestin only pill)

D. IUD

- E. Implan

6. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0, postpartum 6 minggu, datang ke PMB untuk berkonsultasi tentang alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis: ibu belum mendapatkan haid, menyusui bayi secara teratur. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 110/80 mmhg, S 36, 5°C, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?

A. MAL

- B. Suhu Basal
- C. Spermisida
- D. Pantang berkala
- E. Senggama terputus

7. Seorang perempuan umur 20 tahun P0A0 datang PMB untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis: menikah 3 bulan yang lalu, belum ingin punya anak. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 110/80 mmhg, S 36, 3°C. terdapat kutil di daerah labia. Apakah metode kontrasepsi yang tepat untuk kasus tersebut?
- Kondom**
 - Kalender
 - Diafragma
 - Suhu basal
 - Senggama terputus
8. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0, postpartum 6 minggu, datang ke TPMB untuk berkonsultasi tentang alat kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis: ibu belum mendapatkan haid, menyusui bayi secara teratur. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 110/80 mmhg, S 36, 5°C, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
- MAL**
 - Suhu Basal
 - Spermisida
 - Pantang berkala
 - Senggama terputus
9. Seorang perempuan umur 35 tahun P3A1 datang ke TPMB ibu mengatakan ingin berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi, ingin menggunakan KB jangka 165iwayat. Hasil anamnesis : ibu mempunyai 165iwayat Anemia, dan menolak sterilisasi. Hasil Pemeriksaan : Hasil Pemeriksaan: KU baik, TD 120/80 mmhg, Nadi 86 x/menit, P 24 x/menit, Suhu 37,8 °C. Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
- Pil kombinasi
 - IUD hormonal
 - Pil mini (progestin only pill)
 - IUD
 - Implan**
10. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke RS dengan keluhan lupa minum pil 2 hari. Hasil anamnesis: anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan, ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 110/70 mmHg, N 80x/menit, P 24x/menit, S 36,8 0C,

tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut?

- A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal
- B. Ganti cara kontrasepsi
- C. **Minum 2 pil sekaligus**
- D. Berhenti minum pil
- E. Minum pil kondar

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. B
- 3. C
- 4. C
- 5. D
- 6. A
- 7. A
- 8. A
- 9. E
- 10. C

D. Rangkuman Materi

Pelayanan kontrasepsi merupakan bagian penting dari upaya kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga jarak kehamilan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kontrasepsi dapat dibedakan menjadi beberapa metode, yaitu metode alami, sederhana, modern, dan kontrasepsi darurat.

Metode kontrasepsi alami melibatkan pengamatan terhadap siklus menstruasi, suhu basal tubuh, dan lendir serviks tanpa bantuan alat atau hormon. Metode ini cocok bagi pasangan yang ingin menghindari bahan kimia, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan dan pemahaman pengguna.

Metode sederhana, seperti kondom dan spermisida, mudah digunakan dan dapat diakses tanpa resep medis. Kondom juga memberikan perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Metode ini cocok untuk penggunaan jangka pendek dan situasional.

Metode kontrasepsi modern mencakup pil, suntikan, implan, IUD, dan sterilisasi. Metode ini menawarkan efektivitas tinggi dalam jangka menengah hingga panjang, namun beberapa di antaranya memerlukan pelayanan kesehatan profesional untuk pemasangan dan pemantauan efek samping. Kontrasepsi darurat

digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan atau ketika metode reguler gagal, seperti lupa minum pil atau kondom bocor. Umumnya berupa pil yang mengandung hormon tertentu dan harus digunakan dalam waktu maksimal 72–120 jam setelah hubungan seksual.

Pelayanan kontrasepsi pasca aborsi sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan di masa depan. Metode yang umum digunakan dalam situasi ini meliputi kondom, pil kontrasepsi, dan suntik hormonal. Pelayanan harus diberikan segera setelah aborsi dilakukan, disertai konseling yang sensitif terhadap kondisi emosional dan kesehatan klien.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan kontrasepsi yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi individu, dengan tetap menjunjung tinggi hak reproduksi dan prinsip pelayanan yang beretika.

E. Glosarium

Kontrasepsi	: Cara atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan.
Metode Alami	: Metode kontrasepsi tanpa alat atau obat, berdasarkan pengamatan masa subur dan tanda-tanda fisiologis tubuh wanita.
Metode Sederhana	: Kontrasepsi yang menggunakan alat penghalang seperti kondom atau diafragma untuk mencegah pertemuan sperma dan ovum.
Metode Modern	: Metode kontrasepsi yang menggunakan teknologi medis, baik hormonal seperti pil, suntikan, implan; maupun non-hormonal seperti IUD dan sterilisasi.
Kontrasepsi Darurat	: Metode yang digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan untuk mencegah kehamilan, seperti pil darurat atau IUD pasca-koitus.
IUD	: (Intrauterine Device) Alat kontrasepsi kecil yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan.
Sterilisasi	: Prosedur permanen untuk mencegah kehamilan, seperti tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria.
Spermisida	: Zat kimia yang membunuh sperma, digunakan bersamaan dengan metode penghalang.
Ovulasi	: Proses pelepasan sel telur dari ovarium yang terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi.

- Efektivitas Kontrasepsi** : Kemampuan suatu metode untuk mencegah kehamilan secara konsisten jika digunakan dengan benar
- Kondom** : Alat kontrasepsi penghalang berbahan lateks yang digunakan untuk mencegah masuknya sperma ke dalam Rahim
- Pil Kontrasepsi** : Obat oral yang mengandung hormon estrogen dan/atau progestin yang mengatur ovulasi dan mencegah kehamilan.
- Suntikan Kontrasepsi** : Metode hormonal yang diberikan melalui injeksi, biasanya setiap 1 atau 3 bulan untuk mencegah ovulasi.
- Konseling Kontrasepsi** : Proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan klien untuk membantu memilih metode kontrasepsi yang sesuai kebutuhan, kondisi, dan preferensinya.

F. Daftar Pustaka

- Affandi, Biran. (2016). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Amalia, Merlly . 2017. Pelayanan Keluarga Berencana . Cirebon : LovRinz Publishing
- BKKBN. (2022). Pedoman Teknis Pelayanan Kontrasepsi Bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Corniawati, I., 2017. HAMBATAN SUAMI ISTRI DALAM MENJALANKAN KELUARGA BERENCANA METODE OVULASI BILLINGS. MMJ (Mahakam Midwifery Journal), 1(1), pp.55-75.
- Ernawati, Susanti, Ida Prijatni, Freya Nazera Iskandar, Nurul Jannatul Wahidah, Amrina Nur Rohmah, ... Fistaqul Isnaini. (2022). Perkembangan metode kontrasepsi masa kini. Rena Cipta Mandiri.
- Harni, Ari Julisa & Anita. (2017). Perbedaan Lama Waktu Kembali Hamil pada KB Suntik 1 Bulan dengan KB Suntik 3 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Daya Murni Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Jurnal Kesehatan 8(3), 429-434
- Jalilah, Nurul Hidayatun, Rully prapitasari . 2020 . Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana . Indramayu : Penerbit Adab

- Kusmiyati, Y. 2010. Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan. Edisi 6. Yogyakarta : Fitramaya
- Manuaba, I.B.G. (2019). Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan. Edisi Revisi. Jakarta: EGC.
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. (2018). Buku ajar keluarga berencana dan kontrasepsi. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu group.
- Myles, M.F. (2020). Myles Textbook for Midwives. 17th Edition. Edinburgh: Elsevier.
- Prawirohardjo, S. (2019). Pelayanan Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawita, A. A., & Gulo, A. S. (2019). Hubungan penggunaan kontrasepsi 3 bulan dengan kenaikan berat badan ibu di klinik Linez kota Gunungsitoli. Jurnal bidan komunitas, 2(3), 153 - 159.
- Purwoastuti, E., & Walyani, E. S. (2015). Panduan Materi: Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Saifuddin, P. dr. A. B. (2012). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (S. O. (K) Prof. Dr. dr. Biran Affandi, S. O. dr. Moh. Baharuddin, & S. P. Bd. Soekemi Soekir (eds.); 2nd ed.). Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Setyorini, C., & Lieskusumastuti, A. D. (2020). Lama penggunaan KB suntik 3 bulan dengan kejadian spotting dan amenorrhea di PMB Darmiat Ngemplak Boyolali. Jurnal kebidanan Indonesia, 11(3), 124 - 133.
- Sirait, Lenny Irmawaty. 2021. Buku ajar asuhan keluarga berencana pelayanan alat kontrasepsi. Sumbar Insan Cendekian Mandiri
- Susilowati, E. (2012). KB Suntik 3 (tiga) bulan dengan efek samping gangguan haid dan penanganannya. Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. L, no. 126, 33 - 45.
- Varney, H. et al. (2018). Varney's Midwifery. 6th Edition. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2007). Buku ajar asuhan kebidanan. Jakarta: EGC.

- WHO. (2018). Family Planning: A Global Handbook for Providers. Geneva: World Health Organization
- Wiknjosastro, H. (2020). Ilmu Kebidanan. Edisi ke-5. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Wilopo, Siswanto Agus. (2015). Keluarga Berencana: Buku Pedoman Global Untuk Pemberi Layanan. Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM.
- World Health Organization (WHO). (2018). Family planning: A global handbook for providers. Geneva: World Health Organization.
- Yulizawati, Iryani, D., Sinta B, L. E., & Ayunda, I. A. (2019). ASUHAN KEBIDANAN KELUARGA BERENCANA. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Machfudloh, S. SiT., MH. Kes., M. Keb. Lahir di Demak, 08 Januari 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Karya Husada Semarang (UNKAHA) tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Hukum Kesehatan pada Universitas Soegijapranata Semarang dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Aisyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2010 di Akademi Kebidanan Soko tunggal Semarang dan 2010-2025 (sekarang) di Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat ini penulis bekerja di Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengampu mata kuliah Etika dan hukum profesi kebidanan, Nifas dan Kespro dan KB. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan fasilitator Bimbingan calon pengantin bidang kesehatan di wilayah Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui email: machfudloh@unissula.ac.id.

Lely Khulafa'ur R, S.ST., M.Kes. Lahir di Nganjuk, 4 Maret 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang pada Program Studi Kebidanan, Universitas Padjadjaran tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006-2024 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, kemudian Pada Bulan Mei tahun 2024 mulai bekerja di Universitas Strada Indonesia Kota Kediri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku ajar dan modul, publikasi, seminar, riset dan pengabdian kepada masyarakat di Wilayah Kota Kediri. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lelykhulafaurr@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Hardiningsih, SST., M.Kes Lahir di Surakarta, 7 Januari 1987. Penulis menempuh pendidikan DIV Kebidanan di Fakultas Kedokteran UNS lulus tahun 2009 dan melanjutkan studi S2 Magister Kedokteran Keluarga di UNS lulus tahun 2012. Penulis menjadi dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Vokasi UNS sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional terkait kesehatan reproduksi diantaranya tentang kesehatan reproduksi remaja seperti anemia pada remaja, pencegahan stunting sejak usia remaja dan gizi pada remaja serta kesehatan reproduksi wanita. Selain itu penulis telah menulis beberapa buku ajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hardiningsih@staff.uns.ac.id



Asridawati Akib, SST, M.Keb. lahir di Citta, 9 Februari 1988. Merupakan Dosen Tetap Yayasan pada Prodi D3 Kebidanan Politeknik Sandi Karsa Makassar. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menempuh pendidikan Diploma Tiga Kebidanan di Akademi Kebidanan Sandi Karsa dan lulus Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik lulus Tahun 2012 di Stikes Mega Reski Makassar. Kemudian penulis melanjutkan S2 Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 2017.

PROFIL PENULIS



Dhiah Dwi Kusumawati, S.ST., Bdn., MPH. Lahir di Cilacap, 08 Desember 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap lulus tahun 2007. Jenjang DIV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu Dan Anak pada Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2015. Melanjutkan Profesi Kebidanan Di Universitas Al-Irsyad Cilacap lulus pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai asisten dosen di STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. Saat ini penulis bekerja di Universitas Al-Irsyad Cilacap mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan Dan Perencanaan KB, Asuhan Kebidanan Pra Nikah Dan Pra Konsepsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif di organisasi IBI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dhiahdwi@gmail.com

Motto: *Khoiru jaliisin fii az zamaani kitaabun. (Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku)*



Bdn. Nurul Lidya, SST, M.Kes. Menyelesaikan pendidikan D III di Stikes MH.Thamrin tahun 2008, Menyelesaikan Pendidikan D IV di Universitas Padjajaran tahun 2010, Menyelesaikan Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat dengan minat Kesehatan Reproduksi di Universitas Respati Indonesia tahun 2016, Menyelesaikan Pendidikan Profesi Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2023. Sejak tahun 2010 Penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini Penulis merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Penulis juga aktif dalam penerbitan Buku Ajar, Bookchapter, Buku Referensi, Monograf serta pembuatan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email nurullidya03@gmail.com.

"Bidan bukan hanya profesi, tapi panggilan jiwa yang dimulai dari Ilmu yang Kuat dan Jiwa yang Tulus"

SINOPSIS BUKU

Buku ajar "KB dan Pelayanan" hadir sebagai referensi penting bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang ingin memahami secara mendalam konsep keluarga berencana (KB) serta pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif dan berkualitas. KB merupakan salah satu aspek krusial dalam program pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Buku ini disusun dengan pendekatan integratif, mencakup berbagai aspek penting dalam praktik KB seperti pengenalan konsep dasar keluarga berencana, penjelasan berbagai metode kontrasepsi modern maupun tradisional, prinsip-prinsip konseling KB yang efektif, serta aspek etika dan hukum dalam pelaksanaannya. Pembahasan yang sistematis dan praktis dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, serta contoh kasus yang relevan dan representatif, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan menerapkan ilmu yang dipelajari.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi dalam implementasi program KB, termasuk hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang kerap muncul dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis tetapi juga kemampuan praktis dalam menghadapi berbagai situasi nyata.

Dengan kehadiran buku ini, diharapkan pembaca dapat menjadi tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB secara profesional, humanis, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Buku ajar "KB dan Pelayanan" adalah kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Buku ajar "KB dan Pelayanan" hadir sebagai referensi penting bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum yang ingin memahami secara mendalam konsep keluarga berencana (KB) serta pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif dan berkualitas. KB merupakan salah satu aspek krusial dalam program pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Buku ini disusun dengan pendekatan integratif, mencakup berbagai aspek penting dalam praktik KB seperti pengenalan konsep dasar keluarga berencana, penjelasan berbagai metode kontrasepsi modern maupun tradisional, prinsip-prinsip konseling KB yang efektif, serta aspek etika dan hukum dalam pelaksanaannya. Pembahasan yang sistematis dan praktis dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, serta contoh kasus yang relevan dan representatif, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan menerapkan ilmu yang dipelajari.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi dalam implementasi program KB, termasuk hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang kerap muncul dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, pembaca tidak hanya dibekali dengan pengetahuan teoritis tetapi juga kemampuan praktis dalam menghadapi berbagai situasi nyata. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan pembaca dapat menjadi tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB secara profesional, humanis, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Buku ajar "KB dan Pelayanan" adalah kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-623-89992-4-8



9

786238

999248